

Buku Referensi
**KESEHATAN REPRODUKSI
PEREMPUAN**
Sepanjang Daur Kehidupan

Sri Rintani Sikumbang • Atika Kurnia Sari • Yarnita • Erma Puspita Sari
Rizki Amalia • Nor Eka Noviani • Arista Kusuma Wardani



BUKU REFERENSI

KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

SEPANJANG DAUR KEHIDUPAN

Penulis:

Bd. Sri Rintani Sikumbang, SST., M.Kes.

Atika Kurnia Sari, SST., M.Kes.

Yarnita, S.ST., M.K.M.

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.

Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien.

Arista Kusuma Wardani, S.ST., M.Keb.



Buku Referensi Kesehatan Reproduksi Perempuan Sepanjang Daur Kehidupan

Penulis:

Bd. Sri Rintani Sikumbang, SST., M.Kes.

Atika Kurnia Sari, SST., M.Kes.

Yarnita, S.ST., M.K.M.

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.

Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien.

Arista Kusuma Wardani, S.ST., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-27-5

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku referensi yang berjudul Kesehatan Reproduksi Perempuan Sepanjang Daur Kehidupan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu kesehatan, khususnya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi perempuan dari masa anak-anak, remaja, dewasa, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa menopause dan lanjut usia.

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada fungsi biologis organ reproduksi, tetapi juga mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, spiritual, serta hak-hak kesehatan reproduksi. Setiap tahap kehidupan perempuan memiliki karakteristik, kebutuhan, risiko, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh agar upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan perempuan.

Buku referensi ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai konsep dasar kesehatan reproduksi perempuan, perubahan fisiologis sepanjang daur kehidupan, kesehatan reproduksi pada masa remaja, perencanaan keluarga, kehamilan dan persalinan, kesehatan ibu pada masa nifas, kesehatan seksual, pencegahan infeksi menular seksual, gangguan sistem reproduksi, hingga isu kesehatan reproduksi pada masa menopause. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya edukasi, deteksi dini, pemberdayaan perempuan, serta pelayanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan berorientasi pada kebutuhan individu.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, komunikasi yang efektif, serta penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan. Pelayanan kesehatan reproduksi yang baik harus mampu memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh informasi yang benar, membuat keputusan yang tepat, serta mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa kesehatan, dosen, bidan, perawat, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan perempuan. Melalui penyajian yang komprehensif dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat mendukung peningkatan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan secara holistik dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi, keluasan pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku referensi Kesehatan Reproduksi Perempuan Sepanjang Daur Kehidupan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Semoga buku ini juga dapat menjadi salah satu rujukan yang mendukung terwujudnya perempuan yang sehat, berdaya, dan mampu menjalani setiap tahap kehidupannya dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
--------------	-----

DAFTAR ISI.....	v
-----------------	---

BAB I KONSEP REPRODUCTIVE LIFE CYCLE 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian <i>Reproductive Life Cycle</i>	2
C. Pendekatan <i>Life Cycle</i> Dalam Kesehatan Reproduksi.....	3
D. Faktor Yang Memengaruhi <i>Reproductive Life Cycle</i>	6
E. Tahapan <i>Reproductive Lefe Cycle</i> Pada Perempuan	10
F. Permasalahan Kesehatan Reproduksi Pada Setiap Tahap Daur Kehidupan	13
G. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Pendekatan Reproductive Life Cycle	15
H. Penutup	17
Referensi.....	18

BAB II REMAJA DAN KESEHATAN REPRODUKSI21

A. Pendahuluan.....	21
B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja	21
C. Pemahaman Mengenai anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Manusia	23
D. Perubahan Fisik dan Hormonal Pada Masa Purberitas	25
E. Pencegahan Penyakit Menular Seksual	27
F. Mencegah Kehamilan Yang Tidak direncanakan	35
G. Pengembangan Sikap Dan Perilaku Bertanggung Jawab	38
H. Penutup	40
Referensi.....	42

BAB III KEHAMILAN DAN PERSALINAN.....43

A. Pendahuluan.....	43
B. Perubahan Sistem Reproduksi	43
C. Antenatal (ANC).....	45
D. Tanda dan Gejala Kehamilan	47
E. Usia dan Tahapan Perkembangan Janin	49

F. Seksualitas Selama Hamil	50
G. Tanda-Tanda dan Tahapan Persalinan.....	51
H. Asuhan Sayang Ibu Dalam Proses Persalinan.....	53
I. Persiapan Persalinan.....	54
J. Masalah Kesehatan Reproduksi Selama Hamil	55
K. Masalah Kesehatan Reproduksi Selama Persalinan	56
L. Peran Ibu Dalam Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi.....	57
M. Penutup	59
Referensi.....	59
 BAB IV MASA NIFAS DAN LAKTASI.....	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Konsep Masa Nifas dalam Kesehatan Reproduksi.....	64
C. Adaptasi Fisiologis pada Masa Nifas	66
D. Adaptasi Psikologis dan Sosial Postpartum	69
E. Fisiologi dan Regulasi Laktasi.....	71
F. Komposisi dan Tahapan Produksi Air Susu Ibu (ASI).....	73
G. Manfaat Laktasi bagi Ibu dan Bayi.....	75
H. Permasalahan Klinis Masa Nifas dan Laktasi	78
I. Perspektif Evidence-Based Midwifery dalam Pelayanan Postpartum.....	81
J. Penutup	83
Referensi.....	84
 BAB V KESEHATAN REPRODUKSI USIA SUBUR	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Definisi Kesehatan Reproduksi Usia Subur.....	89
C. Karakteristik Perempuan Usia Subur	91
D. Masalah Kesehatan Reproduksi pada Usia Subur.....	93
E. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur	96
F. Upaya Menjaga Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur	98
G. Keluarga Berencana pada Usia Subur	101
H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur	103
I. Tantangan Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur di Indonesia	106
J. Penutup	108

Referensi.....	109
BAB VI PERIMENOPAUSE DAN MENOPAUSE.....	115
A. Pendahuluan.....	115
B. Definisi Perimenopause, Menopause dan Post Menopause.....	116
C. Perubahan terkait dengan Menopause	119
D. Menopasue dan Kualitas Hidup di Masa Mendatang	121
E. Manajemen dan Penatalaksanaan dalam Menopause.....	124
F. Menopause, Ekonomi dan Ketahanan Pangan	125
G. Tantangan Kesehatan dan Keluarga berkaitan dengan menopause	127
H. Menopause dan Kesehatan Mental	128
I. Penutup	129
Referensi.....	130
BAB VII MODEL PELAYANAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN	135
A. Pendahuluan.....	135
B. Filosofi dan Prinsip Dasar Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan	135
C. Dimensi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan	137
D. Model Praktik Mandiri dan Kolaboratif	138
E. Implementasi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan pada Masa Kehamilan	139
F. Implementasi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan pada Masa Nifas dan Menyusui.....	140
G. Implementasi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan pada Masa Nifas dan Menyusui.....	140
H. Peran Teknologi dalam Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan	141
I. Tantangan dan Strategi Pengembangan Model Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan.....	142
J. Penutup	143
Referensi.....	144
PROFIL PENULIS	147

BAB I

KONSEP REPRODUCTIVE LIFE CYCLE

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan perempuan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan fungsi organ reproduksi semata, tetapi mencakup kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi sepanjang kehidupan manusia. Dengan demikian, kesehatan reproduksi perempuan perlu dipahami sebagai bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan yang berlangsung sejak sebelum kelahiran hingga usia lanjut (Prawirohardjo, 2018).

Perempuan mengalami berbagai tahapan biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, usia reproduksi, masa kehamilan dan persalinan, hingga masa menopause dan lanjut usia. Setiap tahapan kehidupan tersebut memiliki karakteristik fisiologis, psikologis, dan sosial yang berbeda sehingga membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan yang sesuai. Pendekatan ini dikenal sebagai ***reproductive life cycle*** atau siklus kehidupan reproduksi perempuan, yaitu suatu konsep yang memandang kesehatan reproduksi sebagai proses yang berlangsung secara kontinu sepanjang daur kehidupan (Bobak, Lowdermilk, & Jensen, 2019).

Kesehatan reproduksi perempuan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas hidup. Kondisi kesehatan reproduksi yang baik memungkinkan perempuan menjalani fungsi reproduksi secara aman, merencanakan kehamilan secara sehat, serta terhindar dari berbagai risiko penyakit maupun komplikasi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial. Sebaliknya, masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi saluran reproduksi, komplikasi kehamilan, atau kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dapat menurunkan kualitas hidup perempuan dan berdampak pada kesehatan keluarga serta generasi yang akan datang (Widiasih & Setyawati, 2018). Oleh karena itu, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam kesehatan reproduksi menjadi sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan.

Dalam penerapan konsep siklus kehidupan reproduksi, peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting. Tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dan

dokter memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan setiap tahap kehidupan perempuan. Pada masa remaja, tenaga kesehatan berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi serta pencegahan perilaku berisiko. Pada masa reproduksi, pelayanan difokuskan pada kesehatan ibu, keluarga berencana, serta pencegahan penyakit reproduksi. Sementara itu, pada masa menopause dan usia lanjut, tenaga kesehatan berperan dalam memberikan edukasi serta penatalaksanaan masalah kesehatan yang berkaitan dengan perubahan hormonal dan penuaan sistem reproduksi (Bobak et al., 2019).

Dengan memahami konsep ***reproductive life cycle***, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan di setiap tahap kehidupan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan serta mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep siklus kehidupan reproduksi menjadi landasan penting dalam pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupan.

B. Pengertian *Reproductive Life Cycle*

Reproductive life cycle atau siklus kehidupan reproduksi merupakan konsep yang menggambarkan tahapan perkembangan fungsi reproduksi manusia sepanjang rentang kehidupan, khususnya pada perempuan. Konsep ini menekankan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan masa kehamilan atau persalinan saja, tetapi dimulai sejak masa sebelum pubertas hingga masa menopause dan lanjut usia (WHO, 2018). Pendekatan ini penting dalam ilmu kesehatan reproduksi karena setiap fase kehidupan memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda serta risiko yang khas.

Menurut ***World Health Organization***, siklus kehidupan reproduksi adalah rangkaian fase biologis dan psikososial yang dialami individu yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, mulai dari masa kanak-kanak, pubertas, masa reproduksi, hingga menopause (WHO, 2018). Pada perempuan, siklus ini mencakup berbagai perubahan hormonal, anatomi, dan fisiologis yang mempengaruhi kemampuan reproduksi serta kesehatan secara keseluruhan.

Secara umum, *reproductive life cycle* pada perempuan dibagi menjadi beberapa tahap utama, yaitu masa bayi dan anak, masa remaja atau pubertas, masa reproduksi (usia subur), masa kehamilan dan persalinan, serta masa perimenopause dan menopause (Cunningham et al., 2022). Pada masa anak dan remaja terjadi proses pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan pubertas dan

menarche. Selanjutnya pada masa reproduksi, perempuan memiliki kemampuan untuk mengalami ovulasi, menstruasi secara teratur, serta potensi untuk hamil dan melahirkan. Pada tahap akhir, yaitu menopause, terjadi penurunan fungsi ovarium yang menyebabkan berhentinya siklus menstruasi secara permanen.

Pendekatan siklus kehidupan reproduksi juga menekankan pentingnya intervensi kesehatan yang berkelanjutan pada setiap fase kehidupan. Hal ini karena kondisi kesehatan pada satu tahap kehidupan dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada tahap berikutnya. Sebagai contoh, status gizi pada masa remaja dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada masa kehamilan di kemudian hari (Glasier et al., 2017). Oleh karena itu, upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan kesehatan reproduksi perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, *reproductive life cycle* dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan perjalanan fungsi reproduksi manusia sepanjang kehidupan. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan, dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang holistik, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap kehidupan perempuan.

C. Pendekatan *Life Cycle* Dalam Kesehatan Reproduksi

1. Konsep *Life Cycle Approach*

Pendekatan *life cycle approach* atau pendekatan daur kehidupan merupakan konsep yang melihat kesehatan individu sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan sejak sebelum lahir hingga usia lanjut. Dalam konteks kesehatan reproduksi perempuan, pendekatan ini menekankan bahwa kebutuhan kesehatan reproduksi tidak hanya terjadi pada masa kehamilan atau persalinan saja, tetapi dimulai sejak masa remaja, masa reproduksi, hingga masa menopause dan lanjut usia. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus dirancang secara berkelanjutan untuk menjamin kesehatan perempuan sepanjang kehidupannya (WHO, 2017).

Pendekatan daur kehidupan menempatkan perempuan sebagai individu yang mengalami berbagai tahap perkembangan biologis dan psikososial yang berbeda. Setiap tahap memiliki risiko kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang spesifik. Misalnya pada masa remaja diperlukan edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, serta promosi perilaku hidup sehat. Pada masa reproduksi diperlukan pelayanan prakonsepsi, antenatal care, persalinan aman, pelayanan nifas, serta keluarga berencana. Sedangkan pada masa menopause

diperlukan perhatian terhadap kesehatan hormonal, penyakit degeneratif, dan kualitas hidup perempuan (Berek & Novak, 2020).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam setiap tahap kehidupan. Upaya promotif bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, sedangkan upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi seperti anemia, infeksi menular seksual, komplikasi kehamilan, serta kanker reproduksi. Dengan demikian, pendekatan *life cycle* tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh.

Selain itu, pendekatan daur kehidupan memberikan kerangka kerja bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Bidan tidak hanya berperan dalam proses persalinan, tetapi juga dalam edukasi kesehatan reproduksi sejak masa remaja, pelayanan prakonsepsi, pemantauan kehamilan, hingga pelayanan keluarga berencana. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan perempuan serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

2. Konsep *Continuum of Care*

Konsep *continuum of care* atau pelayanan berkesinambungan merupakan bagian penting dari pendekatan daur kehidupan dalam kesehatan reproduksi. *Continuum of care* menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara berkelanjutan dan terintegrasi sepanjang siklus kehidupan perempuan serta mencakup berbagai tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari rumah tangga, komunitas, hingga fasilitas kesehatan rujukan.

Dalam pelayanan kebidanan, konsep ini dikenal sebagai *continuity of care*, yaitu pemberian asuhan kebidanan secara komprehensif mulai dari masa kehamilan, persalinan, masa nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana. Asuhan yang berkesinambungan ini bertujuan untuk memantau kondisi ibu dan bayi secara menyeluruh sehingga komplikasi dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin (Andriyani & Maftuchah, 2015).

Pendekatan *continuum of care* juga mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi waktu dan dimensi tempat pelayanan. Dimensi waktu meliputi pelayanan kesehatan dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa anak dan remaja. Sementara itu, dimensi tempat mencakup pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah, masyarakat, puskesmas, rumah sakit, serta sistem rujukan yang efektif. Pelayanan yang terintegrasi pada berbagai tingkat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi (Paunno & Siahaya, 2020).

Penerapan *continuum of care* juga menekankan pentingnya koordinasi antar tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kolaborasi antara bidan, dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhannya. Dengan adanya pelayanan yang berkesinambungan, risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan dapat diminimalkan.

3. Integrasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Integrasi pelayanan kesehatan reproduksi merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan perempuan. Integrasi ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai jenis pelayanan kesehatan reproduksi sehingga dapat diberikan secara komprehensif dan efisien dalam satu sistem pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan reproduksi yang terintegrasi meliputi berbagai program, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan infeksi menular seksual, kesehatan remaja, serta pelayanan kesehatan pada masa menopause. Integrasi pelayanan ini memungkinkan perempuan memperoleh berbagai layanan kesehatan secara bersamaan tanpa harus mengakses fasilitas kesehatan yang berbeda-beda.

Pendekatan integrasi pelayanan kesehatan reproduksi juga mendukung konsep promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan reproduksi. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada perempuan dan keluarga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan serta perilaku kesehatan masyarakat. Edukasi yang tepat dapat membantu perempuan memahami risiko kesehatan reproduksi dan mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan dirinya (Lenny et al., 2024).

Selain itu, integrasi pelayanan kesehatan reproduksi juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Dengan menggabungkan berbagai program pelayanan kesehatan dalam satu sistem, fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan menyeluruh. Integrasi ini juga dapat memperkuat sistem rujukan sehingga pasien yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat segera mendapatkan penanganan yang tepat.

4. Manfaat Pendekatan Daur Kehidupan dalam Pelayanan Kebidanan

Pendekatan daur kehidupan memberikan berbagai manfaat dalam pelayanan kebidanan, baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi perempuan sebagai penerima layanan. Salah satu manfaat utama dari pendekatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.

Dengan menggunakan pendekatan *life cycle*, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan berfokus pada kebutuhan perempuan di setiap tahap kehidupan. Pelayanan tidak hanya terbatas pada masa kehamilan dan persalinan, tetapi juga mencakup masa sebelum kehamilan, masa nifas, serta kesehatan reproduksi jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan reproduksi sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat sejak awal.

Selain itu, pendekatan daur kehidupan juga dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan terintegrasi memungkinkan pemantauan kondisi ibu dan bayi secara lebih optimal. Dengan demikian, komplikasi kehamilan, persalinan, maupun masa nifas dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Manfaat lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi. Melalui edukasi yang diberikan sejak masa remaja, perempuan dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, merencanakan kehamilan dengan baik, serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang.

Dengan demikian, pendekatan *life cycle* dan *continuum of care* merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan perempuan sepanjang daur kehidupannya.

D. Faktor Yang Memengaruhi *Reproductive Life Cycle*

Pendekatan kesehatan reproduksi modern menekankan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik semata, tetapi juga oleh kondisi psikologis, sosial, budaya, serta lingkungan tempat individu hidup. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *reproductive life cycle* sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan (Prawirohardjo, 2018).

1. Faktor Biologis

Faktor biologis merupakan faktor dasar yang secara langsung berkaitan dengan fungsi organ reproduksi dan kondisi fisik perempuan. Faktor ini mencakup struktur anatomi organ reproduksi, kondisi genetik, status gizi, usia, serta adanya penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kondisi biologis

yang optimal akan mendukung proses reproduksi yang sehat, mulai dari pubertas, kehamilan, persalinan, hingga menopause.

Sebaliknya, gangguan biologis seperti kelainan kongenital pada organ reproduksi, penyakit menular seksual, anemia, serta gangguan gizi dapat memengaruhi fungsi reproduksi perempuan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kesuburan, kesehatan kehamilan, hingga risiko komplikasi selama persalinan. Faktor biologis juga berhubungan erat dengan proses perkembangan seksual dan pematangan organ reproduksi pada masa pubertas (Kusmiran, 2014).

Selain itu, faktor biologis juga meliputi kondisi kesehatan secara umum yang mempengaruhi kemampuan reproduksi. Misalnya, penyakit kronis, infeksi pada organ reproduksi, serta kelainan hormonal yang dapat mengganggu proses ovulasi dan siklus menstruasi. Kondisi biologis yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti infertilitas, gangguan menstruasi, maupun komplikasi kehamilan.

2. Faktor Hormonal

Faktor hormonal merupakan faktor fisiologis yang berperan dalam mengatur berbagai fungsi reproduksi perempuan. Hormon reproduksi utama seperti estrogen, progesteron, *luteinizing hormone* (LH), dan *follicle stimulating hormone* (FSH) memiliki peran penting dalam mengatur siklus menstruasi, proses ovulasi, serta kesiapan tubuh untuk kehamilan.

Ketidakseimbangan hormon dapat mempengaruhi berbagai tahapan dalam *reproductive life cycle*. Misalnya, gangguan hormon pada masa pubertas dapat menyebabkan keterlambatan menarche atau gangguan perkembangan seksual sekunder. Pada usia reproduktif, ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan menstruasi seperti amenorea, oligomenorea, atau sindrom ovarium polikistik (PCOS). Sementara itu, perubahan hormon pada masa menopause akan menyebabkan berhentinya siklus menstruasi secara permanen.

Selain itu, perubahan hormon juga mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional perempuan. Fluktuasi hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi mood, tingkat stres, serta keseimbangan emosional perempuan. Oleh karena itu, faktor hormonal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesehatan reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupannya (Prawirohardjo, 2018).

3. Faktor Psikologis

Faktor psikologis juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, serta pengalaman traumatis dapat mempengaruhi fungsi reproduksi secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, stres kronis dapat

mempengaruhi keseimbangan hormon reproduksi sehingga menyebabkan gangguan siklus menstruasi atau kesulitan dalam proses ovulasi.

Selain itu, pengalaman psikologis seperti kekerasan seksual, konflik keluarga, atau tekanan sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi psikologis yang tidak stabil dapat berdampak pada perilaku kesehatan reproduksi, termasuk perilaku seksual berisiko serta kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi (Hasanah, 2016).

Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti rendahnya rasa percaya diri, depresi, atau tekanan emosional dapat mempengaruhi keputusan individu dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan reproduksi yang komprehensif perlu memperhatikan aspek psikologis selain aspek biologis (Sandy et al., 2025).

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi *reproductive life cycle* perempuan. Nilai-nilai budaya, norma sosial, kepercayaan masyarakat, serta sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku reproduksi dan pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Dalam beberapa masyarakat, masih terdapat praktik budaya atau kepercayaan tradisional yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Misalnya, mitos mengenai menstruasi, kepercayaan tentang jumlah anak, atau praktik perkawinan usia dini. Kepercayaan seperti “banyak anak banyak rezeki” masih ditemukan di beberapa daerah dan dapat mempengaruhi keputusan reproduksi keluarga (Hasanah, 2016; Handayani & Sholihah, 2023).

Selain itu, sistem budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat juga dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam kondisi tersebut, perempuan seringkali memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksinya sendiri (Handayani & Sholihah, 2023).

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi ekonomi keluarga dapat menentukan kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan, informasi kesehatan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kemiskinan seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi. Perempuan dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah

cenderung memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, nutrisi yang memadai, serta pendidikan kesehatan reproduksi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti anemia, kehamilan risiko tinggi, serta komplikasi persalinan.

Selain itu, faktor ekonomi juga berkaitan dengan tingkat pendidikan. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi serta lebih mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksinya (Sandy et al., 2025).

6. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berperan dalam mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Lingkungan yang dimaksud meliputi kondisi fisik, sosial, maupun lingkungan tempat tinggal. Kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti sanitasi yang buruk, polusi, atau paparan bahan kimia berbahaya dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi.

Paparan zat kimia tertentu seperti pestisida, logam berat, atau bahan kimia industri dapat mengganggu sistem endokrin dan berdampak pada fungsi reproduksi. Selain itu, kondisi lingkungan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi gender, serta ketidaksetaraan sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan.

Lingkungan sosial yang mendukung, seperti keluarga yang harmonis dan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan reproduksi, dapat membantu perempuan menjalani *reproductive life cycle* dengan lebih sehat dan aman.

7. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan faktor penting yang menentukan kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Akses yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup keterjangkauan biaya, kemudahan transportasi, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, serta penerimaan masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi (Prawirohardjo, 2018). Apabila layanan kesehatan mudah diakses oleh perempuan, maka berbagai kebutuhan kesehatan reproduksi dapat terpenuhi secara optimal.

Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan reproduksi. Hambatan seperti jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya pelayanan yang tinggi, kurangnya tenaga kesehatan, serta rendahnya pengetahuan masyarakat dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan, komplikasi kehamilan, serta tingginya angka

kematian ibu (Hasanah, 2016). Selain itu, perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan cenderung tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi.

Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesehatan perempuan sepanjang daur kehidupannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, serta peningkatan edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat (Handayani & Sholihah, 2023).

E. Tahapan *Reproductive Life Cycle* Pada Perempuan

Secara umum, tahapan *reproductive life cycle* perempuan meliputi masa prenatal, masa bayi dan anak, masa remaja, masa reproduksi atau usia subur, masa pramenopause, serta masa menopause dan pascamenopause.

1. Masa Janin (Prenatal)

Masa prenatal merupakan tahap awal perkembangan sistem reproduksi perempuan yang dimulai sejak berada di dalam kandungan. Pada fase ini terjadi pembentukan organ reproduksi internal seperti ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Proses diferensiasi seksual biasanya mulai terjadi pada trimester pertama kehamilan dan akan terus berkembang hingga menjelang kelahiran (Dewi & Megasari, 2022).

Sel telur atau oosit pada perempuan juga telah terbentuk sejak masa janin. Ovarium janin perempuan mengandung ratusan ribu folikel primordial yang akan menjadi cadangan sel telur sepanjang hidupnya. Jumlah ini tidak akan bertambah setelah lahir dan secara bertahap akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia (Wallace & Kelsey, 2011).

Selain proses perkembangan organ reproduksi, kondisi kesehatan ibu selama kehamilan memiliki pengaruh penting terhadap kesehatan reproduksi anak di masa depan. Faktor seperti status gizi ibu, paparan zat berbahaya, infeksi, serta kondisi kesehatan maternal dapat mempengaruhi pertumbuhan organ reproduksi janin dan kesehatan reproduksi anak ketika dewasa.

2. Masa Bayi dan Anak

Setelah lahir, sistem reproduksi perempuan telah terbentuk secara anatomis namun belum berkembang secara fungsional. Pada bayi perempuan yang lahir cukup bulan, organ reproduksi seperti ovarium, uterus, tuba falopi, dan vagina telah terbentuk dengan baik. Bahkan ovarium telah mengandung sekitar 750.000 sel telur yang belum matang (Dewi & Megasari, 2022).

Pada masa bayi, pengaruh hormon estrogen dari ibu masih dapat mempengaruhi tubuh bayi selama beberapa minggu pertama setelah kelahiran. Hal ini dapat menyebabkan pembesaran payudara sementara atau keluarnya cairan dari vagina bayi. Kondisi tersebut bersifat fisiologis dan akan menghilang dengan sendirinya.

Memasuki masa kanak-kanak, sistem reproduksi relatif tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena aktivitas hormon reproduksi masih rendah. Pada fase ini, perhatian terhadap nutrisi, kebersihan, serta kesehatan anak sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara optimal, termasuk perkembangan organ reproduksi.

3. Masa Remaja (Adolescence)

Masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan terjadinya pubertas. Pubertas adalah proses pematangan sistem reproduksi yang dipicu oleh aktivitas hormon gonadotropin dan hormon seks seperti estrogen (Dewi & Megasari, 2022).

Salah satu tanda utama pubertas pada perempuan adalah *menarche*, yaitu menstruasi pertama yang menandakan bahwa sistem reproduksi telah mulai berfungsi. Menarche biasanya terjadi pada usia sekitar 10–16 tahun dan dipengaruhi oleh faktor genetik, status gizi, serta kondisi kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Selain perubahan biologis, remaja juga mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut pubis, serta perubahan bentuk tubuh. Perubahan ini seringkali diikuti oleh perubahan psikologis seperti peningkatan emosi, pencarian identitas diri, serta ketertarikan terhadap lawan jenis.

Pada fase ini pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting agar remaja memiliki pengetahuan yang benar mengenai tubuhnya, proses reproduksi, serta perilaku yang sehat. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko berbagai masalah seperti kehamilan remaja, infeksi menular seksual, dan gangguan kesehatan reproduksi lainnya (Damayanti & Munawaroh, 2024).

4. Masa Reproduksi (Usia Subur)

Masa reproduksi merupakan fase ketika perempuan memiliki kemampuan biologis untuk hamil dan melahirkan anak. Masa ini biasanya berlangsung dari usia sekitar 15–49 tahun dan ditandai dengan siklus menstruasi yang teratur. Pada periode ini terjadi proses ovulasi secara berkala, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan apabila sel telur bertemu dengan sperma (Dewi & Megasari, 2022).

Dalam tahap ini, kesiapan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan kondisi biologis tetapi juga kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi untuk menjalani kehamilan dan membesarkan anak. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan reproduksi pada masa ini meliputi berbagai aspek seperti pelayanan pranikah, antenatal care, persalinan yang aman, serta pelayanan keluarga berencana.

Program keluarga berencana menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mengatur jarak kehamilan. Selain itu, perempuan usia subur juga perlu memperhatikan kesehatan reproduksi melalui pemeriksaan kesehatan rutin, deteksi dini kanker serviks dan payudara, serta penerapan perilaku hidup sehat (Widiasih & Setyawati, 2018).

5. Masa Premenopause

Masa premenopause merupakan periode transisi sebelum terjadinya menopause. Pada fase ini mulai terjadi perubahan hormon reproduksi, terutama penurunan hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Perubahan hormon tersebut menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan dapat disertai berbagai keluhan seperti hot flushes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, serta penurunan energi.

Selain perubahan fisik, perempuan pada masa premenopause juga dapat mengalami perubahan psikologis seperti kecemasan, mudah marah, atau perasaan tidak nyaman terhadap perubahan tubuhnya. Oleh karena itu, dukungan keluarga serta edukasi mengenai perubahan yang terjadi sangat penting agar perempuan dapat menghadapi fase ini dengan lebih baik.

6. Masa Menopause dan Pascamenopause

Menopause merupakan kondisi berhentinya menstruasi secara permanen akibat menurunnya fungsi ovarium dan produksi hormon estrogen. Umumnya menopause terjadi pada usia sekitar 45–55 tahun dan menandai berakhirnya kemampuan reproduksi perempuan (Siregar et al., 2024)

Pada masa menopause terjadi berbagai perubahan fisiologis seperti penurunan kepadatan tulang, perubahan metabolisme, serta peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, beberapa perempuan juga mengalami keluhan seperti hot flushes, kekeringan vagina, dan gangguan tidur.

Memasuki masa pascamenopause, fokus kesehatan reproduksi perempuan beralih pada upaya menjaga kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang. Hal ini meliputi pencegahan osteoporosis, pemeriksaan kesehatan rutin, serta penerapan gaya hidup sehat seperti aktivitas fisik teratur, konsumsi nutrisi seimbang, dan pengelolaan stres yang baik.

F. Permasalahan Kesehatan Reproduksi Pada Setiap Tahap Daur Kehidupan

Pemahaman mengenai masalah kesehatan reproduksi pada setiap tahap kehidupan sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan yang tepat (Kemenkes RI, 2020).

1. Permasalahan Kesehatan Reproduksi pada Masa Remaja

Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cepat. Pada masa ini terjadi proses pematangan organ reproduksi yang disebut pubertas. Namun, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi serta pengaruh lingkungan dapat menyebabkan remaja rentan mengalami berbagai masalah kesehatan reproduksi (Widyastuti et al., 2019).

a. Kehamilan Remaja

Kehamilan remaja merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehamilan pada usia remaja sering dikaitkan dengan pernikahan dini, kurangnya pendidikan seksual, serta perilaku seksual berisiko. Kehamilan pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan seperti anemia, preeklamsia, persalinan prematur, dan bayi berat lahir rendah (BBLR). Selain itu, kehamilan remaja juga berdampak pada aspek sosial seperti putus sekolah dan keterbatasan kesempatan ekonomi di masa depan (Thalita, 2020).

b. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi menular seksual (IMS) merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Contoh IMS antara lain gonore, sifilis, klamidia, dan HIV/AIDS. Remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap IMS karena rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi serta perilaku seksual yang tidak aman. Selain itu, pengaruh teman sebaya dan akses informasi yang tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko pada remaja (Anggraini, 2024).

c. Anemia pada Remaja Putri

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada remaja putri. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi akibat pola makan yang tidak seimbang serta meningkatnya kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Anemia pada remaja putri dapat berdampak pada kesehatan reproduksi di masa depan, seperti meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan (Khobibah et al., 2021). Selain itu, anemia juga dapat menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi belajar, serta menurunkan produktivitas remaja (Fitria & Astuti, 2023).

2. Permasalahan Kesehatan Reproduksi pada Usia Reproduksi

Usia reproduksi merupakan periode ketika perempuan memiliki kemampuan untuk hamil dan melahirkan, yaitu sekitar usia 15–49 tahun. Pada tahap ini, perempuan menghadapi berbagai tantangan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, serta penyakit pada sistem reproduksi (Bobak et al., 2017).

a. Komplikasi Kehamilan

Komplikasi kehamilan merupakan kondisi yang dapat mengancam kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Beberapa komplikasi yang sering terjadi antara lain preeklamsia, perdarahan antepartum, anemia pada kehamilan, serta infeksi selama kehamilan. Komplikasi tersebut dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan baik (Cunningham et al., 2018).

Faktor risiko terjadinya komplikasi kehamilan antara lain usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, status gizi yang buruk, penyakit kronis, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan maternal.

b. Infertilitas

Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama minimal satu tahun. Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan ovulasi, kelainan pada tuba falopi, endometriosis, serta faktor hormonal. Selain itu, faktor gaya hidup seperti merokok, obesitas, dan stres juga dapat mempengaruhi kesuburan perempuan (Berek & Novak, 2020).

Masalah infertilitas tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang mengalaminya.

c. Kanker Serviks

Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi **Human Papilloma Virus (HPV)** yang ditularkan melalui hubungan seksual. Faktor risiko kanker serviks antara lain hubungan seksual pada usia muda, memiliki banyak pasangan seksual, merokok, serta kurangnya pemeriksaan skrining seperti Pap smear atau IVA (Kemenkes RI, 2020). Kanker serviks sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi HPV, deteksi dini, serta perilaku seksual yang sehat.

3. Permasalahan Kesehatan Reproduksi pada Masa Menopause

Menopause merupakan fase dalam kehidupan perempuan yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium. Penurunan hormon estrogen pada masa menopause dapat menyebabkan berbagai perubahan fisiologis yang berdampak pada kesehatan perempuan (Lowdermilk et al., 2020).

a. Osteoporosis

Osteoporosis merupakan kondisi penurunan kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Pada perempuan menopause, risiko osteoporosis meningkat karena menurunnya kadar hormon estrogen yang berperan dalam menjaga kepadatan tulang. Faktor risiko lainnya meliputi kurangnya aktivitas fisik, kekurangan kalsium dan vitamin D, serta riwayat keluarga dengan osteoporosis

b. Penyakit Kardiovaskular

Selain osteoporosis, perempuan menopause juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan hipertensi. Penurunan hormon estrogen menyebabkan perubahan metabolisme lemak dan peningkatan kadar kolesterol dalam darah sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung (Berek & Novak, 2020). Oleh karena itu, perempuan pada masa menopause dianjurkan untuk menjalani gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

G. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Pendekatan Reproductive Life Cycle

Peran tenaga kesehatan tidak hanya terbatas pada pelayanan klinis, tetapi juga meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara terintegrasi. Dalam konteks kesehatan reproduksi, bidan berperan sebagai pemberi asuhan (*care provider*), pendidik kesehatan, konselor, serta advokat bagi perempuan dan keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka (Walyani & Purwoastuti, 2018).

1. Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Dalam praktiknya, bidan memberikan asuhan kebidanan yang berfokus pada perempuan (*woman-centered care*) dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, deteksi dini komplikasi, pemberian edukasi kesehatan reproduksi, serta rujukan apabila ditemukan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut (Varney et al., 2015).

Penelitian menunjukkan bahwa bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi melalui berbagai program kesehatan di tingkat komunitas. Bidan tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif (Wardhani, 2024).

Selain itu, bidan juga berperan dalam pemantauan kesehatan perempuan pada masa nifas dan memberikan pendidikan kesehatan terkait perawatan diri, pemberian ASI eksklusif, serta pemilihan kontrasepsi yang tepat (Suryati & Islamyati, 2023).

Dengan demikian, bidan menjadi tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan sepanjang siklus kehidupannya.

2. Konseling Kesehatan Reproduksi

Dalam praktik kebidanan, konseling dapat diberikan pada berbagai tahap kehidupan reproduksi perempuan, seperti konseling pranikah, konseling keluarga berencana, konseling kehamilan, serta konseling kesehatan reproduksi remaja. Melalui konseling yang efektif, perempuan dapat memperoleh informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi sehingga mampu membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan dirinya.

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan konseling kesehatan reproduksi kepada masyarakat, terutama kepada remaja dan pasangan usia subur. Konseling yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi serta mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan anemia pada remaja (Winatasari, 2021).

Selain memberikan informasi, konseling juga bertujuan untuk membantu klien memahami berbagai pilihan layanan kesehatan reproduksi yang tersedia serta konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Dengan demikian, konseling menjadi sarana penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.

3. Promosi Kesehatan

Bidan memiliki peran penting dalam kegiatan promosi kesehatan melalui penyuluhan, pendidikan kesehatan, kampanye kesehatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Promosi kesehatan reproduksi dapat dilakukan di berbagai tempat seperti fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, komunitas, maupun melalui kegiatan posyandu dan program kesehatan masyarakat lainnya.

Melalui kegiatan promosi kesehatan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi, seperti pentingnya gizi

bagi remaja putri, pencegahan anemia, kesehatan kehamilan, serta penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif. Promosi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong perubahan perilaku menuju perilaku hidup sehat (Walyani & Purwoastuti, 2018).

Selain itu, promosi kesehatan juga berperan dalam mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi yang dapat terjadi pada setiap tahap kehidupan perempuan. Dengan adanya edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami cara menjaga kesehatan reproduksi serta memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia secara optimal.

4. Pelayanan Berkesinambungan (*Continuity of Care*)

Dalam praktik kebidanan, *continuity of care* mencakup pelayanan yang diberikan mulai dari masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, masa nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana. Pendekatan ini memungkinkan bidan untuk memantau kondisi kesehatan perempuan secara berkelanjutan sehingga masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani lebih dini (Zakiah et al., 2022).

Pelayanan kebidanan yang berkesinambungan terbukti memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan ibu dan bayi, seperti meningkatkan kualitas pelayanan antenatal, mengurangi risiko komplikasi persalinan, serta meningkatkan kepuasan ibu terhadap pelayanan kesehatan yang diterima (Mas'udah et al., 2023).

Selain itu, model pelayanan ini juga membantu membangun hubungan yang kuat antara bidan dan klien, sehingga tercipta rasa percaya yang dapat meningkatkan keberhasilan asuhan kebidanan. Melalui hubungan yang berkelanjutan, bidan dapat memahami kondisi, kebutuhan, serta latar belakang sosial budaya klien secara lebih baik.

H. Penutup

Reproductive life cycle merupakan konsep yang menggambarkan perjalanan fungsi reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupannya, mulai dari masa prenatal, masa bayi dan anak, masa remaja, masa reproduksi, hingga masa menopause dan pascamenopause. Setiap tahap kehidupan tersebut memiliki karakteristik fisiologis, psikologis, dan sosial yang berbeda sehingga memerlukan perhatian serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap fase kehidupan perempuan.

Kesehatan reproduksi perempuan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor biologis, hormonal, psikologis, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut saling

berinteraksi dan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan reproduksi perempuan pada setiap tahap kehidupannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan reproduksi memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai determinan kesehatan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan, tenaga kesehatan terutama bidan memiliki peran yang sangat penting. Bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan, tetapi juga sebagai konselor, pendidik kesehatan, serta pelaksana promosi kesehatan di masyarakat. Melalui pelayanan kebidanan yang berkesinambungan (*continuity of care*), bidan dapat memberikan asuhan yang komprehensif mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana.

Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep *reproductive life cycle* menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi yang holistik dan berkesinambungan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan perempuan sepanjang daur kehidupannya serta mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.

Referensi

- Anggraini, A. (2024). Identifikasi masalah kesehatan reproduksi pada remaja putri di Sumatera Selatan: Literature review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(4). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt>
- Andriyani, L., & Maftuchah. (2015). Asuhan kebidanan berkelanjutan (*continuity of care*) pada Ny. R umur 35 tahun G3P2A0. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 10(2). <https://jurnal.unar.ac.id>
- Berek, J. S., & Novak, E. (2020). *Berek & Novak's gynecology* (16th ed.). Wolters Kluwer.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2019). *Maternity and women's health care* (11th ed.). Mosby.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Damayanti, D. S., & Munawaroh. (2024). Kesehatan reproduksi remaja terkait status gizi, aktivitas fisik, stres dengan siklus menstruasi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id>
- Dewi, R. K., & Megasari, L. A. (2022). *Pengantar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. Poltekkes Kemenkes Medan.

- Fitria, F., & Astuti, N. H. (2023). Aksi sehat untuk diri remaja putri: Merawat kesehatan reproduksi dan mencegah anemia sejak dini. *Health Promotion and Community Engagement Journal*, 2(1). <https://journal.unnes.ac.id/>
- Handayani, A. R., & Sholihah, N. A. (2023). Otonomi perempuan terhadap kesehatan reproduksi dalam perspektif budaya patriarki saat COVID-19. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 12–20. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif>
- Hasanah, H. (2016). Pemahaman kesehatan reproduksi bagi perempuan: Sebuah strategi mencegah berbagai risiko masalah reproduksi remaja. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 229–252. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1456>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Buku kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan*. Kemenkes RI.
- Khobibah, K., Nurhidayati, T., Ruspita, M., & Astyandini, B. (2021). Anemia remaja dan kesehatan reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 3(2). <https://jurnal.unimus.ac.id/>
- Kusmiran, E. (2014). *Kesehatan reproduksi remaja dan wanita*. Salemba Medika.
- Lenny, L., Epril, E., Rahayu, R., Aufa, A., Rita, R., & Faliha, F. (2024). Konsep KIE dan promosi kesehatan perempuan dalam siklus reproduksi normal dan kebutuhan khusus. *Prosiding Forum Ilmiah dan Diskusi Mahasiswa*. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/>
- Mas'udah, S., Tumilah, T., & Windyarti, M. L. N. (2023). Asuhan kebidanan berkelanjutan (*continuity of care*) pada Ny. A di Puskesmas Kedung I Jepara. *PubHealth: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2). <https://journal.unnes.ac.id/>
- Paunno, M. L., & Siahaya, G. C. (2020). Pengaruh perawatan kehamilan dan persalinan dengan kejadian kematian neonatal. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/>
- Prawirohardjo, S. (2018). *Ilmu kebidanan*. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sandy, P. W. S. J., Pratama, A. A., & Sari, C. M. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan informasi kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 7(3), 323–328. <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/>

- Siregar, R., Ramandhani, N. G., Henida, P., & Hati, T. Y. K. (2024). Edukasi persiapan menghadapi masa menopause. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. <https://ejournal.sisfokomtek.org/>
- Suryati, S., & Islamyati, N. (2023). Studi kualitatif peran bidan sebagai care provider dalam pemantauan masa nifas di Puskesmas Mpunda Kota Bima. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 2(1), 20–26. <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/>
- Thalita, T. (2020). Pengaruh program kesehatan seksual dan reproduksi berbasis pendidikan terhadap tingkat kehamilan remaja di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. <https://jurnal.ugm.ac.id/>
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). *Varney's midwifery* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Walyani, E. S., & Purwoastuti, E. (2018). *Asuhan kebidanan kesehatan reproduksi*. Pustaka Baru Press.
- Widiasih, R., & Setyawati, A. (2018). Health behaviour pada perempuan usia subur dalam menjaga kesehatan reproduksi. *Jurnal Perawat Indonesia*, 2(1), 1–7. <https://journal.ppnijateng.org/>
- Widyastuti, Y., Rahmawati, A., & Purnamaningrum, Y. (2019). *Kesehatan reproduksi*. Fitramaya.
- Winatasari, D. (2021). Peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan konseling remaja sebagai pemenuhan hak kesehatan reproduksi remaja akhir. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum*, 6(1). <https://jurnal.akperarrum.ac.id>
- World Health Organization. (2017). *Women's health and life-course approach*. WHO Press.
- World Health Organization. (2018). *Sexual and reproductive health and rights: A global development, health, and human rights priority*. WHO.

BAB II

REMAJA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan remaja sebagai individu yang berada pada rentang usia 10–19 tahun. Pada periode ini terjadi perkembangan pesat pada sistem reproduksi yang disertai perubahan hormon, pertumbuhan fisik, serta perkembangan identitas diri.

Perubahan yang terjadi pada masa remaja sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan dan rasa ingin tahu terkait tubuh dan kesehatan reproduksi. Namun, masih banyak remaja yang tidak memperoleh informasi yang benar dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan munculnya berbagai perilaku berisiko seperti hubungan seksual pranikah, kehamilan tidak diinginkan, serta penularan infeksi menular seksual (IMS).

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada remaja menjadi sangat penting untuk membantu mereka menjalani masa pertumbuhan dengan sehat dan bertanggung jawab.

Pendidikan kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, moral, serta nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Melalui pendidikan yang tepat, remaja dapat memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya, menjaga kesehatan reproduksi, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian, penyediaan informasi yang akurat dan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan remaja.

B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Menurut WHO, kesehatan

reproduksi adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan penyakit atau gangguan pada organ reproduksi. Lebih dari itu, kesehatan reproduksi mencakup kemampuan individu untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Pada masa remaja, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi sangat penting karena pada periode ini terjadi proses pematangan organ reproduksi. Perubahan ini dipengaruhi oleh aktivitas hormon yang meningkat, seperti hormon estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki.

Selain perubahan biologis, remaja juga mengalami perkembangan psikologis yang signifikan. Mereka mulai membentuk identitas diri, mengembangkan hubungan sosial, serta belajar mengambil keputusan secara mandiri. Kondisi ini dapat memengaruhi perilaku remaja dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Konsep kesehatan reproduksi remaja meliputi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi
2. Perubahan fisik dan hormonal pada masa pubertas
3. Pencegahan infeksi menular seksual
4. Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan
5. Pengembangan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab

Peningkatan kesehatan reproduksi remaja tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja. Upaya tersebut memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta pemerintah.

Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan awal mengenai kesehatan reproduksi. Orang tua dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi remaja dalam memahami perubahan yang terjadi pada tubuh mereka.

Sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi secara sistematis melalui kurikulum pendidikan kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan dapat memberikan layanan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah bagi remaja.

Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak, diharapkan remaja dapat memperoleh informasi yang benar serta dukungan yang memadai untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka.

C. Pemahaman Mengenai anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Manusia

1. Anatomi Sistem Reproduksi Laki-Laki

Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari organ eksternal dan internal yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sperma.

a. Organ Eksternal

1) Penis

Organ kopulasi yang berfungsi untuk mengantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi perempuan.

2) Skrotum

Kantung pelindung testis yang berfungsi mengatur suhu optimal untuk produksi sperma.

b. Organ Internal

1) Testis

Berfungsi menghasilkan sperma (spermatogenesis) dan hormon testosteron.

2) Epididimis

Tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma.

3) Vasdeferens

Saluran yang mengangkut sperma dari epididimis ke uretra.

4) Kelenjar aksesori

- Vesikula seminalis: menghasilkan cairan semen
- Kelenjar prostat: menghasilkan cairan pelindung sperma
- Kelenjar bulbouretra: menghasilkan cairan pelumas

2. Anatomi Sistem Reproduksi Perempuan

Sistem reproduksi perempuan berfungsi untuk menghasilkan ovum, menerima sperma, serta menjadi tempat pertumbuhan dan perkembangan janin.

a. Organ Eksternal

1) Vulva

Terdiri dari labia mayor, labia minor, dan klitoris yang berfungsi melindungi organ reproduksi internal.

b. Organ Internal

1) Ovarium

Menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron.

2) Tubafalopi

Tempat terjadinya fertilisasi (pembuahan).

3) Uterus(rahim)

Tempat implantasi dan perkembangan janin.

4) Vagina

Saluran reproduksi yang berfungsi sebagai jalan lahir dan tempat masuknya sperma.

3. Fisiologi Sistem Reproduksi

Fisiologi reproduksi menjelaskan bagaimana organ-organ tersebut bekerja secara terintegrasi dalam proses reproduksi.

a. Spermatogenesis

Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis dan berlangsung sekitar 64–74 hari. Proses ini dipengaruhi oleh hormon testosteron, FSH, dan LH.

b. Oogenesis

Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur (ovum) yang terjadi di ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis, proses ini sudah dimulai sejak masa janin dan berlanjut hingga masa reproduktif.

c. Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi merupakan proses fisiologis pada perempuan yang berlangsung rata-rata 28 hari, terdiri dari beberapa fase:

- 1) Fase folikular: pematangan folikel di ovarium
- 2) Ovulasi: pelepasan ovum
- 3) Fase luteal: persiapan endometrium untuk implantasi
- 4) Menstruasi: peluruhan dinding rahim jika tidak terjadi pembuahan

4. Regulasi Hormonal Sistem Reproduksi

Sistem reproduksi diatur oleh interaksi hormon melalui mekanisme yang disebut aksis hipotalamus–hipofisis–gonad (HPG axis).

- a. Hipotalamus menghasilkan GnRH
- b. Hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH
- c. Gonad (testis/ovarium) menghasilkan hormon seks (testosteron, estrogen, progesteron)

Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan seperti infertilitas, amenore, atau pubertas dini.

5. Integrasi Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi manusia melibatkan beberapa proses utama:

- a. Produksi gamet (sperma dan ovum)
- b. Fertilisasi (pembuahan)
- c. Implantasi embrio
- d. Kehamilan dan persalinan

Semua proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara sistem organ dan hormon.

6. Permasalahan pada Sistem Reproduksi

Beberapa gangguan yang dapat terjadi antara lain:

- a. Infertilitas
- b. Gangguan menstruasi
- c. Disfungsi ereksi
- d. Infeksi organ reproduksi

Pemahaman anatomi dan fisiologi membantu dalam deteksi dini dan penanganan masalah tersebut.

D. Perubahan Fisik dan Hormonal Pada Masa Pubertas

1. Perubahan Hormonal pada Masa Pubertas

Perubahan pubertas dikendalikan oleh sistem hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan kelenjar tubuh untuk mengatur berbagai fungsi tubuh.

a. Peran Hipotalamus dan Hipofisis

Pubertas dimulai ketika hipotalamus di otak melepaskan hormon GnRH yang merangsang kelenjar hipofisis menghasilkan:

- 1) FSH (Follicle Stimulating Hormone)
- 2) LH (Luteinizing Hormone)

Kedua hormon ini merangsang ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki.

2. Hormon pada Perempuan

a. Estrogen

Berfungsi untuk:

- 1) Merangsang pertumbuhan payudara
- 2) Mematangkan rahim dan ovarium
- 3) Mengatur siklus menstruasi
- 4) Membentuk pinggul melebar

b. Progesteron

Berfungsi untuk:

- 1) Mengatur menstruasi
- 2) Menyiapkan rahim untuk kehamilan

3. Hormon pada Laki-laki

a. Testosteron

Berfungsi untuk:

- 1) Membesarkan penis dan testis
- 2) Memproduksi sperma
- 3) Menumbuhkan rambut wajah dan tubuh
- 4) Membentuk otot

- 5) Membuat suara lebih berat
- b. Hormon Pertumbuhan
Pada laki-laki dan perempuan terjadi peningkatan hormon pertumbuhan yang menyebabkan:
 - 1) Tinggi badan bertambah cepat
 - 2) Tulang berkembang
 - 3) Berat badan meningkat

4. Perubahan Fisik pada Masa Pubertas

- a. Perubahan Fisik pada Perempuan
 - 1) Payudara mulai berkembang
 - 2) Pinggul melebar
 - 3) Menstruasi pertama (menarche)
 - 4) Tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan
 - 5) Tinggi badan meningkat cepat
 - 6) Kulit berminyak dan jerawat
- b. Perubahan Fisik pada Laki-laki
 - 1) Testis dan penis membesar
 - 2) Mulai memproduksi sperma
 - 3) Terjadi mimpi basah
 - 4) Suara menjadi berat
 - 5) Jakun mulai terlihat
 - 6) Bahu melebar
 - 7) Otot berkembang
 - 8) Rambut tumbuh di wajah, ketiak, dan kemaluan
- c. Perubahan Umum pada Keduanya
 - 1) Berkeringat lebih banyak
 - 2) Bau badan meningkat
 - 3) Nafsu makan bertambah
 - 4) Berat badan bertambah
 - 5) Jerawat
 - 6) Emosi berubah-ubah

5. Faktor yang Mempengaruhi Pubertas

Beberapa faktor yang memengaruhi waktu pubertas, yaitu:

- a. Faktor genetik atau keturunan
- b. Status gizi
- c. Kesehatan tubuh
- d. Aktivitas fisik
- e. Lingkungan sosial

- f. Berat badan

6. Cara Menjaga Kesehatan pada Masa Pubertas

- a. Menjaga Kebersihan Diri
 - 1) Mandi teratur
 - 2) Membersihkan organ reproduksi
 - 3) Mengganti pakaian dalam setiap hari
- b. Pola Makan Bergizi
 - 1) Konsumsi sayur, buah, protein
 - 2) Minum air putih cukup
 - 3) Kurangi makanan cepat saji
 - 4) Kurangi minuman manis dan karbo yang berlebih
- c. Olahraga Teratur

Olahraga membantu pertumbuhan tulang dan menjaga kebugaran.
- d. Istirahat Cukup

Tidur 8–10 jam per hari penting untuk pertumbuhan dan kebugaran tubuh.

E. Pencegahan Penyakit Menular Seksual

Penyakit Menular Seksual adalah infeksi yang ditularkan dari seseorang ke orang lain melalui kontak seksual. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Penularan juga dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum suntik bersama, serta dari ibu ke bayi saat kehamilan atau persalinan.

1. Jenis-Jenis Penyakit Menular Seksual

- a. Gonore (Kencing Nanah)

Gonore ini disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*.

Gejala:

- 1) Nyeri saat buang air kecil
- 2) Keluar cairan kuning/hijau dari kelamin
- 3) Nyeri panggul
- 4) Perdarahan di luar haid

Komplikasi:

- 1) Radang panggul
- 2) Infertilitas
- 3) Infeksi pada bayi baru lahir

- b. Sifilis

Sifilis ini disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*.

Tahapan:

- 1) Stadium primer: luka tidak nyeri pada kelamin
- 2) Stadium sekunder: ruam kulit

- 3) Stadium laten: tanpa gejala
- 4) Stadium lanjut: merusak jantung dan saraf

Komplikasi:

- 1) Kerusakan organ tubuh
- 2) Gangguan saraf
- 3) Kematian

c. Klamidia

Klamidia ini disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*.

Gejala:

- 1) Keputihan abnormal
- 2) Nyeri saat BAK
- 3) Nyeri perut bawah
- 4) Sering tanpa gejala

Komplikasi:

- 1) Kemandulan
- 2) Kehamilan ektopik

d. Herpes Genital

Herpes Genital disebabkan oleh virus Herpes Simpleks (HSV).

Gejala:

- 1) Luka lepuh pada kelamin
- 2) Nyeri
- 3) Gatal
- 4) Demam

Komplikasi:

- 1) Kambuh berulang
- 2) Penularan pada bayi saat lahir

e. HIV/AIDS

HIV/ AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus.

Gejala awal:

- 1) Demam
- 2) Berat badan turun
- 3) Diare kronis
- 4) Infeksi berulang

Dampak:

- 1) Menurunkan kekebalan tubuh
- 2) Rentan terkena infeksi lain

- f. HPV (Human Papillomavirus)

Gejala:

- 1) Kutil kelamin
- 2) Sebagian tanpa gejala

Dampak:

- 1) Kanker serviks
- 2) Kanker anus
- 3) Kanker penis

2. Cara Penularan PMS

PMS dapat menular melalui:

- a. Hubungan seksual tanpa pengaman
- b. Berganti-ganti pasangan seksual
- c. Penggunaan jarum suntik bersama
- d. Transfusi darah yang tidak aman
- e. Ibu hamil ke janin/bayi
- f. Kontak langsung dengan luka infeksi

3. Faktor Risiko PMS

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko tertular PMS:

- a. Seks bebas tanpa kondom
- b. Memiliki banyak pasangan seksual
- c. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi
- d. Penyalahgunaan narkoba suntik
- e. Kebersihan organ reproduksi buruk
- f. Menikah usia dini tanpa edukasi kesehatan

4. Tanda dan Gejala Umum PMS

Gejala PMS berbeda-beda, namun umumnya meliputi:

- a. Nyeri saat buang air kecil
- b. Keluar cairan abnormal dari kelamin
- c. Luka, lepuh, atau kutil pada kelamin
- d. Gatal di area genital
- e. Nyeri saat berhubungan seksual
- f. Nyeri panggul
- g. Demam
- h. Pembengkakan kelenjar getah bening

Sebagian penderita tidak mengalami gejala.

5. Dampak Penyakit Menular Seksual

Dampak Fisik:

- a. Kemandulan

- b. Radang panggul
- c. Kehamilan bermasalah
- d. Kanker
- e. Penurunan daya tahan tubuh

Dampak Psikologis:

- a. Malu
- b. Cemas
- c. Depresi
- d. Stigma sosial

Dampak Sosial:

- a. Konflik rumah tangga
- b. Perceraian
- c. Beban biaya pengobatan

6. Pencegahan Penyakit Menular Seksual

a. Menjaga Kesetiaan pada Satu Pasangan

Hubungan seksual dengan satu pasangan yang sehat dan setia dapat menurunkan risiko penularan. Hubungan seksual yang dilakukan dengan satu pasangan yang sehat, saling setia, dan memiliki komitmen dalam menjaga kesehatan reproduksi merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan risiko penularan penyakit menular seksual. Kesetiaan pada satu pasangan dapat membatasi kontak seksual dengan orang lain yang berpotensi membawa infeksi, sehingga peluang terjadinya penularan menjadi lebih kecil. Selain itu, penting bagi kedua pasangan untuk saling terbuka mengenai kondisi kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta menjaga kebersihan diri agar hubungan yang dijalani tetap aman, sehat, dan bertanggung jawab.

b. Menggunakan Kondom

Penggunaan kondom secara benar dan konsisten merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah penularan penyakit menular seksual (PMS). Kondom berfungsi sebagai alat pelindung yang dapat menghambat kontak langsung antara cairan tubuh dan organ reproduksi, sehingga risiko penularan infeksi dapat berkurang secara signifikan. Agar efektif, kondom harus digunakan sejak awal hingga akhir hubungan seksual serta dipakai sesuai petunjuk penggunaan. Selain itu, penggunaan kondom secara rutin pada setiap hubungan seksual menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan diri sendiri maupun pasangan. Dengan demikian, pemakaian kondom yang tepat dan konsisten dapat menjadi upaya pencegahan yang sederhana namun sangat bermanfaat.

c. Vaksinasi

Vaksin yang tersedia:

1) Vaksin HPV

vaksin HPV (Human Papillomavirus) merupakan vaksin yang diberikan untuk melindungi tubuh dari infeksi virus HPV, yaitu virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin serta berbagai jenis kanker, terutama kanker serviks. Pemberian vaksin HPV sangat dianjurkan sejak usia remaja sebelum seseorang aktif secara seksual agar perlindungan yang diperoleh lebih optimal.

2) Vaksin Hepatitis B

Vaksin Hepatitis B adalah vaksin yang berfungsi mencegah infeksi virus Hepatitis B, yaitu virus yang menyerang hati dan dapat menimbulkan penyakit kronis seperti sirosis maupun kanker hati. Virus ini dapat menular melalui darah, hubungan seksual, maupun dari ibu kepada bayi saat persalinan. Oleh karena itu, vaksin Hepatitis B penting diberikan sejak bayi dan dapat dilanjutkan pada orang dewasa yang belum pernah mendapatkan

d. Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi

Membersihkan organ reproduksi secara benar dan teratur merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan diri. Kebersihan organ reproduksi dapat mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, maupun kuman penyebab infeksi yang dapat menimbulkan rasa gatal, iritasi, atau penyakit tertentu. Perawatan dilakukan dengan membersihkan area reproduksi menggunakan air bersih, menjaga agar tetap kering, serta mengganti pakaian dalam secara rutin. Dengan menjaga kebersihan organ reproduksi, kesehatan dan kenyamanan tubuh dapat tetap terpelihara.

e. Tidak Berbagi Jarum Suntik

Menghindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama merupakan langkah penting dalam mencegah penularan berbagai penyakit berbahaya. Jarum suntik yang dipakai bergantian dapat menjadi media penularan infeksi melalui darah, seperti HIV, Hepatitis B, dan Hepatitis C. Oleh karena itu, setiap orang harus menggunakan jarum suntik yang steril dan hanya untuk satu kali pemakaian sesuai standar kesehatan. Dengan tidak berbagi jarum suntik, risiko penularan penyakit dapat dikurangi dan kesehatan tetap terjaga.

f. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Melakukan tes penyakit menular seksual (PMS) secara rutin, terutama bagi individu yang memiliki faktor risiko, merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi infeksi sejak dini, bahkan ketika gejala belum terlihat. Dengan

mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, pengobatan dapat segera dilakukan sehingga mencegah komplikasi serta mengurangi risiko penularan kepada pasangan. Oleh karena itu, tes PMS secara berkala menjadi bagian penting dari upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan.

g. Edukasi Seksual Sehat

Meningkatkan pengetahuan remaja dan masyarakat tentang kesehatan reproduksi merupakan upaya penting dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan berkualitas. Pemahaman yang baik mengenai fungsi organ reproduksi, cara menjaga kebersihan, pencegahan penyakit menular seksual, serta pentingnya perilaku hidup sehat dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat. Edukasi yang memadai juga dapat mencegah kesalahpahaman, mitos, dan perilaku berisiko yang dapat merugikan kesehatan. Dengan meningkatnya pengetahuan, remaja dan masyarakat akan lebih sadar untuk menjaga kesehatan reproduksi sejak dini.

7. Penanganan PMS

Jika mengalami gejala PMS:

a. 12.1 Segera periksa ke dokter atau puskesmas

Jika mengalami gejala penyakit menular seksual (PMS), segera periksa ke dokter atau puskesmas agar mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Gejala seperti nyeri saat buang air kecil, keluar cairan tidak normal dari organ reproduksi, luka, gatal, atau ruam di area kelamin tidak boleh diabaikan. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan penting untuk mengetahui penyebab keluhan serta menentukan pengobatan yang sesuai. Dengan memeriksakan diri sejak dini, risiko komplikasi dan penularan kepada orang lain dapat dicegah.

b. Jangan mengobati sendiri tanpa pemeriksaan

Jangan mengobati sendiri tanpa pemeriksaan tenaga kesehatan, karena penggunaan obat yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi dan menunda penanganan yang seharusnya. Gejala penyakit menular seksual (PMS) sering kali mirip dengan penyakit lain, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya. Mengonsumsi obat sembarangan juga dapat menyebabkan efek samping, resistensi obat, atau membuat infeksi tidak sembuh secara tuntas. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan keluhan kepada dokter atau petugas kesehatan agar mendapatkan pengobatan yang aman dan sesuai.

c. Minum obat sesuai resep dokter

Minum obat sesuai resep dokter merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan penyakit. Obat yang diberikan dokter telah disesuaikan dengan

jenis penyakit, kondisi tubuh, serta dosis yang tepat bagi pasien. Mengonsumsi obat secara teratur sesuai aturan dapat membantu mempercepat kesembuhan dan mencegah penyakit menjadi lebih parah. Sebaliknya, jika obat diminum tidak sesuai petunjuk, dihentikan sebelum waktunya, atau digunakan secara sembarangan, pengobatan bisa menjadi tidak efektif dan menimbulkan komplikasi. Oleh karena itu, pasien harus mengikuti resep dokter dengan disiplin agar hasil pengobatan optimal.

d. Hindari hubungan seksual selama pengobatan

Hindari hubungan seksual selama masa pengobatan agar proses penyembuhan dapat berjalan dengan baik dan risiko penularan kepada pasangan dapat dicegah. Pada beberapa penyakit menular seksual, infeksi masih dapat menular meskipun gejala mulai berkurang. Melakukan hubungan seksual saat pengobatan juga dapat menyebabkan iritasi, memperparah keluhan, atau menghambat efektivitas terapi. Oleh karena itu, sebaiknya menunggu hingga pengobatan selesai dan dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan sebelum kembali melakukan hubungan seksual.

e. Lakukan kontrol ulang

Lakukan kontrol ulang setelah menjalani pengobatan untuk memastikan kondisi kesehatan telah membaik dan infeksi benar-benar sembuh. Pemeriksaan ulang penting dilakukan karena beberapa penyakit dapat tetap ada meskipun gejala sudah berkurang atau hilang. Melalui kontrol ulang, tenaga kesehatan dapat menilai keberhasilan pengobatan, memberikan saran lanjutan, serta menentukan apakah masih diperlukan terapi tambahan. Dengan melakukan kontrol secara teratur, risiko kekambuhan dan komplikasi dapat dicegah.

8. Peran Keluarga dan Sekolah

a. Peran Keluarga:

- 1) Memberikan pendidikan moral merupakan upaya penting dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku yang baik pada seseorang sejak usia dini. Pendidikan moral mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, menghormati orang lain, serta kemampuan membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Dengan bekal moral yang baik, seseorang akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain
- 2) Menjalinkan komunikasi terbuka merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling percaya, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan masyarakat. Komunikasi terbuka berarti

adanya keberanian untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan masalah secara jujur serta saling mendengarkan dengan penuh penghargaan. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat dicegah, masalah lebih mudah diselesaikan, dan hubungan antarindividu menjadi lebih harmonis

- 3) Mengawasi pergaulan anak merupakan tanggung jawab penting bagi orang tua dalam menjaga perkembangan dan keselamatan anak. Pengawasan dilakukan bukan untuk membatasi kebebasan anak secara berlebihan, tetapi untuk memastikan anak berada dalam lingkungan pergaulan yang positif dan tidak terpengaruh oleh perilaku yang merugikan. Orang tua perlu mengenal teman-teman anak, mengetahui aktivitas sehari-hari, serta memberikan arahan dan nasihat yang baik

b. Peran Sekolah:

- 1) Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan proses pemberian pengetahuan mengenai fungsi organ reproduksi, cara menjaga kebersihan, perubahan fisik pada masa pubertas, serta pencegahan berbagai masalah kesehatan reproduksi. Pendidikan ini penting diberikan sejak dini sesuai usia agar remaja dan masyarakat memiliki pemahaman yang benar serta mampu menjaga kesehatan dirinya. Dengan adanya pendidikan kesehatan reproduksi, seseorang dapat terhindar dari informasi yang salah, perilaku berisiko, dan penyakit menular seksual
- 2) Konseling remaja merupakan layanan bimbingan dan pendampingan yang diberikan untuk membantu remaja menghadapi berbagai masalah yang dialami pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Permasalahan tersebut dapat berupa masalah emosional, pergaulan, pendidikan, kesehatan reproduksi, maupun tekanan sosial. Melalui konseling, remaja dapat memperoleh tempat yang aman untuk bercerita, mendapatkan arahan, serta menemukan solusi yang tepat terhadap masalahnya
- 3) Kampanye hidup sehat merupakan kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup yang baik demi menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Kampanye ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, media sosial, seminar, maupun kegiatan masyarakat yang membahas pentingnya makan bergizi, olahraga teratur, menjaga kebersihan, istirahat cukup, serta menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Dengan adanya kampanye hidup sehat, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dapat meningkat.

F. Mencegah Kehamilan Yang Tidak direncanakan

1. Pengertian

Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kehamilan pada waktu yang belum diinginkan atau belum dipersiapkan. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat terjadi pada pasangan menikah maupun belum menikah akibat kurangnya pengetahuan, tidak menggunakan alat kontrasepsi, atau penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

2. Tujuan Pencegahan Kehamilan yang Tidak Direncanakan

- a. Mengurangi risiko kehamilan pada usia terlalu muda
merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Kehamilan pada usia terlalu muda, terutama remaja, berisiko menyebabkan komplikasi seperti anemia, persalinan prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah karena organ reproduksi belum berkembang sempurna.
- b. Membantu pasangan merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran.
Membantu pasangan merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran merupakan langkah penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan perencanaan yang baik, pasangan dapat menentukan jumlah anak sesuai kemampuan ekonomi, kesiapan fisik, serta kondisi psikologis keluarga. Selain itu, pengaturan jarak kelahiran memberi waktu bagi ibu untuk memulihkan kesehatan setelah persalinan dan memberikan perhatian optimal kepada anak yang sudah lahir. Jarak kelahiran yang ideal juga dapat menurunkan risiko komplikasi kehamilan serta meningkatkan tumbuh kembang anak secara lebih baik.
- c. Menjaga kesehatan ibu dan bayi.
Menjaga kesehatan ibu dan bayi merupakan tujuan utama dalam setiap kehamilan dan persalinan. Ibu yang sehat selama masa kehamilan akan lebih siap menjalani persalinan serta memiliki risiko komplikasi yang lebih rendah. Kesehatan ibu dapat dijaga melalui pemeriksaan kehamilan rutin, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan diri.
- d. Mengurangi angka putus sekolah akibat kehamilan dini.
Mengurangi angka putus sekolah akibat kehamilan dini merupakan upaya penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan remaja. Kehamilan pada usia sekolah sering menyebabkan siswa menghentikan pendidikannya karena tekanan sosial, tanggung jawab sebagai orang tua, atau keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi, pengawasan orang tua,

serta akses terhadap layanan konseling sangat diperlukan agar remaja mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab

e. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui perencanaan keluarga yang baik, termasuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran secara tepat. Dengan keluarga yang terencana, kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perhatian terhadap setiap anggota keluarga dapat terpenuhi dengan lebih optimal.

f. Mencegah dampak psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Mencegah dampak psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak diinginkan sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan masa depan seseorang. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat menimbulkan stres, rasa takut, kecemasan, hingga depresi, terutama pada remaja yang belum siap secara emosional maupun ekonomi. Selain itu, dapat muncul tekanan sosial, stigma masyarakat, konflik keluarga, dan terhambatnya pendidikan atau pekerjaan.

3. Faktor Penyebab Kehamilan yang Tidak Direncanakan

a. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan berbagai masalah pada remaja maupun masyarakat. Ketidaktahuan mengenai fungsi organ reproduksi, perubahan pubertas, kebersihan diri, serta risiko hubungan seksual yang tidak aman dapat menyebabkan kehamilan tidak direncanakan dan penyakit menular seksual. Selain itu, kurangnya informasi yang benar sering membuat seseorang mudah percaya pada mitos yang menyesatkan

b. Tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Tidak menggunakan alat kontrasepsi dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan serta penularan penyakit menular seksual. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan, rasa malu untuk berkonsultasi, akses yang terbatas, atau anggapan yang salah tentang kontrasepsi. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan kesiapan mental pasangan

c. Penggunaan kontrasepsi yang tidak benar.

Penggunaan kontrasepsi yang tidak benar dapat mengurangi efektivitas alat kontrasepsi dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan maupun penularan penyakit menular seksual. Kesalahan penggunaan dapat terjadi karena kurang memahami cara pakai, lupa jadwal penggunaan, atau tidak

mengikuti petunjuk tenaga kesehatan. Akibatnya, risiko kegagalan kontrasepsi menjadi lebih tinggi dan dapat menimbulkan masalah kesehatan maupun sosial.

d. Pergaulan bebas dan perilaku seksual berisiko.

Pergaulan bebas dan perilaku seksual berisiko dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial, terutama pada remaja. Perilaku tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, infeksi menular seksual, serta gangguan psikologis seperti rasa cemas dan penyesalan. Selain itu, pergaulan yang tidak terarah juga dapat memengaruhi prestasi belajar dan hubungan dengan keluarga.

e. Tekanan dari pasangan atau lingkungan.

Tekanan dari pasangan atau lingkungan dapat memengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan atau nilai yang diyakininya. Pada remaja, tekanan tersebut sering muncul dalam bentuk ajakan melakukan perilaku berisiko, termasuk hubungan seksual pranikah, penggunaan zat berbahaya, atau pergaulan yang tidak sehat. Kondisi ini dapat menimbulkan stres, rasa bersalah, serta berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan masa depan.

f. Pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda, ketika seseorang belum matang secara fisik, mental, maupun ekonomi. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti putus sekolah, kehamilan berisiko, masalah kesehatan ibu dan anak, serta ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, pasangan usia muda lebih rentan mengalami konflik karena emosi yang belum stabil.

g. Kurangnya komunikasi dalam keluarga.

Kurangnya komunikasi dalam keluarga dapat menyebabkan hubungan antaranggota keluarga menjadi kurang harmonis dan menimbulkan kesalahpahaman. Pada remaja, kondisi ini sering membuat mereka merasa kurang diperhatikan, enggan bercerita, dan mencari informasi dari sumber yang belum tentu benar. Akibatnya, remaja lebih rentan terpengaruh lingkungan negatif serta mengalami masalah perilaku dan emosional.

4. Cara Pencegahan Kehamilan yang Tidak Direncanakan

a. Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Memberikan pengetahuan yang benar mengenai sistem reproduksi, masa subur, risiko hubungan seksual, dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi.

b. Menunda Hubungan Seksual

Menunda aktivitas seksual sampai siap secara fisik, mental, sosial, dan memiliki tanggung jawab yang matang merupakan langkah pencegahan yang paling efektif.

c. Menggunakan Alat Kontrasepsi

Bagi pasangan yang telah menikah atau aktif secara seksual, penggunaan kontrasepsi sesuai anjuran tenaga kesehatan dapat membantu mencegah kehamilan.

Contoh alat kontrasepsi:

- 1) Kondom
- 2) Pil KB
- 3) Suntik KB
- 4) Implan
- 5) IUD (spiral)

d. Konsultasi dengan Tenaga Kesehatan

Berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan untuk memilih metode kontrasepsi yang aman dan sesuai kondisi tubuh.

e. Menjalinkan Komunikasi yang Baik

Komunikasi terbuka antara pasangan dan keluarga sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai perencanaan kehamilan.

f. Menghindari Perilaku Berisiko

Menghindari pergaulan bebas, penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan tindakan yang dapat mendorong perilaku seksual tidak bertanggung jawab.

G. Pengembangan Sikap Dan Perilaku Bertanggung Jawab

Pengembangan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam pembentukan kepribadian remaja. Masa remaja adalah periode peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Pada masa ini, remaja mulai belajar mengambil keputusan sendiri, berinteraksi lebih luas dengan lingkungan, serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, sikap dan perilaku yang bertanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini agar remaja mampu menjalani kehidupan secara sehat dan positif.

Sikap bertanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajiban, menerima konsekuensi dari tindakan, serta mampu menjaga diri dan orang lain. Perilaku bertanggung jawab tercermin dalam tindakan nyata seperti disiplin, jujur, menghargai orang lain, serta mampu membuat pilihan yang tepat.

1. Pentingnya Sikap dan Perilaku yang Bertanggung Jawab

Pengembangan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab memiliki manfaat besar bagi kehidupan remaja, antara lain:

a. Membentuk karakter positif

Remaja yang bertanggung jawab akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan dapat dipercaya.

b. Mencegah perilaku berisiko

Sikap tanggung jawab membantu remaja menghindari perilaku negatif seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan.

c. Meningkatkan prestasi belajar

Remaja yang bertanggung jawab cenderung lebih serius dalam belajar, mengerjakan tugas, dan menghargai waktu.

d. Membangun hubungan sosial yang sehat

Sikap menghormati orang lain dan menjaga kepercayaan akan menciptakan hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat.

2. Menyiapkan masa depan

Tanggung jawab menjadi bekal penting dalam dunia kerja, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat.

3. Bentuk Sikap dan Perilaku yang Bertanggung Jawab

Beberapa bentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab yang perlu dimiliki remaja antara lain:

a. Disiplin terhadap aturan

Mematuhi peraturan di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

b. Jujur dalam perkataan dan tindakan

Tidak berbohong, mencontek, atau menipu orang lain.

c. Menjaga kesehatan diri

Menjaga kebersihan tubuh, pola makan sehat, dan menghindari perilaku yang merugikan kesehatan.

d. Menghargai diri sendiri dan orang lain

Bersikap sopan, tidak merendahkan orang lain, dan menjaga batas pergaulan.

e. Berani menerima konsekuensi

Siap bertanggung jawab atas kesalahan dan berusaha memperbaikinya.

f. Bijak dalam menggunakan media sosial

Tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap Bertanggung Jawab

a. Keluarga

Orang tua menjadi teladan utama dalam menanamkan nilai tanggung jawab kepada anak.

b. Sekolah

Guru dan lingkungan sekolah membantu membentuk disiplin, kejujuran, dan kerja sama.

c. Teman sebaya

Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja.

d. Media massa dan teknologi

Informasi dari internet dan media sosial dapat memberi pengaruh positif maupun negatif.

e. Nilai agama dan budaya

Ajaran agama dan norma sosial menjadi pedoman dalam berperilaku.

5. Cara Mengembangkan Sikap dan Perilaku yang Bertanggung Jawab

a. Membiasakan hidup disiplin dan tepat waktu.

b. Menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.

c. Berpikir sebelum bertindak.

d. Berani berkata tidak pada ajakan negatif.

e. Menghormati orang tua, guru, dan sesama teman.

f. Menjaga pergaulan yang sehat.

g. Menggunakan teknologi secara bijaksana.

h. Belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri.

6. Tantangan Remaja dalam Bersikap Bertanggung Jawab

Remaja sering menghadapi tantangan seperti pengaruh teman sebaya, rasa ingin mencoba hal baru, emosi yang belum stabil, serta paparan media sosial yang berlebihan. Jika tidak dibimbing dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pendampingan dari keluarga dan sekolah sangat diperlukan.

H. Penutup

Masa remaja merupakan periode penting dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, sosial, dan psikologis. Pada masa ini, pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi sangat diperlukan agar remaja mampu menjaga diri, mengambil keputusan yang tepat, serta bertanggung jawab terhadap masa depannya. Oleh karena itu, buku *Remaja dan Kesehatan Reproduksi* disusun sebagai sumber pengetahuan yang dapat

membantu remaja, pendidik, maupun orang tua dalam memahami berbagai aspek kesehatan reproduksi secara menyeluruh.

Melalui pembahasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, remaja diharapkan mengenal fungsi tubuhnya dengan baik. Penjelasan tentang perubahan fisik dan hormonal pada masa pubertas membantu remaja memahami proses pertumbuhan yang dialami secara alami. Selain itu, materi mengenai pencegahan infeksi menular seksual dan pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan memberikan wawasan penting agar remaja mampu menghindari berbagai risiko yang dapat merugikan kesehatan dan masa depan mereka.

Tidak kalah penting, pengembangan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab menjadi landasan utama dalam membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Pengetahuan yang baik harus diiringi dengan sikap positif, kemampuan mengendalikan diri, serta penghargaan terhadap nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi pedoman bagi remaja dalam menjalani masa pertumbuhan secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan remaja yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, akan tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Referensi

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2020. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN.
- Hurlock, Elizabeth B. 2011. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2014. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santrock, John W. 2012. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UNESCO. 2018. *International Technical Guidance on Sexuality Education*. Paris: UNESCO.
- United Nations Population Fund (UNFPA). 2019. *Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings*. New York: UNFPA.
- World Health Organization (WHO). 2020. *Adolescent Health*. Geneva: WHO.
- Yusuf, Syamsu. 2016. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB III

KEHAMILAN DAN PERSALINAN

A. Pendahuluan

Kehamilan dan persalinan merupakan proses fisiologis yang dialami perempuan, namun beresiko tinggi mengalami komplikasi bahkan menjadi penyebab kematian ibu dan janin. Kehamilan dan persalinan melibatkan perubahan sistem tubuh terutama organ reproduksi dan perubahan psikologis, dimana kegembiraan dan kecemasan muncul secara bersamaan.

Kehamilan adalah proses alami yang dimulai dari fertilisasi (penyatuan sperma dan ovum), nidasi/implantasi di rahim dan berakhir dengan persalinan. Ibu mengalami perubahan drastis pada sistem organ dan hormon untuk membantu perkembangan janin. Kehamilan umumnya berlangsung selama 40 minggu yang terbagi dalam tiga trimester yaitu trimester I (0-12 minggu), trimester II (13-28 minggu) dan trimester III (29-40 minggu). Di periode ini diharapkan ibu aktif melaksanakan antenatal care (ANC) di fasilitas pelayanan kesehatan sampai menjelang persalinan.

Persalinan dapat terjadi secara spontan maupun dengan tindakan. Ada empat tahapan dalam persalinan yaitu Kala I (pembukaan), Kala II (pengeluaran janin), Kala III (pengeluaran plasenta) dan Kala IV (pengawasan). Komplikasi dapat terjadi pada setiap tahapan karena ada lima faktor yang memengaruhi persalinan antara lain kekuatan (power), jalan lahir (passage), janin (passanger), posisi dan psikologi ibu. Pemantauan intensif oleh tenaga kesehatan sangat krusial untuk memastikan keselamatan ibu dan janin sehingga meminimalisir kesakitan dan kematian.

B. Perubahan Sistem Reproduksi

Perubahan sistem reproduksi pada kehamilan trimester I, II dan III meliputi:

1. Rahim atau *Uterus*

Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama dibawah pengaruh *estrogen* dan *progesteron* yang kadarnya meningkat. Pada kehamilan 8 minggu *uterus* membesar dan semakin membesar sesuai dengan usia kehamilan. Berat menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan, ukurannya untuk pertumbuhan janin rahim menjadi besar, *endometrium* menjadi *desidua*, ukuran kehamilan 30 x 25 x 20 kapasitas lebih dari 4000 cc.

2. Serviks Uteri

Serviks uteri pada kehamilan mengalami perubahan karena *hormon estrogen*. Akibat kadar *estrogen* yang meningkat dan dengan adanya *hipervaskularisasi*, maka konsistensi *serviks* menjadi lunak. *Serviks uteri* lebih banyak mengandung jaringan ikat yang terdiri atas *kolagen*. Selain itu *prostaglandin* bekerja pada serabut *kolagen*, terutama pada minggu-minggu akhir kehamilan.

3. Segmen Bawah Uterus

Segmen bawah *uterus* berkembang dari bagian atas *kanalis servikalis* setinggi *ostium interna* bersama-sama *isthmus uteri*. Segmenbawah lebih tipis dari pada segmen atas dan menjadi lunak serta ber*dilatasi* selama minggu-minggu terakhir kehamilan sehingga memungkinkan segmen tersebut menampung *presenting part* janin.

4. Kontraksi Braxton-Hicks

Merupakan *kontraksi* tak teratur rahim dan terjadi tanpa rasa nyeri disepanjang kehamilan. *Kontraksi* ini barang kali membantu sirkulasi darah dalam *plasenta*.

5. Vagina dan Vulva

Vagina dan *serviks* akibat *hormon estrogen* mengalami perubahan pula. adanya *hipervaskularisasi* mengakibatkan *vagina* dan *vulva* tampak lebih merah, agak kebiruan (*livide*) disebut tanda *chadwick*.

6. Ovarium

Pada permulaan kehamilan masih didapat *korpus luteum graviditas* sampai terbentuknya *plasenta* pada kira-kira kehamilan 16 minggu. *Korpus luteum graviditas* berdiameter kira-kira 3 cm. lalu ia mengecil setelah *plasenta* terbentuk.

7. Mammae (Payudara)

Mammae akan membesar dan tegang akibat *hormon somatomammotropin*, *estrogen* dan *progesteron* akan tetapi belum mengeluarkan air susu. Pada kehamilan akan terbentuk lemak sehingga *mammae* menjadi lebih besar (Darwiten YN, 2019).

Menjelang persalinan bentuk uterus berubah pada tiap kontraksi sumbu panjang rahim bertambah panjang sedangkan ukuran melintang maupun muka belakang berkurang. Hal ini terjadi karena ukuran melintang berkurang, artinya tulang punggung menjadi lebih lurus dan dengan demikian kutup atas anak tertekan pada fundus sedangkan kutub bawah ditekan ke dalam Pintu Atas Panggul (PAP). Kemudian agar bayi dapat keluar dari rahim maka terjadi pembukaan dari serviks yang didahului oleh pendataran dari serviks.

1. Pendataran serviks adalah : pendekatan dari kanalis servikalis berupa sebuah saluran yang panjangnya 1-2 cm, menjadi satu lubang saja dengan pinggir yang tipis.
2. Pembukaan dari serviks adalah pembesaran dari OUE yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa millimeter menjadi lubang yang dapat dilalui anak kira-kira 10 cm diameternya.

Di kala I ketuban ikut meregangkan bagian atas vagina yang sejak kehamilan mengalami perubahan sedemikian rupa, sehingga dapat dilalui oleh anak. Setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul diregang menjadi saluran dengan dinding yang tipis. Waktu kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke depan atas. Dari luar peregangan oleh bagian depan nampak pada perineum yang menonjol dan menjadi tipis sedangkan anus menjadi terbuka.

Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus sekitar di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau seperti buah pear atau alpukat dan fundus berada di atas pusat. Otot uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi . Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan semakin kecil sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina.

Memeriksa ada tidaknya robekan jalan lahir di daerah perineum, vagina dan vulva. Vagina kemungkinan akan mengalami peregangan, edema dan lecet. Introitus vagina juga akan tampak terkulai dan terbuka. Sedangkan vulva bisa berwarna merah, bengkak dan mengalami lecet-lecet. Ketika hal ini terjadi perlu dilakukan tindakan sesuai prosedur agar pemulihan dapat berlangsung baik (Prawirohardjo, 2013).

C. Antenatal (ANC)

Antenatal Care (ANC) atau perawatan kehamilan adalah layanan kesehatan oleh tenaga medis profesional (bidan/dokter) untuk memantau kesehatan fisik dan mental ibu serta tumbuh kembang janin. Tujuannya adalah mendeteksi dini komplikasi, memberikan edukasi, dan mempersiapkan persalinan yang aman. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan ibu hamil minimal 6 kali selama kehamilan dengan jadwal dua kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga. Pemeriksaan boleh dilakukan oleh bidan dan dianjurkan ke dokter spesialis

kebidanan dua kali termasuk pemeriksaan USG, sekali di trimester I dan sekali di trimester III. Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 14T yaitu :

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur tekanan darah
3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA)
4. Pemeriksaan puncak rahim (tinggi fundus uteri)
5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT) bila diperlukan.
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
8. Tes laboratorium, tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
9. Pemeriksaan *Veneral Disease Research Laboratory* (VDRL), Pemeriksaan ini dilakukan untuk skrining antibody terhadap *Treponema pallidum*, dan Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya. Dampak PMS pada kehamilan bergantung pada organisme penyebab, lamanya infeksi dan usia kehamilan pada saat ibu hamil terinfeksi.
10. Perawatan payudara, Perawatan payudara adalah usaha untuk memperlancar aliran ASI dan mencegah masalah – masalah yang mungkin muncul pada saat menyusui seperti puting susu nyeri atau lecet, payudara bengkak dan saluran susu tersumbat.
11. Pemeliharaan tingkat kebugaran/senam hamil. Senam hamil adalah program kebugaran khusus bagi ibu hamil. Oleh karena itu senam hamil memiliki prinsip Gerakan khusus yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Latihan pada senam hamil dirancang untuk menyehatkan dan membugarkan ibu hamil, mengurangi keluhan yang timbul selama kehamilan serta mempersiapkan fisik dan psikis ibu dalam menghadapi persalinan. (Manuaba, 2015)
12. Pemeriksaan *protein urine* atas indikasi dan reduksi *urine* atas indikasi. Pemeriksaan ini perlu dilakukan pada ibu hamil (terutama protein urin pada trimester kedua dan ketiga) untuk mendeteksi adanya hipertensi atau preeklamsi, reduksi urine untuk mendeteksi adanya DM (Diabetes Mellitus).
13. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan.
14. Temu wicara/konseling (Kemenkes,2020).

D. Tanda dan Gejala Kehamilan

Menurut Fatimah (2019), beberapa tanda dan gejala kehamilan, yaitu sebagai berikut :

1. Tanda- Tanda Tidak Pasti (*presumtif*) kehamilan.

- a. Terlambat Datang Bulan (*Amenorhea*)
Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan *folikel de Graaf* dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi.
- b. Mual (*Nausea*) dan Muntah (*Emesis*)
Pengaruh *estrogen* dan *progesteron* terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut *morning sickness*.
- c. Ngidam.
Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan yang demikian disebut ngidam. Ngidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan menghilang dengan makin tuanya kehamilan.
- d. Pingsan (*syncope*)
Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala (*sentral*) menyebabkan *iskemia* susunan saraf pusat dan menimbulkan *syncope* atau pingsan. Hal ini sering terjadi terutama jika berada pada tempat yang ramai. Biasanya akan hilang setelah 16 minggu.
- e. *Mastodinia* (Payudara Tegang)
Estrogen meningkatkan perkembangan sistem *duktus* pada payudara, sedangkan *progesteron* *menstimulasi* perkembangan sistem *alveolar* payudara. Bersama somatomamotropin, hormon-hormon ini menimbulkan pembesaran payudara, menimbulkan perasaan tegang dan nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, pelebaran puting susu, serta pengeluaran *kolustrum*.
- f. *Konstipasi* atau *Obstipasi*
Pengaruh *progesteron* dapat menghambat peristaltik usus (tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB.
- g. *Hiperpigmentasi* Kulit
Hiperpigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Terjadi akibat pengaruh hormon *kortikosteroid* plasenta yang merangsang *melanofor* dan kulit.
- h. Perubahan Berat Badan.
Terjadinya kenaikan berat badan akibat pengaruh pertumbuhan janin, berat badan akan selalu meningkat sampai stabil menjelang persalinan.

2. Tanda-Tanda Kemungkinan Kehamilan (Probability Sign)

a. Tanda *Hegar*.

Pelunakan pada daerah *isthmus uteri* sehingga segmen bawah *uterus* terasa lembek atau teraba tipis.

b. Tanda *Chadwicks*

Perubahan warna vagina menjadi kebiru-biruan yang dialami ibu hamil sekitar minggu ke-6 karena mengalami kongesti.

c. Tanda *Piscacec's*

Pembesaran *uterus* yang tidak simetris. Terjadi karena bagian bawah *uterus* berada didekat *implantasiplacenta* sehingga uterus mengalami pertumbuhan yang tidak simetris.

d. Kontraksi *Braxton His*.

Peregangan sel-sel otot *uterus*, akibat meningkatnya *actomysin* di dalam otot *uterus*. Kontraksi ini tidak *beritmik*, *sporadis*, tidak nyeri, biasanya timbul pada kehamilan delapan minggu, tetapi baru dapat diamati dari pemeriksaan *abdominal* pada trimester ke tiga.

e. Tanda *Goodell's*

Pelunakan *serviks*. Pada wanita yang tidak hamil *serviks* seperti ujung hidung, sedangkan pada hamil melunak seperti bibir.

f. Tanda Mc Donald

Pelunakan *isthmus*. Pada wanita hamil fundus *uteri* dapat difleksikan dengan mudah.

g. Terjadi Pembesaran *Abdomen*.

Setelah minggu ke-16, tampak terjadi pembesaran *abdomen*. Karena *uterus* telah keluar dari rongga *pelvis* dan menjadi organ rongga perut.

h. Kontraksi *Uterus*.

Terjadi pengencangan otot perut akan tetapi tidak muncul merasa sakit

3. Tanda-Tanda Pasti Kehamilan.

a. Denyut Jantung Janin.

Dapat didengar pada usia 16 minggu dengan menggunakan alat *fetal electrocardiograf* (misalnya *dopler* atau stetoskop *laene*). USG memperjelas DJJ.

b. Bagian tubuh janin dan gerakan janin

Bagian-bagian janin dapat dideteksi dengan jelas setelah minggu ke-22 dengan palpasi, dan gerakan janin dapat terasa dengan jelas oleh ibu dan dilihat oleh tenaga kesehatan maupun keluarga. Bagian janin ini dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan USG dari awal kehamilan.

c. Tes Kehamilan Medis.

Pemeriksaan Tes urine dengan menggunakan *planotes* atau di laboratorium dengan mengambil sample darah (Prawirohardjo, 2013).

E. Usia dan Tahapan Perkembangan Janin

Usia dan tahapan perkembangan janin selama masa kehamilan terbagi ke dalam tiga fase yang berbeda, yaitu trimester pertama, trimester kedua dan trimester ketiga. Adapun penjelasan lengkap dari usia dan tahapan perkembangan janin selama kehamilan adalah sebagai berikut:

1. Trimester pertama (0-12 minggu) Trimester pertama kehamilan adalah masa ketika ibu mulai menunjukkan tanda-tanda umum, seperti morning sickness, mudah Lelah, dan kenaikan berat badan. Meski perubahan fisiknya masih belum terlihat jelas, pada fase ini, ibu telah mengalami perubahan kadar hormon yang signifikan. Tubuh juga akan mulai beradaptasi dengan menambah suplai darah untuk memberikan asupan oksigen dan nutrisi kepada zigot yang sedang berkembang. Selama tiga bulan pertama, zigot akan berubah menjadi embrio yang menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim untuk berkembang menjadi janin. Idealnya, janin pada fase ini akan memiliki berat sekitar 30 gram dengan Panjang mencapai 7,5 cm. Selain itu, pada tubuh janin juga akan mulai terbentuk berbagai organ tubuh seperti:
 - a. otak
 - b. sumsum tulang belakang
 - c. kepala, mata, hidung, dan mulut
 - d. jari tangan dan kaki
 - e. alat kelamin

Di trimester pertama ibu cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami keguguran. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi dan Kesehatan tubuh selama trimester pertama kehamilan.

2. Trimester kedua (13 -28 Minggu) Memasuki Trimester kedua, morning sicknes cenderung akan mereda dan menghilang namun ibu hamil dapat mengalami beberapa kondisi berikut ini;
 - a. Perut mulai membesar
 - b. Badan pegal-pegal
 - c. Nafsu makan meningkat
 - d. Munculnya stretch mark pada perut, paha, bokong, dan payudara
 - e. Kulit disekitar puting dan ketiak terlihat menggelap
 - f. Tekanan darah rendah

Trimester Kedua juga menjadi fase Ketika ibu hamil mulai merasakan janin bergerak untuk pertama kalinya. Umumnya, Gerakan janin tersebut akan dirasakan pada minggu ke 20 kehamilan. Disisi lain seluruh organ vital pada tubuh janin juga sudah berkembang penuh pada fase ini. Idealnya, berat janin pada trimester kedua akan mencapai 1 kg. selain itu, janin pada trimester ini juga sudah bisa mendengar suara ibu dan lingkungan sekitarnya.

3. Trimester Ketiga (29 - 40 Minggu) Pada fase ini tulang janin sudah terbentuk sempurna, janin juga sudah dapat menghisap ibu jari, membuka dan menutup mata, menendang, merespon Cahaya serta merenggangkan tubuh. Selain itu, memasuki bulan kedelapan pertumbuhan dan perkembangan otak pada janin akan berlangsung secara optimal. Umumnya, berat janin pada trimester ketiga ini telah mencapai 3 sampai 4 Kg. setelah memasuki minggu ke 36, paru-paru janin sudah terbentuk sempurna dan siap untuk bekerja sendiri. Pada masa ini, posisi kepala janin biasanya sudah turun dan memasuki jalan lahir. Pada trimester ketiga, ibu perlu melakukan sejumlah pemeriksaan Kesehatan secara rutin untuk mempersiapkan diri menuju proses persalinan. Beberapa prosedur pemeriksaan yang umum dilakukan adalah;
- a. Tes urin untuk mendeteksi kadar protein di dalam tubuh
 - b. Pemeriksaan tekanan darah
 - c. Pemantauan detak jantung janin 46 Kesehatan Reproduksi Sepanjang Daur Kehidupan Manusia
 - d. Pemeriksaan kadar gula darah
 - e. Pemeriksaan kehamilan dengan USG
 - f. Pemeriksaan berat badan ibu
 - g. Pemeriksaan amneiosentesis jika terdapat kecurigaan adanya kelainan bawaan, vibrosis kistik, atau spina divida pada janin (Wijayanti, Kartika dkk,2024).

F. Seksualitas Selama Hamil

Hubungan seksual mempunyai peranan dalam pernyataan perasaan kasih sayang, rasa aman dan tenang, kebersamaan, kedekatan dalam hubungan suami istri tapi jangan menjadikan hubungan seks memegang peranan paling berkuasa dalam keselarasan hubungan suami istri. Pasangan suami istri dapat menyatakan perasaan kasih sayang dengan saling bertukar pikiran, berpelukan, atau pijatan tanpa harus melakukan hubungan seksual. Selain itu dapat mencari alternatif lain dengan mandi air hangat, makan malam, ataupun sama-sama membuat pasangan senang. Selama tidak ada larangan dari dokter kandungan dan kehamilan yang bearti tidak beresiko dapat melakukan hubungan seksual hingga menjelang persalinan. Karena tidak sedikit Wanita hamil justru merasakan kenikmatan dan kepuasan luar biasa

dibandingkan semasa tidak hamil. Bahkan Sebagian Wanita hamil mengaku dapat mencapai orgasme berulang kali dengan mudah. Hal ini dapat terjadi karena hormon Wanita dan hormon kehamilan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan perubahan pada sejumlah organ tubuh (Payudara dan organ kandungan) menjadi lebih sensitive dan responsive.

Banyak sekali perubahan fisik dan psikologis yang mempengaruhi gairah dan kenikmatan seksual, baik yang bersifat positive maupun negative. Namun untuk beberapa faktor membuat pasangan harus membiasakan diri dengan keadaan tersebut yaitu:

1. Kondisi fisik

- a. Mual dan muntah pada waktu hamil mudah
- b. Keletihan yang biasanya terjadi pada trimester kedua
- c. Perubahan bentuk fisik tubuh, perut buncit, kaki bengkak dan wajah sembab
- d. Menyempitnya vagina dapat menyebabkan seks kurang memuaskan (terutama pada waktu hamil tua)
- e. Kebocoran kolostrum,
- f. Perubahan pada cairan vagina
- g. Perdarahan yang disebabkan oleh kepekaan leher rahim

2. Kondisi psikologis

- a. Takut menyakiti janin atau menyebabkan keguguran
- b. Takut bahwa orgasme akan merangsang terjadinya keguguran atau persalinan dini
- c. Takut terjadi infeksi pada saat penis masuk kedalam vagina
- d. Kecemasan akan peristiwa persalinan yang akan datang
- e. Kemarahan yang tidak didasari dari calon ayah terhadap ibu
- f. Takut menyakiti janin, Ketika kepala janin sudah turun kerongga panggul (Waluyo D.,Fitriani dkk, 2022)

G. Tanda-Tanda dan Tahapan Persalinan

Ada sejumlah tanda dan gejala peringatan yang akan meningkatkan kesiagaan bahwa seorang wanita sedang mendekati waktu bersalin. Bidan maupun dokter dianjurkan memberikan pendidikan kesehatan dan konseling terkait dengan tanda-tanda persalinan agar ibu dan keluarga mengingatkannya dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika salah satu tanda ini muncul pada ibu. Beberapa tanda akan diketahui ketika ibu memeriksakan diri ke bidan atau dokter dan beberapa lainnya dirasakan oleh ibu menjelang persalinan.

Tanda dan gejala menjelang persalinan sebagai berikut:

1. Lightening atau Settling atau dropping yaitu masuknya kepala pada pintu atas panggul, terutama primigravida, sedangkan pada multigravida belum dapat dibuktikan secara evidence. Sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman yang lain akibat tekanan pada bagian presentasi pada struktur di area pelvis minor.
2. Perut terlihat lebih melebar, fundus uteri turun Polakisuria yaitu sering buang air kecil atau berkemih karena kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin. Pada kasus ini terjadi pada akhir bulan ke9 hasil pemeriksaan epigastrium kendor, dan kepala janin sudah mulai masuk ke dalam pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing.
3. False Labor Pains yaitu perasaan nyeri diperut dan pinggang serta adanya beberapa kontraksi lemah uterus yang dikenal dengan kontraksi palsu. Kontraksi pada persalinan palsu sebenarnya timbul akibat kontraksi braxton hicks yang tidak nyeri, yang telah terjadi sejak sekitar enam minggu kehamilan. Persalinan palsu dapat terjadi selama sehari – hari atau secara intermiten bahkan tiga atau empat minggu sebelum awitan persalinan terjadi.
4. Bloody Show yaitu Servik menjadi lembek, mulai mendatar, dan sekresinya bertambah, mungkin dapat bercampur darah. Plak lendir disekresikan sebagai hasil proliferasi kelenjar lendir serviks pada awal kehamilan. (Dharmayanti, et al, 2019)

Setelah tanda – tanda tersebut muncul, tanda inpartu yang akan terjadi mencakup:

1. Rasa nyeri akibat adanya kontraksi yang datang akan terasa lebih kuat, sering, dan teratur.
2. Keluar lendir bercampur darah (bloody Show) dalam jumlah yang lebih banyak.
3. Kadang ketuban pecah dengan sendirinya.
4. Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada pembukaan.

Jika tanda inpartu poin 1-3, salah satunya dirasakan oleh ibu di rumah maka dianjurkan untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan bersama keluarga, dan mempersiapkan diri untuk proses persalinan (Diki Retno, 2021).

Tahapan Persalinan yang akan dialami oleh setiap wanita sebagai berikut:

1. Kala I persalinan Tahapan proses ini dibagi menjadi tiga fase berikut:
 - a. Fase Laten, berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai dengan pembukaan mencapai ukuran diameter 3 cm
 - b. Fase Aktif, yang dimana dibagi menjadi 3 fase yaitu:
 - 1) Fase Akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.
 - 2) Fase Dilatasi Maksimal, dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm sampai 9 cm
 - 3) Fase Diselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm sampai 10 cm.

2. Kala II Tahap ini dimulai pada dilatasi serviks. Pada kala II ini merupakan periode persalinan yang dimulai pembukaan lengkap (10 cm) sampai lahirnya bayi. Kala II ini umumnya berlangsung 2 jam untuk primipara dan 1 jam untuk multipara. Saat ini ibu sudah mulai merasakan keinginan untuk meneran yang tidak terkendali, dikarenakan sudah ada tanda gejala dorongan ingin meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka lebar.
3. Kala III Tahap ini merupakan periode persalinan yang dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Pada Kala III ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit.
4. Kala IV Tahap ini merupakan tahap akhir proses persalinan dimana merupakan masa persalinan yang dimana tahap pada masa setelah pengeluaran plasenta hingga 2 jam. Observasi yang harus dilakukan pada kala IV yaitu dengan melakukan pengecekan tingkat kesadaran ibu bersalin, pemeriksaan TTV, kontraksi uterus, memantau terjadinya perdarahan (Astuti dkk,2024).

H. Asuhan Sayang Ibu Dalam Proses Persalinan

Asuhan Sayang Ibu Dalam Proses Persalinan Asuhan sayang ibu dalam proses persalinan yang harus diperhatikan para bidan, antara lain:

1. Suami, saudara atau keluarga lainnya harus diperkenankan untuk mendampingi ibu selama proses persalinan.
2. Standar untuk persalinan yang bersih harus selalu dipertahankan.
3. Kontak segera antara ibu dan bayi serta pemberian air susu ibu dianjurkan untuk dikerjakan.
4. Penolong persalinan harus bersikap sopan dan penuh pengertian
5. Penolong persalinan harus mau mendengarkan dan memberi jawaban atas keluhan maupun kebutuhan ibu.
6. Penolong persalinan harus cukup mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan mengenai hal hal yang biasa dilakukan selama proses persalinan maupun pemilihan posisi saat melahirkan.
7. Tindakan tindakan yang secara tradisional sering dilakukan dan sudah terbukti tidak berbahaya harus diperbolehkan bila harus dilakukan.
8. Ibu harus diberi privasi bila ibu menginginkan.
9. Tindakan tindakan medis yang rutin dikerjakan dan ternyata tidak perlu dan harus dihindari. (Wijayanti dkk,2024))

I. Persiapan Persalinan

Hal – Hal Yang Perlu Diketahui Dalam Persiapan Persalinan oleh ibu dan keluarga yaitu :

1. Persiapan fisik

Persiapan persalinan meliputi kesiapan kondisi kesehatan ibu, meliputi kesiapan hal – hal yang berkaitan dengan perubahan fisiologi selama hamil sampai menjelang persalinan. Pengaturan kebutuhan nutrisi saat kehamilan, serta upaya perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Tetap melakukan aktivitas seperti berjalan pagi, atau kegiatan rumah lainnya dan istirahat yang cukup.

2. Persiapan Psikologis

Salah satu yang harus dipersiapkan ibu menjelang persalinan yaitu hindari kepanikan dan ketakutan dan harus bersikap tenang, dimana ibu hamil dapat melalui saat – saat persalinan dengan baik dan lebih siap serta meminta dukungan dari orang – orang terdekat. Perasaan takut dalam persalinan dapat diatasi dengan meminta keluarga atau suami untuk memberikan sentuhan kasih sayang, meyakinkan ibu bahwa persalinan dapat berjalan lancar, mengikutsertakan keluarga untuk memberikan dorongan moril, cepat tanggap keluhan ibu.

3. Persiapan Finansial

Persiapan finansial bagi ibu yang akan melahirkan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak harus disiapkan, dimana berkaitan dengan penghasilan atau keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan seperti menyiapkan biaya persalinan, menyiapkan popok bayi dan perlengkapan lainnya. Menyiapkan pendonor darah ketika dibutuhkan transfusi darah setekah persalinan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan disiapkan.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan saat persiapan persalinan yaitu:

1. Memilih klinik atau rumah bersalin yang memiliki fasilitas rujukan ke rumah sakit yang lebih besar dan juga memiliki mobil ambulans ke rumah sakit rujukan.
2. Rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap, seperti ICU dan NICU.
3. Usahakan agar jarak tempat melahirkan dengan tempat tinggal tidak terlalu jauh.
4. Pada saat akan persalinan barang yang perlu dibawah pakaian secukupnya untuk ibu dan bayi(Waluyo dkk,2022).

J. Masalah Kesehatan Reproduksi Selama Hamil

Berikut ini beberapa masalah pada kesehatan seksual dan reproduksi perempuan saat mengandung, yaitu:

1. Peningkatan Keputihan

Peningkatan keputihan adalah salah satu perubahan vagina yang paling terlihat selama kehamilan. Ini disebabkan oleh tingginya kadar estrogen dan progesteron. Peningkatan volume darah dan aliran darah juga dapat berkontribusi pada peningkatan keputihan. Keputihan yang muncul biasanya encer dan putih layaknya susu. Akan tetapi, saat menjelang kelahiran bayi, keputihan itu meningkat dan tidak berbau busuk.

2. Meningkatnya resiko infeksi vagina

Infeksi vagina sering terjadi pada kehamilan, Sebagian karena perubahan hormonal yang mengubah keseimbangan pH Vagina. Infeksi vagina yang umum selama kehamilan meliputi ;

- a. Infeksi ragi Selama kehamilan, cairan vagina mengandung lebih banyak gula. Infeksi ini tidak akan membahayakan bayi yang belum lahir, tetapi akan membuat ibu hamil tidak nyaman. Gejala infeksi Ragi atau jamur yaitu gatal pada vagina, keputihan yang menyerupai keju dan berbau ragi dan vagina terasa terbakar.
- b. Vagina sisbakterial Kodisi ini disebabkan oleh ketidak seimbangan bakteri baik dan buruk pada vagina. Gejala utama adalah keluarnya cairan berwarna abu-abu yang berbau amis. Apabila tidak diobati akan menyebabkan persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan keguguran.
- c. Trikomoniasis. Infeksi ini ditularkan melalui hubungan seks dengan orang yang terinfeksi. Ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan yang serius, seperti ketuban pecah dini (KPD) dan kelahiran premature. Gejala trikomoniasis seperti bau busuk, cairan kuning hijau, gatal dan kemerahan pada vagina dan nyeri saat buang air kecil dan saat berhubungan seks.

3. Peningkatan pembengkakan vagina

Pembengkakan dan peningkatan aliran darah juga dapat meningkatkan libido dan membuat seseorang lebih mudah terangsang. Perubahan hormonal dan peningkatan aliran darah juga dapat menyebabkan Vagina dan labia menjadi gelap dan berwarna kebiruan.

4. Varises Vulva

Varises vulva dapat menyebabkan tekanan dan ketidaknyamanan pada vulva dan vagina. Untuk mengatasi varises vulva tersebut dengan melakukan kompres

air dingin, mengangkat pinggul saat berbaring dan mengenakan pakaian. (Wijayanti, Susanti dkk,2024)

K. Masalah Kesehatan Reproduksi Selama Persalinan

Masalah kesehatan reproduksi masa persalinan meliputi komplikasi serius yang sering memicu morbiditas dan mortalitas ibu/bayi. Hal ini dapat diminimalkan dengan manajemen persalinan yang tepat. Berikut beberapa masalah selama masa persalinan:

1. Perdarahan: Merupakan penyebab utama kematian ibu, baik saat hamil tua (antepartum, 40,6%) maupun setelah melahirkan (postpartum, 41,2%). Penyebab utama perdarahan saat persalinan antara lain:
 - a) Atonia uteri: Rahim tidak berkontraksi dengan baik untuk menutup pembuluh darah setelah plasenta keluar.
 - b) Retensio plasenta: Sebagian atau seluruh plasenta tertinggal di dalam rahim.
 - c) Robekan jalan lahir: Cedera pada rahim, serviks, atau vagina.
 - d) Masalah pembekuan darah: Kondisi bawaan atau komplikasi kehamilan seperti preeklamsia.

Penanganan medis dilakukan sesuai dengan kasus yang terjadidan kondisi ibu berupa masase uterus, penggunaan obat-obatan, tranfusi darah bahkan sampai ke prosedur operasi.

2. Hipertensi dalam Kehamilan (Preeklampsia/Eklampsia): Pemicu sekitar 32,3% kasus gawat darurat ibu bersalin. Peningkatan tekanan darah pada kehamilan dapat terdeteksi dengan melakukan pemeriksaan rutin (ANC) dan ibu perlu mewaspadaai apabila merasakan sakit kepala yang hebat dan menetap, pandangan kabur/ berkunang-kunang, nyeri ulu hati, bengkak pada kaki-tangan-wajah, mual muntah yang berlebihan dan peningkatan berat badan secara drastis.
3. Partus lama dan macet: Persalinan yang berlangsung lama (kala I/II) (>24 jam primi/>18 jam multi) dan partus tak maju (tidak ada pembukaan/penurunan kepala >2 jam). Hal ini berisiko menyebabkan infeksi, kelelahan ibu, serta asfiksia janin. Penyebab utamanya adalah gangguan kontraksi (power), ukuran janin besar/posisi salah (passenger), atau panggul sempit (passage).
4. Infeksi/ Ketuban Pecah Dini: robeknya selaput ketuban sebelum kontraksi persalinan dimulai, seringkali dipicu oleh infeksi saluran kemih atau vagina. Kondisi ini berisiko tinggi menyebabkan infeksi pada ibu (korioamnionitis) dan janin, serta kelahiran prematur. Hal ini dapat diketahui ibu dengan keluarnya air dari vagina.

5. Gangguan pada janin (Asfiksia): Kekurangan oksigen pada janin saat proses persalinan sehingga bayi mengalami kegagalan bernafas secara spontan dan teratur setelah dilahirkan.

Ada beberapa faktor Risiko dan Kondisi Terkait yang memperparah kondisi ibu, antara lain :

1. Terlambat (3T) : Terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan medis.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja: Hamil di usia muda meningkatkan risiko perdarahan, kelahiran prematur, dan BBLR.
3. Masalah Psikologis: Perubahan hormonal yang drastis pasca melahirkan memicu stres dan depresi.
4. Komplikasi Non-Obstetri: Penyakit lain yang sudah ada sebelum kehamilan atau muncul selama hamil yang tidak terkait langsung dengan kebidanan tapi mengganggu proses persalinan seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan obesitas (Wijayanti K., Susanti R, dkk, 2024).

L. Peran Ibu Dalam Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi

Menjaga kesehatan organ reproduksi selama kehamilan berarti memberikan perhatian ekstra pada tubuh agar proses kehamilan berjalan lancar dan minim risiko. Berikut beberapa hal yang dianjurkan dilakukan oleh ibu selama kehamilan:

1. Menjaga Kebersihan Area Kewanitaan

Perubahan hormon selama kehamilan bisa membuat area kewanitaan lebih rentan terhadap infeksi, seperti infeksi jamur atau bakteri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan area ini dengan menggunakan air bersih dan menghindari penggunaan sabun yang mengandung bahan kimia keras. Memakai pakaian dalam berbahan katun juga membantu menjaga area tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.

2. Pemeriksaan Rutin ke Dokter Kandungan

Pemeriksaan antenatal secara berkala wajib dilakukan. Lewat pemeriksaan ini, dokter dapat memantau kondisi rahim, serviks, dan organ reproduksi lainnya. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) juga membantu mendeteksi adanya kelainan pada janin atau organ reproduksi sejak dini, sehingga tindakan medis bisa segera dilakukan jika diperlukan.

3. Nutrisi Seimbang untuk Kesehatan Reproduksi

Asupan nutrisi selama kehamilan sangat berpengaruh pada kesehatan organ reproduksi. Nutrisi seperti asam folat, zat besi, kalsium, dan protein sangat penting. Asam folat membantu mencegah cacat tabung saraf pada bayi. Zat besi mendukung produksi sel darah merah tambahan yang dibutuhkan untuk

mendukung kehamilan. Konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sumber protein rendah lemak harus menjadi bagian dari pola makan harian.

4. Cegah dan Atasi Infeksi Sejak Dini

Infeksi saluran kemih atau infeksi vagina selama kehamilan bisa memicu komplikasi, seperti kelahiran prematur. Segera konsultasikan ke dokter jika ibu mengalami gejala seperti rasa panas saat buang air kecil, keputihan berbau, atau rasa tidak nyaman di area panggul. Penanganan dini membantu mencegah infeksi menyebar ke organ reproduksi.

5. Jaga Kesehatan Serviks

Serviks yang sehat sangat penting dalam mempertahankan kehamilan. Pada beberapa kasus, serviks yang lemah bisa menyebabkan kelahiran prematur. Melakukan pemeriksaan leher rahim secara rutin dan mengikuti saran dokter terkait aktivitas fisik dapat membantu mencegah masalah pada serviks.

6. Hindari Hubungan Seksual Berisiko

Selama kehamilan, terutama pada trimester pertama dan terakhir, penting untuk berhati-hati dalam berhubungan seksual. Konsultasikan dengan dokter mengenai keamanan aktivitas seksual, terutama jika kehamilan tergolong berisiko tinggi. Hubungan seksual yang aman dapat mencegah risiko infeksi atau komplikasi lainnya.

7. Kelola Stres dengan Baik

Stres berlebihan bisa berdampak buruk pada kesehatan organ reproduksi dan kehamilan secara keseluruhan. Ibu dianjurkan untuk melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga prenatal, atau berjalan santai di luar ruangan. Mengelola stres dengan baik akan mendukung keseimbangan hormon yang dibutuhkan untuk kehamilan sehat.

8. Cukup Istirahat dan Aktivitas Fisik Teratur

Istirahat yang cukup sangat diperlukan agar tubuh bisa melakukan regenerasi sel dengan optimal, termasuk pada organ reproduksi. Selain itu, olahraga ringan seperti senam hamil, jalan kaki, atau berenang dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot panggul, dan membantu menjaga kesehatan rahim.

Menjaga kesehatan organ reproduksi selama kehamilan membutuhkan kombinasi antara kebersihan pribadi, nutrisi yang tepat, pemeriksaan rutin, serta gaya hidup sehat. Dengan perhatian yang baik terhadap tubuh sendiri, ibu hamil tidak hanya mendukung pertumbuhan janin secara optimal, tetapi juga menjaga dirinya tetap sehat hingga masa persalinan tiba. Mulailah dari langkah-langkah kecil

hari ini untuk memastikan kehamilan yang aman dan menyenangkan (columbia Asia, 2025).

M. Penutup

Kesehatan reproduksi dalam kehamilan dan persalinan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam sistem reproduksi, di mana fokus utamanya adalah pemantauan ketat untuk mendeteksi dini komplikasi. Kesehatan reproduksi dalam kehamilan dan persalinan menekankan pentingnya asuhan berkesinambungan (*continuity of care*) untuk mencegah komplikasi, deteksi dini risiko, dan peningkatan kualitas hidup ibu serta janin. Fokus utamanya adalah persiapan kehamilan dan persalinan aman untuk menjaga kesehatan reproduksi jangka panjang. Kepatuhan ANC (Antenatal Care), dukungan keluarga, serta pelayanan kesehatan berkualitas krusial untuk mencegah komplikasi.

Pelayanan antenatal minimal 6 kali selama kehamilan yang sesuai standar tidak hanya untuk mendeteksi dini komplikasi pada ibu dan janin tetapi menjadi wadah dalam pelaksanaan program seperti Kelas Ibu Hamil, yang efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan tanda bahaya kehamilan, mempersiapkan persalinan secara fisik, mental dan finansial berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan reproduksi. Tenaga kesehatan melakukan pertolongan persalinan sesuai standar dan penerapan asuhan sayang ibu meminimalkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Secara keseluruhan, peningkatan kesehatan reproduksi ibu hamil dan bersalin sangat bergantung pada kombinasi pelayanan kesehatan yang aksesibel, pengetahuan ibu, dan dukungan sosial.

Referensi

- Ani M, dkk (2023). DasarDasar Ilmu Kebidanan. Yayasan Kita Menulis.
- Ariana R., Rosaria R, dkk (2024). Isu Kesehatan Ibu dan Anak Dan Kesehatan Reproduksi. CV Bintang Semesta media. <https://repository.unsri.ac.id/152279/1/%5BEBOOK%5D%20ISU%20KESEHATAN%20IBU%20DAN%20ANAK%20DAN%20KESEHATAN%20REPRODUKSI.pdf>
- Artikel Columbia Asia (2025) .<https://columbiaasia.co.id/artikel/kesehatan-organ-reproduksi-di-masa-kehamilan-apa-yang-perlu-dijaga/>
- Astuti ED., Situmorang K, dkk (2024). Asuhan Kebidanan Pada Kesehatan Reproduksi. Yayasan Kita Menulis.
- Darwiten YN. (2019). Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. CV Andi Offset.

- Dharmayanti, I. et al. (2019) 'Pelayanan pemeriksaan kehamilan berkualitas yang dimanfaatkan ibu hamil untuk persiapan persalinan di Indonesia', *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 18(1), pp. 60–69.
- Diki Retno, D., (2021). Asuhan Kehamilan. yayasan kita menulis.
- Kemenkes RI (2020). Standar Profesi Bidan
- Manuaba, I. A. (2010). *ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan kb*. Buku kedokteran EGC.
- Prawirohardjo, S (2013). Ilmu Kebidanan. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Ugmsehat (2023) Kesehatan Reproduksi. Available at: <https://hu.ugm.ac.id/kesehatan-reproduksi/#:text=kesehatan reproduksi menurut World Health,reproduksi%2C fungsi%2C serta prosesnya>.
- Waluyo D., Fitriani, dkk (2022). Pengantar Kesehatan Reproduksi Wanita. Eureka Media Aksara.
<https://sipuswita.mojokertokab.go.id/upload/file/PengantarKesehatanReproduksiWanita.pdf>
- Wijayanti K., Susanti R, dkk (2024). Kesehatan Reproduksi Sepanjang Daur kehidupan Manusia. Nuansa Fajar Cemerlang.
<https://media.neliti.com/media/publications/586317-kesehatan-reproduksi-sepanjang-daur-kehi-e39757b6.pdf>

BAB IV

MASA NIFAS DAN LAKTASI

A. Pendahuluan

Masa nifas merupakan periode setelah persalinan yang dimulai sejak lahirnya plasenta hingga sekitar enam minggu postpartum. Periode ini merupakan fase penting dalam kesehatan reproduksi perempuan karena tubuh mengalami proses pemulihan fisiologis yang kompleks setelah kehamilan dan persalinan. Proses pemulihan tersebut meliputi involusi uterus, perubahan hormonal, adaptasi sistem kardiovaskular, serta pemulihan berbagai fungsi organ tubuh yang mengalami perubahan selama masa kehamilan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan membutuhkan pemantauan yang adekuat untuk memastikan bahwa kondisi ibu kembali ke keadaan fisiologis sebelum kehamilan. Pemantauan kesehatan selama masa nifas menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan maternal untuk mencegah komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi (Cunningham et al., 2022).

Masa nifas juga merupakan periode kritis dalam kesehatan ibu karena sebagian besar komplikasi maternal dapat terjadi setelah persalinan. Laporan global menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga kematian ibu terjadi pada periode postpartum, terutama dalam minggu pertama setelah persalinan. Kondisi seperti perdarahan postpartum, infeksi puerperium, gangguan hipertensi postpartum, serta tromboemboli merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal pada periode tersebut (Say et al., 2019). Risiko tersebut menunjukkan bahwa masa nifas tidak dapat dipandang sebagai periode pemulihan pasif, melainkan sebagai fase penting yang membutuhkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat.

Perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas tidak hanya berkaitan dengan sistem reproduksi, tetapi juga melibatkan berbagai sistem tubuh lainnya. Sistem kardiovaskular mengalami penyesuaian terhadap perubahan volume darah setelah persalinan. Sistem endokrin mengalami perubahan hormonal yang signifikan akibat penurunan hormon estrogen dan progesteron serta peningkatan hormon prolaktin yang berperan dalam proses laktasi. Sistem muskuloskeletal juga mengalami adaptasi setelah kehamilan dan persalinan. Perubahan tersebut

menunjukkan bahwa masa nifas merupakan fase adaptasi fisiologis yang kompleks dalam kehidupan reproduksi perempuan (Marshall & Raynor, 2021).

Masa nifas juga memiliki hubungan yang erat dengan proses laktasi. Laktasi merupakan proses fisiologis produksi dan pengeluaran air susu ibu yang dimulai segera setelah persalinan. Air susu ibu merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi pada awal kehidupan karena mengandung zat gizi lengkap, antibodi, serta berbagai komponen bioaktif yang mendukung perkembangan sistem imun bayi. Komponen imunologis dalam ASI seperti imunoglobulin A, laktoferin, dan oligosakarida memiliki peran penting dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi pada masa awal kehidupan (Victoria et al., 2016).

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan telah direkomendasikan oleh berbagai organisasi kesehatan dunia karena terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan bayi. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan, diare, serta berbagai penyakit kronis pada masa dewasa. Pemberian ASI juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu karena dapat membantu mempercepat involusi uterus, mengurangi risiko perdarahan postpartum, serta menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium (Rollins et al., 2016).

Perkembangan ilmu kebidanan modern menekankan pentingnya penerapan evidence-based practice dalam pelayanan kesehatan ibu pada masa nifas. Evidence-based practice merupakan pendekatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada pasien didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat (Renfrew et al., 2014).

Penerapan praktik berbasis bukti dalam pelayanan masa nifas mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pemantauan kondisi ibu dilakukan secara sistematis melalui pemeriksaan tanda vital, penilaian involusi uterus, serta pemantauan tanda bahaya postpartum. Dukungan terhadap proses menyusui juga menjadi bagian penting dari pelayanan nifas berbasis bukti karena keberhasilan menyusui memiliki dampak besar terhadap kesehatan ibu dan bayi. Konseling menyusui, dukungan keluarga, serta pendidikan kesehatan kepada ibu menjadi komponen penting dalam meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Pembaruan kebijakan global dalam kesehatan maternal juga menekankan pentingnya pelayanan masa nifas yang berpusat pada perempuan dan keluarga. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan pendekatan pelayanan nifas yang komprehensif dan berkesinambungan yang mencakup pemantauan kondisi ibu dan

bayi, dukungan menyusui, konseling kesehatan reproduksi, serta deteksi dini gangguan kesehatan mental pada ibu. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan pengalaman postpartum yang positif bagi perempuan serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi (World Health Organization, 2022).

Perkembangan ilmu kebidanan juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental ibu pada masa nifas. Perubahan hormonal yang terjadi setelah persalinan, kelelahan fisik, serta adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu dapat memengaruhi kondisi emosional perempuan pada periode postpartum. Gangguan psikologis seperti postpartum blues, depresi postpartum, dan kecemasan postpartum dapat terjadi apabila ibu tidak memperoleh dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi hubungan ibu dengan bayi serta keberhasilan proses menyusui (Stewart & Vigod, 2019).

Pendekatan pelayanan kesehatan maternal modern juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu pada masa nifas. Dukungan keluarga memiliki peran penting dalam membantu ibu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi setelah persalinan. Edukasi kepada keluarga mengenai perawatan ibu dan bayi, pentingnya menyusui, serta tanda bahaya masa nifas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pemahaman yang baik mengenai masa nifas dan proses laktasi memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan anak. Pengetahuan mengenai perawatan masa nifas, dukungan terhadap pemberian ASI, serta deteksi dini komplikasi postpartum dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi. Upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan maternal juga berperan penting dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas generasi masa depan.

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai masa nifas dan laktasi sebagai bagian dari kesehatan reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupan. Pembahasan mencakup perubahan fisiologis pada masa nifas, mekanisme dan proses laktasi, manfaat pemberian air susu ibu, serta berbagai permasalahan yang dapat terjadi selama masa nifas dan menyusui. Pemahaman terhadap aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan di masyarakat.

B. Konsep Masa Nifas dalam Kesehatan Reproduksi

Masa nifas merupakan salah satu fase penting dalam siklus kehidupan reproduksi perempuan yang dimulai sejak lahirnya plasenta hingga sekitar enam minggu setelah persalinan. Periode ini sering disebut sebagai periode postpartum, yaitu fase transisi biologis dan psikososial yang ditandai dengan proses pemulihan fisiologis tubuh ibu setelah kehamilan dan persalinan. Proses pemulihan tersebut meliputi kembalinya fungsi organ reproduksi, penyesuaian sistem hormonal, serta adaptasi psikologis terhadap peran baru sebagai ibu. Masa nifas tidak hanya merupakan fase pemulihan fisiologis, tetapi juga merupakan periode penting dalam menjaga kesejahteraan ibu dan bayi serta membangun hubungan awal antara ibu dan bayi melalui proses perawatan dan menyusui (Cunningham et al., 2022).

Konsep masa nifas dalam kesehatan reproduksi modern tidak dapat dipisahkan dari pendekatan *continuum of care* dalam pelayanan kesehatan maternal. Pendekatan ini menempatkan kesehatan perempuan sebagai suatu rangkaian yang berkelanjutan mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga periode kehidupan selanjutnya. Masa nifas menjadi bagian penting dari rangkaian tersebut karena kondisi kesehatan ibu pada periode ini sangat menentukan kesehatan jangka panjang ibu dan bayi. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sepanjang siklus reproduksi perempuan terbukti dapat meningkatkan kualitas kesehatan maternal dan neonatal secara signifikan (World Health Organization, 2022).

Kajian global menunjukkan bahwa masa nifas merupakan periode yang memiliki kerentanan tinggi terhadap komplikasi kesehatan ibu. Analisis epidemiologi maternal menunjukkan bahwa sebagian besar komplikasi maternal terjadi pada periode postpartum, terutama dalam beberapa minggu pertama setelah persalinan. Kondisi seperti perdarahan postpartum, infeksi puerperium, gangguan hipertensi postpartum, serta tromboemboli menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal di berbagai negara (Say et al., 2019). Situasi tersebut menunjukkan bahwa masa nifas memerlukan perhatian yang sama besar dengan masa kehamilan dan persalinan dalam pelayanan kesehatan maternal.

Konsep kesehatan reproduksi yang berkembang saat ini menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan kesehatan (*woman-centered care*). Pendekatan ini menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang menghargai pengalaman, kebutuhan, serta preferensi perempuan selama masa nifas. Pelayanan kesehatan yang berpusat pada perempuan tidak hanya mencakup pemantauan kondisi fisik ibu, tetapi juga mencakup dukungan emosional, konseling kesehatan reproduksi, serta perhatian terhadap kesehatan mental ibu setelah persalinan.

Pendekatan tersebut dianggap sebagai strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal secara global (Renfrew et al., 2014).

Masa nifas juga memiliki keterkaitan yang erat dengan proses laktasi. Laktasi merupakan proses biologis produksi dan pengeluaran air susu ibu yang dimulai segera setelah persalinan sebagai respons terhadap perubahan hormonal dalam tubuh ibu. Air susu ibu merupakan sumber nutrisi optimal bagi bayi karena mengandung berbagai zat gizi penting serta komponen imunologis yang berperan dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Komponen bioaktif dalam ASI seperti imunoglobulin, laktoferin, dan oligosakarida berperan dalam meningkatkan sistem imun bayi serta mendukung perkembangan mikrobiota usus yang sehat (Victora et al., 2016).

Manfaat pemberian ASI tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu. Proses menyusui dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin yang berperan dalam kontraksi uterus sehingga mempercepat proses involusi uterus setelah persalinan. Menyusui juga dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai penyakit kronis pada ibu, termasuk kanker payudara, kanker ovarium, serta penyakit metabolik. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa praktik menyusui yang optimal memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak dalam jangka panjang (Rollins et al., 2016).

Perkembangan ilmu kebidanan modern menekankan pentingnya penerapan praktik berbasis bukti (*evidence-based midwifery*) dalam pelayanan masa nifas. Evidence-based practice merupakan pendekatan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu pada masa nifas didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat serta memberikan manfaat optimal bagi ibu dan bayi (Renfrew et al., 2014).

Pelayanan masa nifas yang berbasis bukti mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan maternal. Pemantauan kondisi ibu dilakukan secara sistematis melalui pemeriksaan klinis untuk menilai proses pemulihan fisiologis setelah persalinan. Dukungan terhadap proses menyusui menjadi bagian penting dari pelayanan tersebut karena keberhasilan menyusui memiliki dampak besar terhadap kesehatan ibu dan bayi. Konseling kesehatan reproduksi pada masa nifas juga memiliki peran penting dalam membantu perempuan merencanakan kehamilan berikutnya secara sehat dan aman.

Perspektif kesehatan masyarakat juga menempatkan masa nifas sebagai periode strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan masa nifas, pentingnya

pemberian ASI eksklusif, serta tanda bahaya postpartum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan maternal menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi masa depan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Konteks sosial dan budaya juga memiliki pengaruh terhadap praktik perawatan ibu pada masa nifas. Berbagai masyarakat memiliki tradisi dan praktik tertentu dalam merawat ibu setelah persalinan. Praktik tersebut dapat memberikan manfaat apabila selaras dengan prinsip kesehatan, namun dapat menimbulkan risiko apabila tidak sesuai dengan prinsip ilmiah. Tenaga kesehatan perlu memahami konteks sosial budaya masyarakat agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh ibu dan keluarga (Fraser & Cooper, 2020).

Pemahaman mengenai konsep masa nifas dalam kesehatan reproduksi memberikan dasar penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada perempuan setelah persalinan. Pendekatan pelayanan yang holistik mencakup pemantauan kondisi fisiologis ibu, dukungan terhadap proses laktasi, perhatian terhadap kesehatan mental ibu, serta keterlibatan keluarga dalam proses perawatan ibu dan bayi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ibu secara optimal serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan.

C. Adaptasi Fisiologis pada Masa Nifas

Periode postpartum ditandai oleh serangkaian proses adaptasi biologis yang terjadi sebagai respons terhadap berakhirnya kehamilan dan proses persalinan. Adaptasi ini mencakup perubahan pada berbagai sistem tubuh yang sebelumnya mengalami modifikasi fisiologis selama kehamilan. Sistem reproduksi, endokrin, kardiovaskular, urinaria, serta metabolisme mengalami proses penyesuaian yang bertujuan mengembalikan keseimbangan fisiologis tubuh perempuan. Dinamika perubahan tersebut mencerminkan kemampuan tubuh untuk melakukan reorganisasi fungsi biologis setelah fase reproduksi yang intensif (Cunningham et al., 2022).

Transformasi terbesar setelah persalinan terjadi pada organ reproduksi, terutama uterus. Uterus yang selama kehamilan mengalami pembesaran hingga mencapai berat sekitar satu kilogram akan mengalami reduksi ukuran secara progresif hingga mendekati ukuran pra kehamilan. Mekanisme utama yang mendasari proses ini adalah kontraksi serabut otot miometrium yang menyebabkan kompresi pembuluh darah di tempat implantasi plasenta serta reorganisasi jaringan endometrium.

Proses pemulihan struktur uterus berlangsung melalui mekanisme autolisis sel-sel otot uterus yang membesar selama kehamilan. Aktivitas enzim proteolitik menyebabkan degradasi sebagian protein seluler sehingga ukuran sel miometrium berkurang secara bertahap. Proses tersebut memungkinkan uterus kembali mendekati kondisi fisiologis sebelum kehamilan dalam waktu beberapa minggu postpartum (Marshall & Raynor, 2021).

Regenerasi endometrium juga berlangsung secara progresif setelah pelepasan plasenta. Permukaan endometrium yang sebelumnya menjadi tempat implantasi plasenta mengalami proses penyembuhan jaringan melalui proliferasi sel epitel baru. Proses ini berkaitan dengan pengeluaran cairan uterus yang dikenal sebagai lochia, yang mencerminkan tahap pemulihan lapisan dalam uterus.

Perubahan hormonal yang terjadi setelah persalinan merupakan salah satu mekanisme fisiologis utama yang memengaruhi berbagai proses biologis pada masa nifas. Hilangnya plasenta sebagai sumber utama hormon estrogen dan progesteron menyebabkan penurunan tajam kedua hormon tersebut dalam sirkulasi maternal. Penurunan kadar hormon tersebut memicu aktivasi hormon prolaktin yang disekresikan oleh hipofisis anterior.

Prolaktin berperan dalam merangsang aktivitas sel alveolar pada jaringan payudara untuk memproduksi air susu ibu. Aktivitas prolaktin meningkat sebagai respons terhadap stimulasi hisapan bayi pada puting susu. Refleks neuroendokrin tersebut menunjukkan keterkaitan antara stimulasi mekanik pada payudara dengan regulasi hormonal dalam proses laktasi. Selain prolaktin, hormon oksitosin yang dilepaskan oleh hipofisis posterior memiliki peran penting dalam pengeluaran ASI. Hormon ini memicu kontraksi sel mioepitel pada alveoli payudara sehingga ASI dapat dikeluarkan melalui saluran laktiferus menuju puting susu. Mekanisme tersebut dikenal sebagai refleks pengeluaran ASI atau milk ejection reflex (Victora et al., 2016).

Sistem kardiovaskular mengalami reorganisasi signifikan setelah persalinan. Selama kehamilan, volume darah maternal meningkat secara substansial sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan metabolik ibu dan janin. Setelah persalinan, tubuh melakukan redistribusi cairan dan eliminasi volume darah berlebih untuk mengembalikan homeostasis sirkulasi. Penurunan volume plasma terjadi secara bertahap melalui peningkatan ekskresi cairan oleh ginjal. Mekanisme ini berkaitan dengan mobilisasi cairan ekstraseluler yang terakumulasi selama kehamilan. Adaptasi tersebut membantu mengembalikan tekanan darah dan fungsi hemodinamik ke kondisi fisiologis sebelum kehamilan (Fraser & Cooper, 2020).

Perubahan hemodinamik juga memengaruhi sistem koagulasi darah. Aktivitas koagulasi cenderung meningkat pada periode postpartum sebagai mekanisme

perlindungan terhadap perdarahan setelah persalinan. Kondisi hiperkoagulabilitas ini memiliki implikasi klinis karena dapat meningkatkan risiko tromboemboli pada sebagian perempuan dengan faktor risiko tertentu.

Fungsi ginjal dan saluran kemih mengalami perubahan adaptif pada periode postpartum. Peningkatan produksi urin sering terjadi pada hari-hari awal setelah persalinan sebagai bagian dari mekanisme pengeluaran cairan tubuh yang berlebih. Proses diuresis ini membantu tubuh mengeliminasi cairan yang sebelumnya terakumulasi selama kehamilan.

Perubahan fisiologis pada kandung kemih juga dapat terjadi akibat peregangan jaringan selama persalinan. Sensitivitas kandung kemih terhadap rangsangan pengisian dapat berkurang sementara waktu sehingga sebagian perempuan tidak segera merasakan dorongan untuk berkemih. Kondisi ini memerlukan perhatian klinis karena retensi urin dapat memengaruhi kontraksi uterus serta meningkatkan risiko komplikasi postpartum (Cunningham et al., 2022).

Perubahan metabolisme tubuh perempuan setelah persalinan berkaitan erat dengan kebutuhan energi untuk pemulihan jaringan serta produksi air susu ibu. Proses laktasi membutuhkan energi tambahan yang berasal dari cadangan lemak tubuh yang terakumulasi selama kehamilan. Aktivitas metabolik tersebut memungkinkan tubuh menyediakan nutrisi yang diperlukan bagi bayi melalui ASI.

Peningkatan kebutuhan energi pada ibu menyusui menuntut keseimbangan nutrisi yang adekuat. Asupan protein, vitamin, mineral, serta cairan yang cukup menjadi faktor penting dalam mempertahankan produksi ASI yang optimal. Kondisi nutrisi ibu memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas dan kuantitas air susu yang dihasilkan (Rollins et al., 2016).

Pemahaman mengenai adaptasi fisiologis postpartum memiliki implikasi penting dalam praktik kebidanan dan kesehatan maternal. Pengetahuan mengenai perubahan biologis yang terjadi setelah persalinan memungkinkan tenaga kesehatan melakukan interpretasi klinis yang tepat terhadap kondisi ibu pada periode postpartum.

Pendekatan pelayanan kesehatan maternal modern menekankan pentingnya pemantauan komprehensif terhadap kondisi fisiologis ibu setelah persalinan. Pemantauan tersebut tidak hanya berfokus pada sistem reproduksi, tetapi juga mencakup berbagai sistem tubuh lainnya yang mengalami adaptasi selama masa nifas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan maternal berbasis bukti yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi (World Health Organization, 2022).

D. Adaptasi Psikologis dan Sosial Postpartum

Periode postpartum tidak hanya ditandai oleh perubahan biologis, tetapi juga oleh proses adaptasi psikologis dan sosial yang kompleks. Setelah persalinan, perempuan memasuki fase transisi kehidupan yang melibatkan perubahan identitas, peran sosial, serta dinamika hubungan dalam keluarga. Adaptasi tersebut berkaitan dengan pengalaman emosional ibu, pembentukan ikatan dengan bayi, serta penyesuaian terhadap tanggung jawab baru dalam merawat dan membesarkan anak. Dinamika psikologis yang terjadi pada masa ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman postpartum seorang perempuan (Stewart & Vigod, 2019).

Perubahan hormonal yang terjadi setelah persalinan berkontribusi terhadap fluktuasi emosional pada perempuan postpartum. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang terjadi segera setelah lahirnya plasenta dapat memengaruhi regulasi neurotransmitter dalam sistem saraf pusat yang berkaitan dengan stabilitas suasana hati. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan emosi seperti perasaan sensitif, mudah menangis, atau perubahan suasana hati yang cepat pada hari-hari awal setelah persalinan. Fenomena tersebut sering dikenal sebagai postpartum blues, yaitu kondisi emosional ringan yang umumnya muncul dalam beberapa hari pertama postpartum dan biasanya bersifat sementara (O'Hara & McCabe, 2013).

Adaptasi psikologis postpartum juga berkaitan dengan proses pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Ikatan emosional tersebut sering disebut sebagai maternal bonding, yaitu hubungan emosional yang berkembang antara ibu dan bayi melalui interaksi awal setelah kelahiran. Interaksi tersebut meliputi kontak kulit antara ibu dan bayi, aktivitas menyusui, serta respons ibu terhadap kebutuhan bayi. Pembentukan ikatan ini memiliki peran penting dalam perkembangan emosional dan sosial bayi pada masa awal kehidupan (Feldman, 2017).

Selain perubahan emosional ringan, sebagian perempuan dapat mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih serius setelah persalinan. Depresi postpartum merupakan salah satu gangguan psikologis yang paling sering terjadi pada periode postpartum. Kondisi ini ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, kelelahan yang berlebihan, serta kesulitan dalam menjalin hubungan emosional dengan bayi. Depresi postpartum dapat memengaruhi kesejahteraan ibu serta perkembangan emosional dan kognitif bayi apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat (Stewart & Vigod, 2019).

Kecemasan postpartum juga menjadi salah satu bentuk gangguan psikologis yang dapat dialami oleh ibu setelah persalinan. Perasaan cemas sering berkaitan

dengan kekhawatiran mengenai kemampuan merawat bayi, kesehatan bayi, atau perubahan dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas tidur ibu serta kemampuan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Pendekatan pelayanan kesehatan maternal modern menekankan pentingnya skrining kesehatan mental ibu pada masa postpartum untuk mendeteksi secara dini gangguan psikologis yang mungkin terjadi (World Health Organization, 2022).

Dimensi sosial juga memiliki peran penting dalam proses adaptasi postpartum. Perubahan struktur kehidupan keluarga setelah kelahiran bayi dapat memengaruhi hubungan interpersonal antara ibu, pasangan, serta anggota keluarga lainnya. Kehadiran bayi sering kali membawa perubahan dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dukungan emosional dan praktis dari pasangan serta anggota keluarga lainnya menjadi faktor penting yang dapat membantu ibu beradaptasi dengan perubahan tersebut (Feldman, 2017).

Dukungan sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan psikologis ibu postpartum. Ibu yang mendapatkan dukungan dari keluarga, pasangan, maupun lingkungan sosial cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah serta kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap peran baru sebagai orang tua. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan dalam perawatan bayi, dukungan emosional, serta penghargaan terhadap pengalaman ibu selama masa postpartum (Dennis & Letourneau, 2007).

Faktor sosial budaya juga memengaruhi pengalaman perempuan pada masa postpartum. Praktik budaya tertentu dapat memberikan dukungan bagi ibu dalam menjalani masa pemulihan setelah persalinan, seperti tradisi istirahat postpartum atau dukungan keluarga dalam merawat ibu dan bayi. Namun, beberapa praktik budaya juga dapat memengaruhi perilaku kesehatan ibu, termasuk praktik menyusui, pola makan, serta perawatan bayi. Pemahaman terhadap konteks sosial budaya menjadi penting dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal yang sensitif terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat (Fraser & Cooper, 2020).

Pendekatan pelayanan kesehatan maternal modern menempatkan kesehatan mental ibu sebagai bagian integral dari pelayanan postpartum. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan pentingnya integrasi layanan kesehatan mental dalam pelayanan kesehatan maternal untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Pendekatan ini mencakup deteksi dini gangguan kesehatan mental, pemberian dukungan psikososial, serta rujukan ke layanan kesehatan mental apabila diperlukan (World Health Organization, 2022).

Pemahaman mengenai adaptasi psikologis dan sosial pada masa postpartum memberikan landasan penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada perempuan setelah persalinan. Pendekatan

yang holistik tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik ibu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional, dukungan sosial, serta kualitas hubungan antara ibu dan bayi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses transisi menjadi orang tua secara sehat serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga setelah kelahiran bayi.

E. Fisiologi dan Regulasi Laktasi

Laktasi merupakan proses fisiologis yang memungkinkan kelenjar payudara memproduksi dan mengeluarkan air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi pada awal kehidupan. Proses ini merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem endokrin, sistem saraf, serta stimulasi mekanik pada payudara yang terjadi selama dan setelah persalinan. Aktivitas biologis tersebut menunjukkan bahwa laktasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hormonal, tetapi juga oleh respons neuroendokrin yang dipicu oleh interaksi antara ibu dan bayi selama proses menyusui (Cunningham et al., 2022).

Perkembangan kemampuan laktasi sebenarnya telah dimulai sejak masa kehamilan. Selama trimester kedua dan ketiga, jaringan payudara mengalami proliferasi dan diferensiasi sebagai respons terhadap peningkatan hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan human placental lactogen. Hormon estrogen berperan dalam merangsang pertumbuhan sistem duktus pada payudara, sedangkan progesteron memfasilitasi perkembangan lobulus dan alveoli yang berfungsi sebagai tempat produksi ASI. Prolaktin berperan dalam mempersiapkan sel-sel alveolar untuk sintesis komponen utama ASI, termasuk protein, lemak, dan laktosa (Marshall & Raynor, 2021).

Produksi ASI secara aktif dimulai setelah persalinan melalui proses yang dikenal sebagai lactogenesis. Tahap awal lactogenesis dimulai pada masa akhir kehamilan dan berlanjut hingga beberapa hari setelah persalinan. Tahap ini sering disebut sebagai lactogenesis I, yaitu fase diferensiasi sel sekretori pada jaringan payudara yang mulai memproduksi kolostrum dalam jumlah terbatas. Kolostrum merupakan cairan pertama yang dihasilkan oleh payudara dan memiliki konsentrasi tinggi antibodi serta faktor imunologis yang penting bagi perlindungan bayi terhadap infeksi pada awal kehidupan (Victora et al., 2016).

Tahap berikutnya dikenal sebagai lactogenesis II, yaitu fase aktivasi sekresi ASI yang biasanya terjadi sekitar dua hingga tiga hari setelah persalinan. Fase ini ditandai dengan peningkatan volume produksi ASI yang signifikan sebagai akibat dari penurunan kadar hormon progesteron setelah lahirnya plasenta. Penurunan progesteron memungkinkan hormon prolaktin bekerja secara optimal dalam

merangsang produksi ASI oleh sel alveolar pada jaringan payudara (Fraser & Cooper, 2020).

Proses produksi ASI dikendalikan terutama oleh hormon prolaktin yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Stimulasi mekanik pada puting susu akibat hisapan bayi akan mengirimkan impuls saraf menuju hipotalamus yang kemudian merangsang pelepasan prolaktin dari hipofisis. Hormon prolaktin selanjutnya merangsang sel-sel alveolar pada payudara untuk memproduksi komponen ASI. Mekanisme ini menunjukkan bahwa frekuensi menyusui memiliki pengaruh langsung terhadap produksi ASI, karena stimulasi yang lebih sering akan meningkatkan sekresi prolaktin (Rollins et al., 2016).

Pengeluaran ASI dari jaringan payudara dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis posterior. Oksitosin menyebabkan kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi alveoli dan duktus laktiferus sehingga ASI dapat terdorong keluar menuju puting susu. Mekanisme ini dikenal sebagai refleksi pengeluaran ASI atau milk ejection reflex. Refleksi tersebut dapat dipicu oleh rangsangan fisik seperti hisapan bayi maupun oleh respons emosional ibu terhadap bayinya, seperti mendengar tangisan bayi atau memikirkan bayinya (Cunningham et al., 2022).

Regulasi laktasi tidak hanya bergantung pada mekanisme hormonal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor autokrin dalam jaringan payudara. Produksi ASI diatur oleh prinsip keseimbangan antara produksi dan pengeluaran ASI. Ketika payudara sering dikosongkan melalui proses menyusui, produksi ASI akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan bayi. Sebaliknya, apabila ASI tidak dikeluarkan secara teratur, akumulasi ASI dalam alveoli akan menghambat aktivitas sel sekretori sehingga produksi ASI menurun. Mekanisme ini dikenal sebagai feedback inhibitor of lactation, yaitu sistem regulasi lokal yang mengontrol produksi ASI berdasarkan kebutuhan bayi (Kent et al., 2012).

Perkembangan ilmu kebidanan dan neonatologi menekankan pentingnya praktik menyusui dini sebagai bagian dari regulasi fisiologis laktasi. Inisiasi menyusui dini yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah kelahiran terbukti dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin dan prolaktin secara optimal. Kontak kulit antara ibu dan bayi pada periode awal kehidupan juga berperan dalam menstimulasi refleksi menyusui bayi serta memperkuat hubungan emosional antara ibu dan bayi (World Health Organization, 2022).

Faktor psikologis ibu juga memiliki pengaruh terhadap proses laktasi. Kondisi emosional seperti stres, kecemasan, atau kelelahan dapat memengaruhi refleksi pengeluaran ASI karena refleksi oksitosin sangat sensitif terhadap kondisi psikologis ibu. Dukungan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan menjadi faktor

penting dalam membantu ibu mempertahankan proses menyusui secara optimal. Lingkungan yang nyaman dan dukungan sosial yang memadai dapat meningkatkan keberhasilan menyusui serta memperkuat proses laktasi secara fisiologis (Dennis & Letourneau, 2007).

Pemahaman mengenai fisiologi dan regulasi laktasi memiliki implikasi penting dalam praktik pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pengetahuan tersebut membantu tenaga kesehatan memberikan edukasi yang tepat kepada ibu mengenai mekanisme produksi ASI, pentingnya frekuensi menyusui, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan menyusui. Pendekatan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti dalam mendukung proses laktasi diharapkan dapat meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif serta memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi ibu dan bayi pada awal kehidupan.

F. Komposisi dan Tahapan Produksi Air Susu Ibu (ASI)

Air susu ibu merupakan cairan biologis kompleks yang diproduksi oleh kelenjar payudara dan berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi pada awal kehidupan. Komposisi ASI dirancang secara fisiologis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, imunologis, serta perkembangan bayi secara optimal. Kandungan nutrisi dalam ASI tidak hanya menyediakan energi dan zat gizi penting, tetapi juga mengandung berbagai komponen bioaktif yang berperan dalam perlindungan terhadap infeksi, pematangan sistem imun, serta perkembangan organ bayi, khususnya sistem pencernaan dan sistem saraf (Victora et al., 2016).

Komposisi ASI bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan tahap produksi, usia bayi, waktu menyusui, serta kebutuhan fisiologis bayi. Variasi komposisi ini menunjukkan bahwa ASI merupakan nutrisi biologis yang sangat adaptif terhadap kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Penyesuaian komposisi tersebut mencerminkan mekanisme biologis yang kompleks dalam sistem laktasi manusia (Ballard & Morrow, 2013).

Komposisi Utama Air Susu Ibu

Air susu ibu mengandung berbagai komponen nutrisi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bayi. Komponen utama ASI meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta berbagai komponen bioaktif yang berperan dalam fungsi imunologis dan perkembangan biologis bayi. Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa. Laktosa berfungsi sebagai sumber energi utama bagi bayi serta berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dan magnesium di dalam usus. Selain laktosa, ASI juga mengandung oligosakarida kompleks yang berfungsi sebagai prebiotik alami. Oligosakarida dalam ASI membantu pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan bayi, terutama *Bifidobacterium*, yang berperan dalam

menjaga keseimbangan mikrobiota usus serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi (Bode, 2012).

Protein dalam ASI terdiri atas dua kelompok utama, yaitu protein whey dan kasein. Proporsi protein whey dalam ASI lebih tinggi dibandingkan kasein, sehingga lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih berkembang. Protein whey mengandung berbagai komponen penting seperti laktoferin, imunoglobulin, serta enzim yang berperan dalam perlindungan imunologis bayi terhadap berbagai mikroorganisme patogen (Ballard & Morrow, 2013).

Lemak merupakan komponen energi terbesar dalam ASI dan berperan penting dalam pertumbuhan serta perkembangan otak bayi. Lemak dalam ASI mengandung asam lemak esensial seperti asam dokosaheksaenoat (DHA) dan asam arakidonat (ARA) yang berperan dalam perkembangan sistem saraf pusat dan fungsi visual bayi. Kandungan lemak dalam ASI dapat berubah selama satu sesi menyusui, di mana ASI yang keluar pada awal menyusui memiliki kandungan lemak lebih rendah dibandingkan ASI yang keluar pada akhir sesi menyusui (Victora et al., 2016).

Air susu ibu juga mengandung berbagai komponen imunologis yang penting dalam melindungi bayi dari infeksi. Komponen tersebut meliputi imunoglobulin A sekretori (sIgA), sel imun, sitokin, serta berbagai faktor pertumbuhan yang berperan dalam pematangan sistem imun bayi. Kandungan komponen imunologis dalam ASI memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan dan infeksi saluran pencernaan pada bayi (Bode, 2012).

Tahapan Produksi Air Susu Ibu

Produksi ASI berlangsung melalui beberapa tahap yang mencerminkan perubahan fisiologis pada jaringan payudara setelah persalinan. Tahapan produksi ASI berkaitan dengan perubahan hormonal serta adaptasi metabolik yang terjadi pada tubuh ibu selama masa laktasi.

Tahap pertama produksi ASI dikenal sebagai kolostrum. Kolostrum merupakan cairan pertama yang diproduksi oleh payudara selama beberapa hari awal setelah persalinan. Cairan ini berwarna kekuningan dan memiliki konsistensi yang lebih kental dibandingkan ASI matur. Kolostrum mengandung konsentrasi tinggi protein, antibodi, serta faktor imunologis yang berperan penting dalam melindungi bayi dari infeksi pada masa awal kehidupan. Kandungan imunoglobulin A dalam kolostrum sangat tinggi sehingga berfungsi sebagai perlindungan imun pasif bagi bayi yang sistem kekebalannya masih berkembang (Cunningham et al., 2022).

Tahap berikutnya adalah produksi ASI transisi. Fase ini biasanya berlangsung pada hari ketiga hingga sekitar dua minggu setelah persalinan. Selama fase ini terjadi peningkatan volume produksi ASI serta perubahan komposisi nutrisi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. Kandungan lemak dan laktosa

mulai meningkat, sementara konsentrasi protein dan antibodi secara bertahap menurun dibandingkan dengan kolostrum. Perubahan komposisi ini menunjukkan adaptasi biologis terhadap kebutuhan energi bayi yang semakin meningkat (Marshall & Raynor, 2021).

Tahap terakhir adalah produksi ASI matur. ASI matur biasanya terbentuk sekitar dua minggu setelah persalinan dan menjadi sumber nutrisi utama bagi bayi selama periode menyusui. Komposisi ASI matur relatif stabil namun tetap dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Kandungan air dalam ASI matur cukup tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan cairan bayi tanpa memerlukan tambahan air dari sumber lain selama enam bulan pertama kehidupan (World Health Organization, 2022). Selain perubahan komposisi berdasarkan tahap produksi, ASI juga menunjukkan variasi selama satu sesi menyusui. ASI yang keluar pada awal menyusui disebut foremilk, yang memiliki kandungan air lebih tinggi dan berfungsi untuk menghilangkan rasa haus bayi. ASI yang keluar pada akhir sesi menyusui disebut hindmilk, yang mengandung lebih banyak lemak dan energi sehingga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan bayi.

Signifikansi Biologis ASI bagi Kesehatan Bayi

Karakteristik komposisi ASI yang dinamis memberikan keuntungan biologis yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sumber nutrisi lain. Kombinasi antara zat gizi, komponen imunologis, serta faktor pertumbuhan menjadikan ASI sebagai nutrisi yang optimal bagi bayi pada awal kehidupan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi secara signifikan (Victora et al., 2016).

Pemahaman mengenai komposisi dan tahapan produksi ASI menjadi dasar penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pengetahuan tersebut membantu tenaga kesehatan memberikan edukasi yang tepat kepada ibu mengenai manfaat menyusui serta pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pendekatan berbasis bukti dalam promosi menyusui diharapkan dapat meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif serta mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di masyarakat.

G. Manfaat Laktasi bagi Ibu dan Bayi

Laktasi merupakan proses biologis yang memiliki manfaat luas bagi kesehatan ibu dan bayi. Air susu ibu tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan kesehatan pada awal kehidupan. Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa praktik menyusui memberikan keuntungan

jangka pendek maupun jangka panjang bagi kesehatan ibu dan anak. Manfaat tersebut berkaitan dengan aspek nutrisi, imunologi, perkembangan psikologis, serta pencegahan berbagai penyakit kronis di kemudian hari (Victora et al., 2016).

Manfaat Laktasi bagi Bayi

Air susu ibu merupakan makanan alami yang paling sesuai dengan kebutuhan fisiologis bayi. Kandungan nutrisi dalam ASI dirancang secara biologis untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa awal kehidupan. ASI mengandung keseimbangan optimal antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk mendukung metabolisme dan perkembangan jaringan tubuh bayi. Komposisi nutrisi tersebut juga mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih dalam tahap perkembangan (Ballard & Morrow, 2013).

Komponen imunologis dalam ASI memberikan perlindungan penting terhadap berbagai penyakit infeksi. Kandungan imunoglobulin A sekretori, laktoferin, sel imun, serta berbagai faktor bioaktif membantu melindungi bayi dari infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran pencernaan, serta berbagai penyakit menular lainnya. Perlindungan imunologis ini sangat penting karena sistem kekebalan bayi pada awal kehidupan belum berkembang secara sempurna (Bode, 2012).

Pemberian ASI juga memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sistem pencernaan bayi. Oligosakarida dalam ASI berperan sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus bayi, terutama *Bifidobacterium*. Keberadaan mikrobiota usus yang sehat berperan dalam meningkatkan sistem imun, memperbaiki fungsi pencernaan, serta melindungi bayi dari berbagai gangguan gastrointestinal (Rollins et al., 2016).

Perkembangan kognitif dan neurologis bayi juga berkaitan dengan praktik menyusui. Kandungan asam lemak rantai panjang seperti DHA dan ARA dalam ASI berperan penting dalam perkembangan otak dan fungsi visual bayi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak disusui secara optimal (Victora et al., 2016).

Manfaat menyusui bagi bayi juga berkaitan dengan pencegahan penyakit kronis pada masa kehidupan selanjutnya. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan ASI pada masa bayi memiliki risiko lebih rendah mengalami obesitas, diabetes tipe 2, serta penyakit kardiovaskular pada masa dewasa. Efek protektif ini berkaitan dengan pengaruh nutrisi awal terhadap pemrograman metabolik tubuh manusia (Horta & Victora, 2013).

Manfaat Laktasi bagi Ibu

Proses menyusui memberikan manfaat fisiologis bagi kesehatan ibu setelah persalinan. Stimulasi pada puting susu selama menyusui merangsang pelepasan

hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi uterus. Kontraksi tersebut membantu mempercepat proses involusi uterus serta mengurangi risiko perdarahan postpartum. Aktivitas hormonal ini juga berperan dalam mempercepat pemulihan kondisi reproduksi ibu setelah persalinan (Cunningham et al., 2022).

Menyusui juga berkontribusi terhadap pemulihan metabolisme tubuh ibu setelah kehamilan. Produksi ASI memerlukan energi tambahan sehingga membantu penggunaan cadangan lemak yang tersimpan selama masa kehamilan. Proses ini dapat membantu ibu secara bertahap kembali ke berat badan sebelum kehamilan apabila didukung oleh pola makan dan gaya hidup yang sehat (Marshall & Raynor, 2021).

Manfaat jangka panjang menyusui bagi ibu juga telah banyak dilaporkan dalam berbagai penelitian epidemiologi. Perempuan yang menyusui memiliki risiko lebih rendah mengalami kanker payudara dan kanker ovarium dibandingkan perempuan yang tidak menyusui. Efek protektif tersebut diduga berkaitan dengan perubahan hormonal selama periode laktasi yang memengaruhi aktivitas sel pada jaringan payudara dan ovarium (Victora et al., 2016).

Praktik menyusui juga berkaitan dengan penurunan risiko penyakit metabolik pada ibu. Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan yang menyusui memiliki risiko lebih rendah mengalami diabetes melitus tipe 2, hipertensi, serta penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Mekanisme biologis yang mendasari fenomena ini berkaitan dengan pengaruh laktasi terhadap regulasi metabolisme glukosa dan lipid dalam tubuh (Horta & Victora, 2013).

Manfaat Psikologis dan Sosial

Selain manfaat fisiologis, menyusui juga memberikan keuntungan psikologis bagi ibu dan bayi. Proses menyusui meningkatkan interaksi emosional antara ibu dan bayi melalui kontak fisik, tatapan mata, serta respons emosional yang terjadi selama proses menyusui. Interaksi tersebut berperan dalam memperkuat ikatan emosional atau bonding antara ibu dan bayi yang penting bagi perkembangan psikososial anak (Feldman, 2017).

Pemberian ASI juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi keluarga serta masyarakat. ASI merupakan sumber nutrisi alami yang tidak memerlukan biaya tambahan sehingga dapat mengurangi pengeluaran keluarga untuk kebutuhan makanan bayi. Praktik menyusui juga berkontribusi terhadap pengurangan beban sistem kesehatan karena menurunkan kejadian penyakit infeksi dan berbagai masalah kesehatan pada bayi (World Health Organization, 2022).

Implikasi dalam Kesehatan Masyarakat

Manfaat luas dari praktik laktasi menjadikan promosi menyusui sebagai salah satu strategi penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Organisasi

Kesehatan Dunia merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan serta melanjutkan pemberian ASI hingga usia dua tahun atau lebih dengan pemberian makanan pendamping yang sesuai. Rekomendasi tersebut didasarkan pada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa praktik menyusui memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat secara global (World Health Organization, 2022).

Pemahaman mengenai manfaat laktasi bagi ibu dan bayi memberikan dasar penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi serta dukungan kepada ibu selama masa menyusui. Pendekatan berbasis bukti dalam promosi dan dukungan laktasi diharapkan dapat meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sepanjang daur kehidupan.

H. Permasalahan Klinis Masa Nifas dan Laktasi

Masa nifas dan periode menyusui merupakan fase yang sangat penting dalam kesehatan ibu dan bayi, namun periode ini juga memiliki potensi terjadinya berbagai permasalahan klinis. Perubahan fisiologis yang terjadi setelah persalinan, proses pemulihan organ reproduksi, serta dimulainya proses laktasi dapat menimbulkan kondisi tertentu yang memerlukan perhatian klinis. Permasalahan yang muncul pada masa ini dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis ibu serta keberhasilan pemberian ASI kepada bayi. Identifikasi dini dan penanganan yang tepat terhadap masalah klinis pada masa nifas dan laktasi sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius serta mendukung kesehatan ibu dan bayi secara optimal (Cunningham et al., 2022).

Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum merupakan salah satu komplikasi paling serius pada masa nifas dan menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas maternal di berbagai negara. Perdarahan postpartum dapat terjadi segera setelah persalinan maupun pada periode beberapa hari hingga minggu setelah kelahiran. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh atonia uteri, yaitu kegagalan uterus untuk berkontraksi secara efektif setelah pelepasan plasenta. Penyebab lain dapat meliputi retensi sisa jaringan plasenta, trauma pada jalan lahir, serta gangguan koagulasi darah (World Health Organization, 2022).

Manifestasi klinis perdarahan postpartum meliputi pengeluaran darah dalam jumlah berlebihan, penurunan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, serta tanda-tanda syok pada kondisi yang berat. Penanganan dini sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Pemantauan kontraksi uterus dan

jumlah perdarahan menjadi bagian penting dalam observasi klinis pada masa nifas (Marshall & Raynor, 2021).

Infeksi Puerperium

Infeksi puerperium merupakan infeksi yang terjadi pada traktus genitalia setelah persalinan. Kondisi ini dapat terjadi akibat masuknya mikroorganisme ke dalam uterus selama atau setelah proses persalinan. Faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian infeksi puerperium antara lain persalinan yang berlangsung lama, ketuban pecah dini, prosedur invasif selama persalinan, serta kebersihan yang kurang optimal pada masa postpartum (Fraser & Cooper, 2020).

Gejala infeksi puerperium dapat meliputi demam, nyeri pada perut bagian bawah, lokia berbau tidak normal, serta kondisi umum ibu yang memburuk. Penanganan infeksi puerperium umumnya melibatkan terapi antibiotik yang sesuai serta pemantauan kondisi klinis ibu secara berkelanjutan. Deteksi dini terhadap tanda-tanda infeksi sangat penting dalam mencegah penyebaran infeksi yang dapat membahayakan kesehatan ibu.

Gangguan Penyembuhan Luka Persalinan

Proses persalinan dapat menyebabkan trauma pada jaringan jalan lahir, termasuk robekan perineum atau tindakan episiotomi. Luka pada perineum memerlukan waktu untuk proses penyembuhan selama masa nifas. Beberapa perempuan dapat mengalami masalah dalam proses penyembuhan luka, seperti nyeri yang berlebihan, pembengkakan, atau tanda-tanda infeksi pada luka perineum. Perawatan luka yang tepat sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi. Kebersihan area perineum, pemantauan kondisi luka, serta edukasi kepada ibu mengenai perawatan luka merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan pada masa nifas (Marshall & Raynor, 2021).

Permasalahan Laktasi

Permasalahan dalam proses menyusui juga sering terjadi pada masa nifas. Kondisi ini dapat memengaruhi keberhasilan pemberian ASI serta kenyamanan ibu selama menyusui. Salah satu masalah yang sering dialami adalah bendungan payudara (breast engorgement), yaitu kondisi ketika payudara terasa penuh, tegang, dan nyeri akibat akumulasi ASI yang tidak dikeluarkan secara optimal.

Mastitis merupakan peradangan pada jaringan payudara yang dapat terjadi akibat infeksi bakteri atau akibat penyumbatan saluran ASI. Gejala mastitis meliputi nyeri pada payudara, kemerahan pada kulit payudara, demam, serta rasa tidak nyaman pada ibu. Penanganan mastitis biasanya melibatkan pengosongan payudara secara teratur, pemberian antibiotik apabila terjadi infeksi bakteri, serta istirahat yang cukup bagi ibu (Amir, 2014).

Masalah lain yang dapat terjadi adalah puting susu lecet atau nyeri pada puting susu. Kondisi ini sering disebabkan oleh teknik menyusui yang kurang tepat atau posisi bayi yang tidak optimal saat menyusui. Edukasi mengenai teknik menyusui yang benar sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah tersebut serta mendukung keberhasilan proses menyusui.

Gangguan Kesehatan Mental Postpartum

Selain masalah fisik, perempuan pada masa nifas juga dapat mengalami gangguan kesehatan mental. Perubahan hormonal, kelelahan fisik, serta tuntutan peran baru sebagai ibu dapat memengaruhi kondisi emosional perempuan setelah persalinan. Gangguan psikologis seperti postpartum blues, depresi postpartum, serta kecemasan postpartum dapat memengaruhi kesejahteraan ibu serta hubungan antara ibu dan bayi (Stewart & Vigod, 2019).

Depresi postpartum merupakan kondisi yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak pada kemampuan ibu dalam merawat bayi serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Deteksi dini terhadap gejala depresi postpartum menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan maternal. Pendekatan yang melibatkan dukungan keluarga, konseling psikologis, serta intervensi medis apabila diperlukan dapat membantu mengatasi kondisi tersebut.

Pendekatan Evidence-Based dalam Penanganan Permasalahan Nifas dan Laktasi

Perkembangan ilmu kebidanan modern menekankan pentingnya penerapan praktik berbasis bukti dalam penanganan berbagai masalah klinis pada masa nifas dan laktasi. Evidence-based practice mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaru dengan pengalaman klinis tenaga kesehatan serta kebutuhan individu ibu dan bayi. Pendekatan ini bertujuan memberikan pelayanan yang aman, efektif, serta berorientasi pada kesejahteraan ibu dan bayi (Renfrew et al., 2014).

Pelayanan kesehatan yang komprehensif pada masa nifas meliputi pemantauan kondisi fisik ibu, dukungan terhadap proses menyusui, serta perhatian terhadap kesehatan mental ibu. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, serta dukungan sosial dari masyarakat menjadi faktor penting dalam mengatasi berbagai permasalahan klinis yang dapat muncul pada periode postpartum.

Pemahaman mengenai berbagai permasalahan klinis pada masa nifas dan laktasi memberikan landasan penting bagi tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penatalaksanaan yang tepat. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal serta mendukung kesehatan ibu dan bayi dalam jangka panjang.

I. Perspektif Evidence-Based Midwifery dalam Pelayanan Postpartum

Perkembangan ilmu kebidanan modern menempatkan pendekatan evidence-based midwifery sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Evidence-based midwifery merupakan praktik kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dari penelitian, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan kepada ibu dan bayi pada masa postpartum didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan maternal (Renfrew et al., 2014).

Pelayanan postpartum merupakan salah satu fase penting dalam continuum of maternal care karena periode ini memiliki risiko tinggi terhadap berbagai komplikasi kesehatan ibu dan bayi. Evidence-based midwifery menekankan pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan bayi secara sistematis pada periode setelah persalinan. Pemantauan tersebut mencakup evaluasi kondisi fisiologis ibu, pemulihan organ reproduksi, keberhasilan proses laktasi, serta kesejahteraan psikologis ibu. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi secara dini berbagai potensi masalah kesehatan sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat (World Health Organization, 2022).

Salah satu prinsip utama dalam praktik berbasis bukti adalah penggunaan rekomendasi klinis yang didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru. Organisasi kesehatan global seperti World Health Organization (WHO) dan International Confederation of Midwives (ICM) telah mengembangkan berbagai pedoman praktik klinis yang mendukung pelayanan postpartum yang aman dan berkualitas. Pedoman tersebut mencakup rekomendasi mengenai pemantauan kondisi ibu dan bayi, dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif, deteksi dini komplikasi postpartum, serta integrasi pelayanan kesehatan mental dalam pelayanan maternal (World Health Organization, 2022).

Evidence-based midwifery juga menekankan pentingnya pendekatan pelayanan yang berpusat pada perempuan (woman-centered care). Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pelayanan kesehatan dengan menghargai pengalaman, kebutuhan, serta preferensi individu perempuan selama masa postpartum. Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator yang memberikan informasi ilmiah yang akurat sehingga perempuan dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan dirinya dan bayinya. Pendekatan tersebut dianggap mampu meningkatkan kepuasan perempuan terhadap pelayanan kesehatan serta memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan klien (Renfrew et al., 2014).

Praktik kebidanan berbasis bukti juga menekankan pentingnya dukungan terhadap proses menyusui sebagai bagian dari pelayanan postpartum yang komprehensif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan profesional terhadap ibu menyusui dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Intervensi yang berbasis bukti meliputi inisiasi menyusui dini, konseling menyusui, serta pemantauan teknik menyusui yang benar. Dukungan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan praktik menyusui serta kesehatan ibu dan bayi dalam jangka panjang (Rollins et al., 2016).

Integrasi pelayanan kesehatan mental dalam pelayanan postpartum juga menjadi bagian penting dari pendekatan evidence-based midwifery. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental seperti depresi postpartum dan kecemasan postpartum dapat memengaruhi kesejahteraan ibu serta perkembangan bayi. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan maternal modern menekankan pentingnya skrining kesehatan mental pada masa postpartum serta penyediaan dukungan psikososial bagi ibu yang membutuhkan (Stewart & Vigod, 2019).

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan kontribusi dalam implementasi evidence-based midwifery pada pelayanan postpartum. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan, telekonsultasi, serta platform edukasi digital memungkinkan tenaga kesehatan memberikan informasi yang lebih luas kepada ibu mengenai perawatan diri setelah persalinan dan praktik menyusui yang optimal. Inovasi tersebut dapat meningkatkan akses ibu terhadap informasi kesehatan yang berkualitas serta memperkuat dukungan terhadap kesehatan ibu dan bayi (World Health Organization, 2022).

Pendekatan evidence-based midwifery juga memiliki implikasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal di tingkat sistem kesehatan. Implementasi praktik berbasis bukti dapat membantu mengurangi variasi praktik klinis yang tidak didukung oleh bukti ilmiah serta meningkatkan standar pelayanan kebidanan. Integrasi antara penelitian ilmiah, pendidikan kebidanan, serta praktik klinis menjadi kunci dalam mengembangkan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas dan berkelanjutan (Renfrew et al., 2014).

Pemahaman mengenai perspektif evidence-based midwifery dalam pelayanan postpartum memberikan landasan ilmiah bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta mendukung upaya global dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Implementasi praktik kebidanan berbasis bukti juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sepanjang daur kehidupan reproduksinya.

J. Penutup

Masa nifas dan periode laktasi merupakan fase penting dalam siklus kehidupan reproduksi perempuan yang ditandai oleh berbagai proses pemulihan biologis, adaptasi psikologis, serta penyesuaian sosial setelah persalinan. Periode ini memiliki peran yang sangat menentukan terhadap kesehatan ibu dan bayi karena berbagai perubahan fisiologis yang terjadi memerlukan pemantauan serta dukungan pelayanan kesehatan yang optimal. Proses involusi organ reproduksi, adaptasi hormonal, serta dimulainya mekanisme laktasi menunjukkan bahwa masa nifas merupakan periode transisi yang kompleks dalam kehidupan Perempuan.

Pemahaman mengenai fisiologi masa nifas dan proses laktasi memberikan dasar ilmiah yang penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada ibu setelah persalinan. Pengetahuan mengenai perubahan fisiologis tubuh ibu, mekanisme produksi ASI, serta manfaat laktasi bagi kesehatan ibu dan bayi memungkinkan tenaga kesehatan memberikan edukasi serta dukungan yang tepat kepada ibu dalam menjalani masa nifas dan menyusui. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik ibu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologis serta hubungan antara ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan maternal pada masa nifas memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemantauan kondisi kesehatan ibu dan bayi, dukungan terhadap praktik menyusui, serta deteksi dini berbagai komplikasi postpartum menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan maternal dan neonatal. Implementasi pelayanan kesehatan yang komprehensif pada periode postpartum berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi berikutnya.

Perkembangan ilmu kebidanan modern juga menekankan pentingnya penerapan praktik kebidanan berbasis bukti (evidence-based midwifery) dalam pelayanan postpartum. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tindakan klinis yang diberikan kepada ibu dan bayi didasarkan pada bukti ilmiah terbaik serta mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi perempuan. Integrasi antara penelitian ilmiah, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai-nilai perempuan menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas.

Peningkatan kualitas pelayanan masa nifas dan laktasi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, serta sistem pelayanan kesehatan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu pada masa nifas, manfaat pemberian ASI eksklusif, serta tanda bahaya postpartum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan

ibu dan bayi. Partisipasi keluarga dalam memberikan dukungan emosional dan praktis kepada ibu setelah persalinan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proses pemulihan dan menyusui.

Pemahaman yang komprehensif mengenai masa nifas dan laktasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupan. Pendekatan pelayanan yang berbasis bukti, berpusat pada perempuan, serta didukung oleh sistem kesehatan yang kuat akan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan global yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Referensi

- Amir, L. H. (2014). Managing common breastfeeding problems in the community. *BMJ*, 348, g2954. <https://doi.org/10.1136/bmj.g2954>
- Ballard, O., & Morrow, A. L. (2013). Human milk composition: Nutrients and bioactive factors. *Pediatric Clinics of North America*, 60(1), 49–74. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2012.10.002>
- Bode, L. (2012). Human milk oligosaccharides: Every baby needs a sugar mama. *Glycobiology*, 22(9), 1147–1162. <https://doi.org/10.1093/glycob/cws074>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dennis, C. L., & Letourneau, N. (2007). Global and relationship-specific perceptions of support and the development of postpartum depressive symptomatology. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 42(5), 389–395. <https://doi.org/10.1007/s00127-007-0170-4>
- Feldman, R. (2017). The neurobiology of human attachments. *Trends in Cognitive Sciences*, 21(2), 80–99. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.11.007>
- Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2020). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Elsevier.
- Horta, B. L., & Victora, C. G. (2013). Long-term effects of breastfeeding: A systematic review. World Health Organization.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu nifas*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kent, J. C., Prime, D. K., & Garbin, C. P. (2012). Principles for maintaining or increasing breast milk production. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*,

41(1), 114–121. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2011.01313.x>

Marshall, J., & Raynor, M. (2021). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Elsevier.

O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression: Current status and future directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 379–407. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612>

Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., Silva, D. R., Downe, S., Kennedy, H. P., Malata, A., McCormick, F., Wick, L., & Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)

Rollins, N. C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., Lutter, C. K., Martines, J. C., Piwoz, E. G., Richter, L. M., & Victora, C. G. (2016). Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *The Lancet*, 387(10017), 491–504. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01044-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2)

Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A., Daniels, J., Gülmezoglu, A., Temmerman, M., & Alkema, L. (2019). Global causes of maternal death: A WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 2(6), e323–e333.

Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2019). Postpartum depression. *New England Journal of Medicine*, 381(22), 2127–2136. <https://doi.org/10.1056/NEJMcp1906596>

Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J., França, G. V., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)

World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization.

BAB V

KESEHATAN REPRODUKSI USIA SUBUR

A. Pendahuluan

Usia subur merupakan fase kehidupan perempuan yang memiliki arti strategis dalam perspektif kesehatan masyarakat, karena pada rentang usia ini fungsi biologis reproduksi berada pada kapasitas yang paling aktif dan adaptif. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan kelompok perempuan usia subur pada rentang 15–49 tahun, yaitu periode ketika ovulasi, siklus menstruasi, fertilitas, kehamilan, persalinan, dan laktasi paling sering terjadi dalam perjalanan hidup perempuan (WHO, 2023). Rentang usia tersebut tidak hanya dipahami sebagai batas biologis, melainkan juga sebagai masa transisi sosial yang ditandai dengan pembentukan keluarga, peran pengasuhan, produktivitas kerja, dan peningkatan tanggung jawab sosial.

Kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur berkembang dari konsep lama yang berfokus pada kehamilan dan persalinan menjadi konsep yang lebih komprehensif. Pendekatan modern memandang kesehatan reproduksi sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dan spiritual yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta hak individu untuk mengambil keputusan secara aman dan bertanggung jawab terhadap fungsi reproduksinya (UNFPA, 2022). Ruang lingkupnya meliputi kesehatan menstruasi, kesiapan prakonsepsi, kontrasepsi, pencegahan infertilitas, penanganan infeksi menular seksual, kesehatan seksual, pencegahan kanker reproduksi, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Perkembangan ilmu kebidanan, ginekologi, epidemiologi, endokrinologi reproduksi, kesehatan masyarakat, dan ilmu perilaku menunjukkan bahwa kondisi kesehatan perempuan pada masa usia subur berpengaruh langsung terhadap kualitas generasi berikutnya. Konsep life course approach menjelaskan bahwa status gizi, penyakit kronis, stres psikologis, paparan lingkungan, dan akses pelayanan kesehatan sebelum kehamilan akan menentukan luaran kehamilan, kesehatan neonatus, bahkan risiko penyakit tidak menular pada anak di masa dewasa (Barker, 2018; Qiao et al., 2021). Kesehatan reproduksi usia subur dengan demikian menjadi investasi jangka panjang, bukan hanya isu klinis sesaat.

Bukti ilmiah juga menunjukkan bahwa intervensi pada kelompok usia subur memberikan dampak kesehatan yang luas. Analisis lintas 172 negara

memperkirakan bahwa penggunaan kontrasepsi modern berkontribusi besar dalam menurunkan kematian ibu melalui pencegahan kehamilan berisiko tinggi, penjarangan kelahiran, dan pengurangan kehamilan yang tidak direncanakan (Ahmed et al., 2012). Tinjauan sistematis global lainnya melaporkan bahwa peningkatan akses kontrasepsi berhubungan dengan meningkatnya pendidikan perempuan, partisipasi kerja, dan penguatan otonomi pengambilan keputusan dalam rumah tangga (Cleland et al., 2012; Lassi et al., 2024).

Masalah kesehatan reproduksi pada usia subur masih menjadi tantangan di berbagai negara berkembang maupun maju. Gangguan menstruasi, anemia, sindrom ovarium polikistik, endometriosis, infertilitas, infeksi menular seksual, kanker serviks, obesitas, dan gangguan kesehatan mental merupakan kondisi yang sering ditemukan pada kelompok ini (Okoth et al., 2020; Jahanfar et al., 2024). Beban masalah tersebut semakin kompleks ketika disertai ketimpangan sosial, pernikahan usia dini, rendahnya literasi kesehatan, kemiskinan, serta keterbatasan layanan kesehatan primer.

Konteks Indonesia menunjukkan tantangan yang serupa. Prevalensi anemia pada perempuan usia reproduksi masih tinggi, cakupan skrining kanker serviks belum optimal, kehamilan tidak direncanakan masih terjadi, dan sebagian perempuan belum memperoleh informasi kontrasepsi yang memadai (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Urbanisasi, perubahan pola makan, peningkatan penyakit metabolik, serta paparan stres pekerjaan turut memengaruhi kualitas kesehatan reproduksi perempuan masa kini. Situasi tersebut menuntut pendekatan pelayanan yang lebih integratif antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pendekatan *evidence-based practice* dalam kesehatan reproduksi menekankan bahwa setiap intervensi harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis tenaga kesehatan, dan kebutuhan perempuan sebagai pusat pelayanan. Konseling kontrasepsi berbasis pilihan sadar, skrining faktor risiko prakonsepsi, deteksi dini kanker serviks, pelayanan fertilitas, serta dukungan kesehatan mental merupakan contoh implementasi praktik berbasis bukti yang terus berkembang (Haakenstad et al., 2022).

Pembahasan kesehatan reproduksi usia subur menjadi sangat penting dalam buku ini karena periode tersebut merupakan poros utama kesinambungan daur kehidupan perempuan. Kesehatan yang baik pada masa usia subur akan menentukan kualitas kehamilan, keselamatan persalinan, keberhasilan menyusui, kesehatan anak, dan kesiapan perempuan memasuki fase pramenopause. Upaya peningkatan kesehatan reproduksi pada fase ini pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan keluarga sehat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian target pembangunan kesehatan nasional maupun global.

B. Definisi Kesehatan Reproduksi Usia Subur

Kesehatan reproduksi usia subur merupakan konsep multidimensional yang menggambarkan keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dan fungsional pada perempuan dalam rentang usia reproduktif, umumnya 15–49 tahun, yang berkaitan dengan sistem reproduksi, proses biologisnya, serta kemampuan mengambil keputusan secara aman dan bertanggung jawab terhadap kehidupan reproduksinya (WHO, 2023). Definisi ini menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi tidak dapat dibatasi hanya pada ketiadaan penyakit, tetapi mencakup kemampuan perempuan menjalani fungsi reproduksi secara optimal sepanjang fase usia subur.

Perkembangan keilmuan kesehatan reproduksi dalam dua dekade terakhir memperluas makna definisi tersebut. Pendekatan kontemporer menempatkan perempuan sebagai subjek utama pelayanan, bukan sekadar penerima intervensi medis. Perspektif ini menekankan hak atas informasi, akses layanan bermutu, perlindungan dari kekerasan, kebebasan menentukan jumlah dan jarak kelahiran, serta kesempatan memperoleh kualitas hidup yang baik tanpa diskriminasi (Starrs et al., 2018). Definisi modern kesehatan reproduksi karena itu mencakup dimensi hak reproduksi, kesehatan seksual, dan otonomi tubuh.

Pada kelompok usia subur, kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan kesiapan biologis dan sosial untuk menjalani kehamilan, persalinan, serta pengasuhan anak. Kondisi kesehatan sebelum konsepsi terbukti berpengaruh besar terhadap keberhasilan kehamilan dan kesehatan bayi. Penelitian berbasis populasi menunjukkan bahwa status gizi, anemia, obesitas, penyakit metabolik, kesehatan mental, dan paparan infeksi sebelum hamil berkaitan dengan komplikasi obstetri, berat badan lahir rendah, prematuritas, serta gangguan tumbuh kembang anak (Qiao et al., 2021). Kondisi tersebut menjadikan definisi kesehatan reproduksi usia subur harus dipahami sejak sebelum kehamilan terjadi.

Fungsi menstruasi yang sehat merupakan komponen dasar kesehatan reproduksi. Siklus menstruasi mencerminkan keseimbangan hormonal, fungsi ovarium, status metabolik, dan kondisi psikologis perempuan. Gangguan seperti amenore, oligomenore, dismenore berat, atau perdarahan abnormal sering menjadi indikator awal masalah endokrin, sindrom ovarium polikistik, endometriosis, maupun stres kronis (Wilson & Rademacher, 2021). Menstruasi yang sehat tidak hanya berarti datang setiap bulan, tetapi berlangsung teratur, tidak menimbulkan disabilitas, dan tidak mengganggu kualitas hidup.

Kemampuan memperoleh kehamilan secara sehat juga menjadi unsur penting dalam definisi kesehatan reproduksi usia subur. Fertilitas dipengaruhi oleh usia, cadangan ovarium, kualitas sperma pasangan, status nutrisi, penyakit kronis, dan gaya hidup. Organisasi Kesehatan Dunia menempatkan infertilitas sebagai bagian

integral dari kesehatan reproduksi karena berdampak biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi individu maupun keluarga (WHO, 2025). Pendekatan evidence-based menegaskan pentingnya deteksi dini gangguan kesuburan, konseling prakonsepsi, dan tata laksana infertilitas yang adil serta terjangkau.

Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan merupakan indikator penting kesehatan reproduksi. Penggunaan kontrasepsi modern terbukti menurunkan angka kematian ibu, menurunkan kehamilan risiko tinggi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Analisis global menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan kontrasepsi berkontribusi nyata terhadap keselamatan ibu dan peningkatan partisipasi sosial perempuan (Ahmed et al., 2012; Cleland et al., 2012). Definisi kesehatan reproduksi usia subur karenanya mencakup akses terhadap konseling dan pilihan kontrasepsi yang aman, efektif, serta sesuai preferensi individu.

Pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Infeksi seperti klamidia, gonore, sifilis, HIV, dan human papillomavirus (HPV) dapat menyebabkan infertilitas, kehamilan ektopik, keguguran, kanker serviks, serta penularan vertikal kepada bayi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa skrining rutin, vaksinasi HPV, penggunaan kondom, dan deteksi dini merupakan strategi efektif dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan usia subur (Terrinoni et al., 2025).

Kehamilan dan persalinan yang aman merupakan puncak implementasi kesehatan reproduksi pada usia subur. Perempuan yang memasuki kehamilan dengan status kesehatan baik memiliki risiko komplikasi lebih rendah dibanding perempuan dengan anemia, hipertensi, diabetes, atau malnutrisi. Layanan antenatal berkualitas, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta pelayanan nifas terbukti menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal (Qiao et al., 2021). Definisi kesehatan reproduksi karena itu harus mencakup kesinambungan pelayanan dari prakonsepsi hingga masa pascapersalinan.

Pencegahan penyakit reproduksi kronis menjadi dimensi yang semakin penting. Beban global penyakit seperti kanker serviks, kanker ovarium, fibroid uteri, endometriosis, dan sindrom ovarium polikistik meningkat pada perempuan usia produktif. Kajian global terbaru menunjukkan bahwa gangguan non-neoplastik dan neoplastik sistem reproduksi memberikan dampak besar terhadap produktivitas, kesehatan mental, dan kualitas hidup perempuan (Tang et al., 2025). Deteksi dini, edukasi, serta layanan rujukan tepat waktu menjadi bagian dari definisi kesehatan reproduksi yang komprehensif.

Kesehatan reproduksi usia subur pada akhirnya dapat dirumuskan sebagai kondisi optimal yang memungkinkan perempuan menjalani menstruasi sehat, memiliki pilihan terhadap kehamilan, memperoleh kehamilan yang aman ketika

diinginkan, terlindungi dari penyakit dan kekerasan, serta mendapatkan layanan kesehatan bermutu sepanjang masa reproduktifnya. Definisi tersebut menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan sekaligus agen utama dalam pengambilan keputusan kesehatannya sendiri.

C. Karakteristik Perempuan Usia Subur

Perempuan usia subur merupakan kelompok yang berada pada fase reproduktif aktif, umumnya dalam rentang usia 15–49 tahun, dengan karakteristik biologis, psikologis, sosial, dan kesehatan yang berbeda dibanding masa remaja awal maupun masa pramenopause. Karakteristik tersebut penting dipahami karena menentukan kebutuhan pelayanan kesehatan, perencanaan keluarga, pencegahan penyakit, serta kualitas generasi berikutnya. Pendekatan ilmu kesehatan modern memandang perempuan usia subur bukan hanya dari kemampuan hamil, tetapi sebagai individu yang mengalami interaksi kompleks antara hormon, metabolisme, lingkungan, dan peran sosial (WHO, 2023).

1. Kematangan Organ Reproduksi dan Regulasi Hormonal

Fase usia subur ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara optimal. Ovarium secara fisiologis menghasilkan oosit matang melalui proses ovulasi serta mensekresi hormon estrogen, progesteron, inhibin, dan sejumlah mediator endokrin lain yang berperan dalam pengaturan siklus menstruasi. Hipotalamus, hipofisis, dan ovarium bekerja melalui mekanisme hypothalamic-pituitary-ovarian axis yang menjaga keteraturan hormonal dan kesuburan (La Marca & Mastellari, 2020).

Siklus menstruasi yang teratur sering menjadi indikator fungsi reproduksi yang baik, meskipun variasi individual tetap dapat terjadi. Panjang siklus normal berkisar 21–35 hari, dengan durasi perdarahan rata-rata 2–7 hari. Ketidakteraturan siklus, nyeri haid berat, atau perdarahan berlebihan dapat mencerminkan gangguan hormonal, stres, gangguan tiroid, sindrom ovarium polikistik, atau kelainan struktural uterus (Mussa et al., 2024).

Kematangan organ reproduksi juga tercermin dari kemampuan endometrium menerima implantasi, fungsi serviks yang normal, serta kondisi tuba falopi yang paten. Ketiga komponen tersebut berperan besar dalam keberhasilan konsepsi alami.

2. Potensi Fertilitas Tinggi tetapi Dipengaruhi Usia

Karakteristik penting perempuan usia subur adalah adanya kemampuan reproduksi atau fertilitas. Fertilitas tertinggi umumnya berada pada dekade kedua akhir hingga awal dekade ketiga kehidupan, terutama usia 20–35 tahun. Pada

rentang tersebut kualitas oosit, respons hormonal, dan kondisi metabolik cenderung lebih baik dibanding usia yang lebih lanjut (Steiner et al., 2017).

Penurunan fertilitas berlangsung bertahap seiring bertambahnya usia akibat berkurangnya jumlah dan kualitas folikel ovarium. Cadangan ovarium mulai menurun nyata setelah usia 30 tahun dan lebih cepat setelah usia 35 tahun. Penurunan tersebut meningkatkan risiko infertilitas, keguguran spontan, dan komplikasi kehamilan (Nabhan et al., 2022).

Fertilitas tidak hanya ditentukan usia kronologis. Status gizi, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, penyakit kronis, kualitas tidur, paparan polutan, dan stres psikologis juga memengaruhi peluang kehamilan. Evidence terkini menunjukkan gaya hidup sehat dapat membantu mempertahankan fungsi reproduksi lebih lama (Yang et al., 2025).

3. Perubahan Psikologis dan Peran Sosial

Perempuan usia subur umumnya berada pada fase kehidupan yang padat tanggung jawab. Banyak perempuan menjalani beberapa peran sekaligus sebagai pasangan, ibu, pekerja, mahasiswa, pengasuh keluarga, dan anggota masyarakat. Dinamika tersebut menjadikan kesehatan reproduksi sangat terkait dengan kondisi psikososial.

Tekanan pekerjaan, konflik peran, beban pengasuhan, masalah ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial dapat memengaruhi keseimbangan hormonal melalui peningkatan kortisol dan gangguan tidur. Kondisi ini berhubungan dengan gangguan menstruasi, penurunan libido, infertilitas fungsional, serta gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi (Yang et al., 2025).

Perempuan usia subur juga menunjukkan peningkatan kebutuhan terhadap informasi kesehatan yang akurat. Literasi reproduksi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi, kehamilan, jarak kelahiran, dan pemeriksaan kesehatan berkala.

4. Risiko Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Penyerta

Walaupun secara biologis berada pada fase reproduktif aktif, perempuan usia subur tetap memiliki risiko berbagai masalah kesehatan. Anemia defisiensi besi masih menjadi masalah global yang sering ditemukan akibat menstruasi bulanan, asupan zat besi yang kurang, kehamilan berulang, atau penyakit kronis. Anemia pada usia subur berkaitan dengan kelelahan, penurunan produktivitas, gangguan ovulasi, serta risiko komplikasi kehamilan (WHO, 2023).

Infeksi menular seksual seperti klamidia, gonore, sifilis, HIV, dan HPV juga dapat terjadi pada kelompok ini. Infeksi yang tidak terdeteksi berpotensi menyebabkan penyakit radang panggul, infertilitas, kehamilan ektopik, dan kanker serviks. Kajian global menunjukkan sebagian beban infertilitas perempuan

berkaitan dengan infeksi menular seksual yang tidak tertangani dengan baik (Li et al., 2026).

Risiko lain yang semakin meningkat adalah obesitas, diabetes melitus, hipertensi, dan gangguan metabolik. Penyakit tidak menular tersebut berpengaruh terhadap siklus haid, ovulasi, keberhasilan kehamilan, dan keselamatan maternal. Perempuan usia subur masa kini memerlukan pendekatan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan pencegahan penyakit metabolik.

5. Variabilitas Individual dan Pengaruh Lingkungan

Tidak semua perempuan usia subur memiliki karakteristik yang sama. Faktor genetik, status sosial ekonomi, budaya, pola makan, aktivitas fisik, akses layanan kesehatan, dan paparan lingkungan menyebabkan variasi besar antarindividu maupun antarpopulasi. Usia kronologis yang sama dapat menunjukkan kondisi cadangan ovarium, kesehatan mental, dan risiko kehamilan yang berbeda.

Pendekatan pelayanan modern karena itu menekankan person-centered care, yaitu pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, nilai, dan kondisi klinis masing-masing perempuan. Penilaian kesehatan usia subur tidak cukup hanya berdasarkan umur, tetapi harus mencakup aspek klinis, perilaku, psikologis, dan sosial.

6. Implikasi dalam Pelayanan Kesehatan

Pemahaman mengenai karakteristik perempuan usia subur menjadi dasar penyusunan intervensi kesehatan yang tepat. Skrining anemia, konseling gizi, pelayanan kontrasepsi, deteksi infeksi reproduksi, pemeriksaan prakonsepsi, serta promosi kesehatan mental merupakan strategi berbasis bukti yang direkomendasikan untuk kelompok ini.

Karakteristik perempuan usia subur menunjukkan bahwa fase reproduktif adalah masa produktif yang membutuhkan dukungan kesehatan komprehensif. Investasi kesehatan pada kelompok ini memberi dampak luas terhadap kesejahteraan perempuan, keselamatan ibu, dan kualitas generasi mendatang.

D. Masalah Kesehatan Reproduksi pada Usia Subur

Perempuan usia subur menghadapi berbagai masalah kesehatan reproduksi yang bersifat kompleks dan saling berkaitan antara faktor biologis, perilaku, lingkungan, serta sosial. Beban masalah ini tidak hanya berdampak pada fungsi reproduksi, tetapi juga pada kualitas hidup, produktivitas, serta kesehatan jangka panjang. Kajian global menunjukkan bahwa gangguan kesehatan reproduksi pada kelompok usia ini masih menjadi penyumbang signifikan terhadap morbiditas perempuan, terutama di negara berkembang (Tang et al., 2025).

1. Gangguan Menstruasi

Gangguan menstruasi merupakan salah satu masalah paling sering dialami perempuan usia subur. Kondisi ini meliputi amenore, oligomenore, dismenore, menoragia, serta sindrom pramenstruasi. Siklus menstruasi yang tidak normal dapat menjadi indikator awal adanya gangguan hormonal, kelainan struktural, atau masalah metabolik.

Dismenore atau nyeri haid dilaporkan memiliki prevalensi tinggi dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta produktivitas kerja. Gangguan lain seperti perdarahan berlebihan berisiko menyebabkan anemia defisiensi besi, sedangkan siklus tidak teratur sering dikaitkan dengan sindrom ovarium polistik atau gangguan endokrin lainnya (Ciebiera et al., 2021; Brenner et al., 2026). Bukti menunjukkan bahwa sekitar seperempat perempuan usia reproduksi mengalami ketidakteraturan siklus menstruasi dalam berbagai derajat (Sharif et al., 2022).

2. Infeksi Saluran Reproduksi

Infeksi saluran reproduksi mencakup infeksi non-spesifik maupun spesifik yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, atau parasit. Kondisi yang sering ditemukan antara lain kandidiasis vulvovaginal, vaginosis bakterialis, serta infeksi oleh bakteri seperti *Chlamydia trachomatis* dan *Neisseria gonorrhoeae*.

Infeksi ini dapat menimbulkan gejala seperti keputihan abnormal, gatal, nyeri, dan gangguan fungsi seksual. Infeksi yang tidak ditangani berpotensi berkembang menjadi penyakit radang panggul, kerusakan tuba falopi, dan infertilitas. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa infeksi saluran reproduksi merupakan faktor penting dalam penurunan kesuburan perempuan di berbagai negara (Rocha et al., 2019).

3. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi menular seksual tetap menjadi masalah kesehatan utama pada perempuan usia subur. Penyakit seperti sifilis, HIV, herpes genital, gonore, klamidia, dan infeksi human papillomavirus (HPV) memiliki dampak luas terhadap kesehatan reproduksi.

HPV merupakan salah satu IMS paling umum dan berkaitan erat dengan kejadian kanker serviks. Infeksi persisten HPV berisiko menyebabkan perubahan sel serviks yang dapat berkembang menjadi keganasan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara infeksi HPV dan peningkatan risiko infertilitas pada perempuan (Hsu et al., 2020; Yuan et al., 2020).

IMS yang tidak terdiagnosis sering bersifat asimtomatik sehingga meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang. Pencegahan melalui edukasi, penggunaan kondom, vaksinasi HPV, serta skrining rutin menjadi strategi utama berbasis bukti.

4. Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi masih menjadi tantangan penting dalam kesehatan reproduksi. Risiko meningkat pada kondisi usia terlalu muda, usia lebih dari 35 tahun, jarak kehamilan yang terlalu dekat, jumlah kehamilan yang terlalu banyak, serta adanya penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau anemia.

Kehamilan dengan risiko tinggi berkaitan dengan peningkatan komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan, persalinan prematur, dan kematian ibu maupun bayi. Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya pelayanan prakonsepsi, pemantauan antenatal yang berkualitas, serta deteksi dini faktor risiko untuk menurunkan komplikasi (WHO, 2023).

5. Infertilitas

Infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan memperoleh kehamilan setelah 12 bulan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor ovulasi, gangguan tuba, kelainan uterus, endometriosis, infeksi, maupun faktor pasangan.

Beban infertilitas cukup besar dan berdampak tidak hanya secara biologis, tetapi juga psikologis dan sosial. Infeksi menular seksual, gangguan hormonal, serta penurunan cadangan ovarium merupakan faktor yang sering berperan. Sekitar 50% kasus infertilitas perempuan berkaitan dengan gangguan sistem reproduksi seperti endometriosis, fibroid, dan gangguan ovulasi (Tang et al., 2025).

Pendekatan penanganan infertilitas saat ini berkembang pesat melalui teknologi reproduksi berbantu, namun pencegahan tetap menjadi strategi utama melalui edukasi kesehatan reproduksi dan deteksi dini.

6. Kanker Organ Reproduksi

Kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker payudara merupakan penyakit serius yang sering terjadi pada perempuan usia subur maupun setelahnya. Kanker serviks memiliki hubungan kuat dengan infeksi HPV, terutama tipe onkogenik.

Insidensi kanker reproduksi masih tinggi di banyak negara akibat rendahnya cakupan skrining dan vaksinasi. Deteksi dini melalui Pap smear, inspeksi visual dengan asam asetat (IVA), serta vaksinasi HPV terbukti efektif menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks (Tang et al., 2025). Kanker ovarium dan payudara juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan faktor risiko meliputi genetik, hormonal, gaya hidup, dan lingkungan.

7. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merupakan masalah serius yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat menyebabkan trauma genital,

infeksi menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, gangguan menstruasi, serta gangguan kesehatan mental.

Dampak jangka panjang meliputi depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, serta penurunan kualitas hidup. Bukti menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan reproduksi dan penggunaan layanan kesehatan yang rendah akibat stigma sosial (Starrs et al., 2018).

Masalah kesehatan reproduksi pada usia subur menunjukkan bahwa fase ini bukan hanya periode dengan potensi reproduksi tinggi, tetapi juga periode dengan kerentanan yang memerlukan perhatian serius. Pendekatan komprehensif berbasis bukti, yang mencakup promosi kesehatan, pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan yang tepat, menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan perempuan usia subur.

E. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur dipengaruhi oleh berbagai determinan yang saling berinteraksi secara kompleks. Pendekatan ilmu kesehatan modern menempatkan faktor-faktor tersebut dalam kerangka determinants of health, yang mencakup aspek biologis, perilaku, sosial ekonomi, budaya, serta lingkungan. Tidak ada satu faktor tunggal yang berdiri sendiri, karena setiap komponen saling memengaruhi dalam menentukan status kesehatan reproduksi perempuan (Canelón & Boland, 2020).

1. Faktor Biologis

Faktor biologis merupakan dasar utama yang menentukan fungsi reproduksi. Usia, status hormonal, kondisi genetik, serta adanya penyakit kronis berperan besar dalam kesehatan reproduksi perempuan. Usia memengaruhi kualitas dan kuantitas oosit, keseimbangan hormon, serta risiko komplikasi kehamilan.

Status gizi juga termasuk dalam faktor biologis yang sangat penting. Kekurangan zat besi, asam folat, atau energi kronis dapat menyebabkan anemia, gangguan ovulasi, dan komplikasi kehamilan. Sebaliknya, obesitas berkaitan dengan gangguan hormonal seperti resistensi insulin dan sindrom ovarium polikistik yang dapat menurunkan fertilitas (Feng et al., 2018).

Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan tiroid memiliki dampak langsung terhadap siklus menstruasi, kesuburan, serta keselamatan kehamilan. Paparan bahan kimia lingkungan seperti endocrine disrupting chemicals (EDCs) juga terbukti memengaruhi sistem hormonal dan fungsi reproduksi perempuan (Caserta et al., 2011).

2. Faktor Perilaku dan Gaya Hidup

Perilaku individu menjadi determinan penting dalam menjaga atau justru menurunkan kesehatan reproduksi. Kebiasaan menjaga kebersihan diri, perilaku seksual, pola makan, aktivitas fisik, serta konsumsi zat berisiko seperti rokok dan alkohol berpengaruh langsung terhadap fungsi reproduksi.

Perilaku seksual yang tidak aman meningkatkan risiko infeksi menular seksual, yang pada akhirnya dapat menyebabkan infertilitas atau komplikasi kehamilan. Gaya hidup sedentari dan pola makan tidak seimbang berkontribusi terhadap obesitas dan gangguan metabolik yang berdampak pada sistem reproduksi.

Stres psikologis kronis juga menjadi faktor penting. Aktivasi hormon stres seperti kortisol dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan siklus menstruasi. Kajian psikososial menunjukkan bahwa tekanan emosional dan kurangnya dukungan sosial berkaitan dengan gangguan reproduksi serta penurunan kualitas hidup perempuan (Stanton et al., 2002).

3. Faktor Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi merupakan determinan kuat dalam kesehatan reproduksi perempuan. Tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, serta akses terhadap layanan kesehatan memengaruhi kemampuan perempuan dalam memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan.

Perempuan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan lebih baik tentang kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, serta perencanaan kehamilan. Pendapatan yang memadai memungkinkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, nutrisi yang baik, dan lingkungan hidup yang sehat. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi sering dikaitkan dengan pernikahan usia dini, kehamilan berulang, kurangnya akses kontrasepsi, serta rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi berkontribusi besar terhadap perbedaan status kesehatan reproduksi antar kelompok populasi (Biglari et al., 2024).

4. Faktor Budaya dan Norma Sosial

Nilai budaya dan norma sosial memengaruhi cara perempuan memahami dan menjalani kesehatan reproduksinya. Praktik seperti pernikahan dini, preferensi jumlah anak, tabu dalam membicarakan kesehatan seksual, serta ketimpangan gender dapat membatasi akses perempuan terhadap informasi dan layanan kesehatan.

Budaya yang membatasi otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi dapat meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan, kekerasan berbasis gender, serta rendahnya penggunaan kontrasepsi. Kajian

lintas budaya menunjukkan bahwa faktor religius dan norma sosial memiliki peran signifikan dalam menentukan perilaku kesehatan reproduksi perempuan (Alomair et al., 2020).

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan fisik dan sosial memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan reproduksi. Akses terhadap air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, serta kondisi tempat tinggal memengaruhi risiko infeksi dan kualitas kesehatan secara umum.

Paparan polusi udara, bahan kimia industri, pestisida, dan logam berat dapat mengganggu sistem endokrin dan menurunkan kesuburan. Studi menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak sehat berkaitan dengan peningkatan gangguan menstruasi, infertilitas, serta komplikasi kehamilan (Caserta et al., 2011).

Lingkungan sosial seperti tempat kerja dan komunitas juga berperan penting. Perempuan yang tinggal di lingkungan dengan akses layanan kesehatan terbatas atau dalam kondisi sosial yang tidak aman cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan reproduksi (Akwara et al., 2023).

6. Faktor Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi faktor penentu dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan usia subur. Akses terhadap layanan antenatal, kontrasepsi, skrining kanker, serta penanganan infeksi reproduksi sangat memengaruhi luaran kesehatan.

Pelayanan yang tidak merata, biaya tinggi, serta kurangnya tenaga kesehatan terlatih menjadi hambatan utama di berbagai wilayah. Sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan terbukti meningkatkan penggunaan layanan dan menurunkan risiko komplikasi reproduksi (Srivastava et al., 2015).

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur tidak dapat dipisahkan dari interaksi berbagai faktor yang bekerja secara simultan. Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya intervensi yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup perbaikan kondisi sosial, ekonomi, perilaku, dan lingkungan. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam merancang program kesehatan yang efektif dan berkelanjutan bagi perempuan usia subur.

F. Upaya Menjaga Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Upaya menjaga kesehatan reproduksi perempuan usia subur memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu kesehatan

berbasis bukti yang menekankan pentingnya intervensi sejak sebelum terjadinya kehamilan hingga pemeliharaan kesehatan jangka panjang. Strategi yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mempertimbangkan faktor perilaku, sosial, dan akses pelayanan kesehatan (Moos et al., 2008).

1. Pemeliharaan Kebersihan Organ Reproduksi

Kebersihan organ reproduksi merupakan langkah dasar dalam mencegah infeksi saluran reproduksi. Praktik higiene yang baik meliputi membersihkan area genital dengan cara yang benar, menjaga kelembapan, serta mengganti pembalut secara teratur saat menstruasi.

Kurangnya kebersihan dapat meningkatkan risiko vaginosis bakterialis, kandidiasis, dan infeksi lain yang berpotensi berkembang menjadi komplikasi lebih serius. Edukasi mengenai higiene menstruasi terbukti meningkatkan kesehatan reproduksi serta menurunkan kejadian infeksi pada perempuan usia subur (Sommer & Mmari, 2015).

2. Pemenuhan Gizi Seimbang

Status gizi memiliki hubungan langsung dengan fungsi reproduksi. Asupan zat besi, asam folat, protein, kalsium, serta mikronutrien lain berperan dalam menjaga keseimbangan hormonal, ovulasi, dan kesehatan kehamilan.

Kekurangan gizi berkaitan dengan anemia, gangguan menstruasi, dan komplikasi obstetri, sedangkan kelebihan berat badan berhubungan dengan gangguan metabolik dan infertilitas. Intervensi nutrisi pada perempuan usia subur terbukti meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan luaran kehamilan (Lassi et al., 2014).

3. Aktivitas Fisik dan Gaya Hidup Sehat

Aktivitas fisik yang cukup membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menyeimbangkan hormon reproduksi. Olahraga teratur juga berkontribusi terhadap kesehatan mental dan mengurangi stres, yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan kesuburan.

Perilaku lain seperti tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, serta menghindari paparan zat berbahaya merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan fungsi reproduksi dan pencegahan penyakit kronis (Paladine et al., 2021).

4. Perencanaan Kehamilan dan Pelayanan Prakonsepsi

Perencanaan kehamilan merupakan strategi utama dalam menjaga kesehatan reproduksi. Konseling prakonsepsi memungkinkan identifikasi faktor risiko seperti anemia, penyakit kronis, infeksi, serta status gizi sebelum kehamilan terjadi.

Pendekatan ini terbukti menurunkan risiko komplikasi kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta mendukung kehamilan yang diinginkan dan aman. Intervensi prakonsepsi mencakup suplementasi, imunisasi, skrining kesehatan, serta edukasi reproduksi (Moos et al., 2008).

5. Penggunaan Kontrasepsi

Penggunaan kontrasepsi merupakan komponen penting dalam kesehatan reproduksi perempuan usia subur. Kontrasepsi memungkinkan perempuan mengatur jumlah dan jarak kehamilan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kesiapan sosial.

Berbagai metode kontrasepsi tersedia, mulai dari metode alami, barrier, hormonal, hingga alat kontrasepsi jangka panjang. Konseling yang tepat meningkatkan pemilihan metode yang sesuai dan kepatuhan penggunaan. Tinjauan sistematik menunjukkan bahwa intervensi konseling kontrasepsi secara signifikan meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan menurunkan kehamilan tidak direncanakan (Nelson et al., 2022; Harris et al., 2022).

6. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Pemeriksaan kesehatan secara rutin merupakan strategi penting dalam deteksi dini masalah reproduksi. Skrining kanker serviks melalui Pap smear atau IVA terbukti efektif menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks. Pemeriksaan lain seperti deteksi dini kanker payudara, skrining infeksi menular seksual, serta pemeriksaan kadar hemoglobin membantu mengidentifikasi masalah sejak dini. Perempuan yang rutin melakukan skrining memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan penanganan tepat waktu dan mencegah komplikasi (Akokuwebe et al., 2021).

7. Edukasi Kesehatan Reproduksi

Edukasi kesehatan reproduksi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat. Materi edukasi mencakup anatomi dan fisiologi reproduksi, siklus menstruasi, kontrasepsi, infeksi menular seksual, serta hak reproduksi. Program edukasi berbasis komunitas dan pelayanan kesehatan terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi. Edukasi yang efektif juga berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan layanan kesehatan dan penurunan perilaku berisiko (Gelgelo et al., 2023).

8. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Ketersediaan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan reproduksi. Pelayanan harus mencakup konseling, pemeriksaan, pengobatan, serta rujukan yang sesuai kebutuhan. Ketimpangan akses layanan masih menjadi tantangan di banyak

wilayah. Intervensi berbasis sistem kesehatan, termasuk peningkatan fasilitas, pelatihan tenaga kesehatan, serta kebijakan kesehatan yang mendukung, terbukti meningkatkan hasil kesehatan reproduksi perempuan (Sutton et al., 2021).

Upaya menjaga kesehatan reproduksi perempuan usia subur memerlukan keterlibatan aktif individu, keluarga, tenaga kesehatan, serta sistem kesehatan secara keseluruhan. Pendekatan berbasis bukti menunjukkan bahwa kombinasi intervensi promotif dan preventif memberikan dampak paling efektif dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menurunkan risiko masalah kesehatan reproduksi di masa depan.

G. Keluarga Berencana pada Usia Subur

Keluarga berencana merupakan salah satu pilar utama dalam kesehatan reproduksi perempuan usia subur. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pembatasan jumlah anak, tetapi mencakup upaya terencana untuk mengatur waktu, jumlah, dan jarak kelahiran melalui penggunaan metode kontrasepsi yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Pendekatan modern keluarga berencana menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan utama dengan dukungan pasangan dan sistem kesehatan (Cleland et al., 2012).

Perkembangan ilmu kesehatan menunjukkan bahwa keluarga berencana memiliki dampak luas terhadap kesehatan ibu, anak, serta kesejahteraan sosial ekonomi. Analisis global menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi modern berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu dengan mencegah kehamilan berisiko tinggi dan kehamilan yang tidak diinginkan (Ahmed et al., 2012). Program keluarga berencana juga terbukti menurunkan kejadian abortus tidak aman serta meningkatkan kesehatan bayi melalui pengaturan jarak kelahiran yang optimal (Ganatra & Faundes, 2016).

1. Tujuan Keluarga Berencana

Keluarga berencana bertujuan untuk:

- a. Mengatur jumlah dan jarak kelahiran
- b. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan
- c. Menurunkan risiko kehamilan risiko tinggi
- d. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
- e. Mendukung kesejahteraan keluarga secara sosial dan ekonomi

Pendekatan berbasis bukti menunjukkan bahwa jarak kelahiran yang ideal, yaitu minimal 24 bulan, berhubungan dengan penurunan risiko kematian ibu, prematuritas, dan berat badan lahir rendah (Cleland et al., 2012).

2. Metode Kontrasepsi

Metode kontrasepsi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan cara kerja dan durasi efektivitasnya:

a. Metode Alami

Metode ini tidak menggunakan alat atau obat, melainkan berdasarkan pemahaman siklus menstruasi. Contohnya metode kalender, suhu basal tubuh, dan amenore laktasi.

Efektivitas metode alami relatif lebih rendah dibanding metode modern karena sangat bergantung pada ketepatan penggunaan dan keteraturan siklus (Teal & Edelman, 2021).

b. Metode Barrier

Metode ini mencegah pertemuan sperma dan ovum. Kondom merupakan contoh utama yang juga memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual.

Penggunaan kondom secara konsisten terbukti efektif dalam mencegah kehamilan sekaligus menurunkan risiko penularan IMS (Tsui & McDonald-Mosley, 2010).

c. Metode Hormonal

Metode ini bekerja melalui regulasi hormonal untuk mencegah ovulasi atau mengubah kondisi endometrium. Contohnya pil kombinasi, suntik, dan implan. Kontrasepsi hormonal memiliki efektivitas tinggi apabila digunakan secara tepat, dengan tingkat kegagalan yang rendah dalam penggunaan rutin (Teal & Edelman, 2021).

d. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)

Metode ini termasuk kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif. IUD bekerja dengan mencegah fertilisasi dan implantasi.

Tingkat efektivitasnya tinggi dengan durasi penggunaan yang panjang, sehingga menjadi pilihan yang efisien bagi perempuan usia subur (Cleland et al., 2012).

e. Metode Permanen

Metode ini meliputi tubektomi pada perempuan dan vasektomi pada laki-laki. Pilihan ini ditujukan bagi pasangan yang tidak menginginkan kehamilan lagi. Metode permanen memiliki efektivitas sangat tinggi, namun memerlukan pertimbangan matang karena bersifat irreversibel.

3. Manfaat Keluarga Berencana

Manfaat keluarga berencana tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang luas. Penggunaan kontrasepsi modern terbukti dapat:

- a. Menurunkan angka kematian ibu hingga signifikan melalui pencegahan kehamilan berisiko (Ahmed et al., 2012)
- b. Mengurangi kejadian kehamilan tidak diinginkan dan abortus tidak aman
- c. Menurunkan angka kematian bayi melalui pengaturan jarak kelahiran
- d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan
- e. Mendukung stabilitas ekonomi keluarga dan pembangunan nasional (Canning & Schultz, 2012)

Kajian sistematis juga menunjukkan bahwa intervensi keluarga berencana merupakan salah satu strategi kesehatan yang paling cost-effective dalam sistem kesehatan global (Chola et al., 2015).

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana

Meskipun manfaatnya telah terbukti secara ilmiah, pelaksanaan program keluarga berencana masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor seperti kurangnya pengetahuan, mitos tentang kontrasepsi, keterbatasan akses layanan, serta norma budaya dan agama dapat memengaruhi penggunaan kontrasepsi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap kontrasepsi masih menjadi masalah di berbagai negara berkembang (Memon et al., 2024). Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya edukasi, konseling yang komprehensif, serta peningkatan akses layanan untuk mengatasi hambatan tersebut.

5. Implikasi dalam Pelayanan Kesehatan

Pelayanan keluarga berencana harus bersifat berpusat pada perempuan (woman-centered care) dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, preferensi, nilai, dan kebutuhan individu.

Tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat, membantu pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, serta memastikan keberlanjutan penggunaan. Integrasi layanan keluarga berencana dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya terbukti meningkatkan efektivitas program dan kualitas pelayanan.

Keluarga berencana merupakan intervensi kunci dalam kesehatan reproduksi perempuan usia subur yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Pendekatan berbasis bukti menunjukkan bahwa akses universal terhadap kontrasepsi yang aman dan efektif menjadi salah satu strategi paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi mendatang.

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Tenaga kesehatan memiliki posisi strategis dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur melalui pelayanan yang komprehensif,

berkesinambungan, dan berbasis bukti. Peran ini mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Pendekatan modern menekankan *woman-centered care*, yaitu pelayanan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan kondisi individual perempuan (Dayyani et al., 2022). Kontribusi tenaga kesehatan tidak hanya terbatas pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup edukasi, advokasi, serta pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Bukti menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan tenaga kesehatan secara aktif dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi, pelayanan antenatal, dan skrining penyakit reproduksi (Comfort et al., 2019).

1. Edukasi dan Promosi Kesehatan Reproduksi

Tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan edukasi yang akurat dan berbasis bukti mengenai kesehatan reproduksi. Materi edukasi meliputi siklus menstruasi, kontrasepsi, infeksi menular seksual, kesehatan seksual, serta perencanaan kehamilan.

Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku berisiko, serta meningkatkan kesadaran perempuan untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien berkontribusi pada peningkatan kepatuhan serta hasil kesehatan yang lebih baik (Rowe et al., 2002).

2. Pelayanan Prakonsepsi dan Konseling Reproduksi

Pelayanan prakonsepsi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi. Tenaga kesehatan berperan dalam mengidentifikasi faktor risiko sebelum kehamilan, seperti anemia, penyakit kronis, status gizi, serta perilaku berisiko.

Konseling reproduksi membantu perempuan merencanakan kehamilan secara sehat dan sesuai kesiapan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan luaran kehamilan serta menurunkan komplikasi maternal dan neonatal (Goossens et al., 2018; Hussein et al., 2016).

3. Pelayanan Antenatal, Persalinan, dan Pascapersalinan

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter, dan perawat, memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan antenatal yang berkualitas. Pemeriksaan rutin selama kehamilan memungkinkan deteksi dini komplikasi, pemantauan pertumbuhan janin, serta pemberian intervensi yang tepat.

Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih terbukti menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan pascapersalinan juga penting untuk

memastikan pemulihan ibu, keberhasilan menyusui, serta pencegahan komplikasi lanjutan (Metcalf et al., 2013).

4. Pelayanan Keluarga Berencana

Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan konseling, pemilihan metode, serta pelayanan kontrasepsi yang aman dan efektif. Informasi yang diberikan harus objektif, tidak bias, dan sesuai dengan kondisi kesehatan serta preferensi perempuan.

Kualitas konseling sangat memengaruhi keberhasilan penggunaan kontrasepsi. Perempuan yang mendapatkan informasi lengkap cenderung memilih metode yang sesuai dan menggunakan kontrasepsi secara konsisten (Phommachanh et al., 2019).

5. Skrining dan Deteksi Dini Penyakit Reproduksi

Deteksi dini merupakan langkah penting dalam mencegah komplikasi kesehatan reproduksi. Tenaga kesehatan berperan dalam melakukan skrining kanker serviks, kanker payudara, infeksi menular seksual, serta gangguan reproduksi lainnya.

Keterlibatan tenaga kesehatan dalam skrining terbukti meningkatkan cakupan pemeriksaan dan deteksi dini kasus. Studi menunjukkan bahwa faktor tenaga kesehatan, termasuk akses dan kualitas pelayanan, sangat memengaruhi partisipasi perempuan dalam skrining kanker serviks (Osingada et al., 2015).

6. Penanganan Infeksi dan Masalah Reproduksi

Diagnosis dan penanganan infeksi saluran reproduksi serta infeksi menular seksual memerlukan kompetensi tenaga kesehatan. Penanganan yang tepat dapat mencegah komplikasi jangka panjang seperti infertilitas dan kanker.

Tenaga kesehatan juga berperan dalam manajemen gangguan menstruasi, infertilitas, serta penyakit kronis yang memengaruhi sistem reproduksi. Pendekatan berbasis bukti memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan secara aman dan efektif.

7. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender

Kesehatan reproduksi tidak terlepas dari isu kekerasan berbasis gender. Tenaga kesehatan memiliki peran dalam mengidentifikasi, menangani, dan merujuk kasus kekerasan.

Intervensi berbasis layanan kesehatan, termasuk skrining kekerasan dan konseling, terbukti membantu mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan mental perempuan (Lewis et al., 2022).

8. Kolaborasi Interprofesional dan Sistem Kesehatan

Pelayanan kesehatan reproduksi memerlukan kolaborasi antara berbagai tenaga kesehatan, termasuk dokter, bidan, perawat, konselor, dan tenaga

kesehatan masyarakat. Pendekatan tim meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kesinambungan perawatan.

Sistem kesehatan yang mendukung, termasuk kebijakan, pembiayaan, serta distribusi tenaga kesehatan, sangat menentukan keberhasilan pelayanan reproduksi. Bukti menunjukkan bahwa model pelayanan berbasis bidan dapat meningkatkan kualitas perawatan dan kepuasan pasien (Sandall et al., 2010).

Peran tenaga kesehatan dalam kesehatan reproduksi perempuan usia subur bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Pelayanan yang berkualitas, berbasis bukti, serta berorientasi pada kebutuhan perempuan menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Keterlibatan aktif tenaga kesehatan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesehatan keluarga dan masyarakat secara luas.

I. Tantangan Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur di Indonesia

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek medis, sosial, budaya, dan sistem kesehatan. Dinamika pembangunan, perubahan demografi, serta ketimpangan akses layanan kesehatan turut memengaruhi kondisi kesehatan reproduksi perempuan. Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam pelayanan kesehatan, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pencapaian indikator kesehatan reproduksi (Amran et al., 2025).

1. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang cukup tinggi di Indonesia. Praktik ini berkaitan dengan faktor sosial budaya, ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan, anemia, persalinan prematur, serta gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Kajian berbasis data demografi menunjukkan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan peningkatan risiko kesehatan ibu dan bayi, termasuk berat badan lahir rendah dan stunting (Rizkianti & Sari, 2025). Kondisi biologis yang belum matang serta keterbatasan akses informasi menjadi faktor yang memperburuk dampak tersebut.

2. Tingginya Prevalensi Anemia

Anemia masih menjadi masalah utama pada perempuan usia subur di Indonesia. Kondisi ini sering disebabkan oleh kekurangan zat besi, pola makan yang tidak seimbang, serta kehilangan darah saat menstruasi. Anemia pada perempuan usia subur berkontribusi terhadap penurunan produktivitas, gangguan fungsi reproduksi, serta peningkatan risiko komplikasi kehamilan seperti perdarahan dan infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa anemia juga

berkaitan dengan pernikahan dini dan kehamilan pada usia muda (Simbolon et al., 2021).

3. Kehamilan Tidak Direncanakan

Kehamilan yang tidak direncanakan masih terjadi akibat keterbatasan akses kontrasepsi, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, serta faktor sosial budaya. Kondisi ini berisiko meningkatkan angka abortus tidak aman, komplikasi kehamilan, serta dampak psikologis bagi perempuan.

Kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Perempuan yang tidak memiliki akses terhadap layanan keluarga berencana cenderung memiliki risiko kehamilan berulang dengan jarak yang tidak ideal.

4. Rendahnya Cakupan Skrining Kanker Serviks

Kanker serviks masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada perempuan di Indonesia. Infeksi HPV sebagai faktor utama sering tidak terdeteksi sejak dini karena rendahnya partisipasi dalam program skrining. Studi menunjukkan bahwa faktor seperti kurangnya pengetahuan, rasa takut, stigma, serta keterbatasan akses layanan menjadi hambatan dalam pelaksanaan skrining kanker serviks (Amran et al., 2025). Perempuan yang tidak melakukan skrining memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan diagnosis dan penanganan.

5. Rendahnya Literasi Kesehatan Reproduksi

Literasi kesehatan reproduksi yang masih rendah menjadi tantangan penting, terutama pada kelompok remaja dan perempuan muda. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi reproduksi, kontrasepsi, serta pencegahan penyakit menyebabkan perilaku berisiko yang berdampak pada kesehatan reproduksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi yang belum merata berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini, kehamilan remaja, serta infeksi menular seksual (Trianita et al., 2026). Informasi yang tidak akurat atau mitos juga memperburuk kondisi ini.

6. Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan

Distribusi layanan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah terpencil dan kepulauan, menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi. Keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, serta infrastruktur menyebabkan sebagian perempuan tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya cakupan pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta akses terhadap kontrasepsi dan skrining penyakit. Kondisi geografis Indonesia yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata.

7. Faktor Sosial Budaya dan Gender

Norma sosial dan budaya masih memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Keputusan terkait kehamilan, penggunaan kontrasepsi, dan akses layanan kesehatan sering kali tidak sepenuhnya berada di tangan perempuan.

Ketimpangan gender serta praktik diskriminatif dapat membatasi otonomi perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran hak reproduksi, termasuk dalam konteks pernikahan dini, masih terjadi dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental perempuan (Huzaimah et al., 2023).

Tantangan kesehatan reproduksi perempuan usia subur di Indonesia menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Intervensi tidak cukup hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga harus mencakup peningkatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, penguatan kebijakan, serta perbaikan sistem kesehatan. Pendekatan berbasis bukti menjadi landasan penting dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia.

J. Penutup

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur merupakan fondasi utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan perempuan, keberlangsungan generasi, serta kesejahteraan keluarga. Fase usia subur tidak hanya mencerminkan kemampuan biologis untuk bereproduksi, tetapi juga menjadi periode penting dalam pembentukan kualitas kesehatan jangka panjang yang dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, perilaku, sosial, dan lingkungan.

Pemahaman komprehensif mengenai kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa kondisi kesehatan perempuan sebelum, selama, dan setelah masa reproduktif memiliki dampak yang luas terhadap luaran kehamilan, kesehatan bayi, serta risiko penyakit pada generasi berikutnya. Bukti ilmiah menegaskan adanya keterkaitan erat antara kesehatan reproduksi, kesehatan maternal, dan kesehatan perinatal sebagai suatu kesinambungan yang tidak terpisahkan (Bhutta et al., 2010).

Intervensi berbasis bukti seperti pemenuhan kebutuhan kontrasepsi, pelayanan prakonsepsi, skrining penyakit, serta edukasi kesehatan reproduksi terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah kehamilan tidak direncanakan, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan. Investasi pada kesehatan reproduksi juga memberikan manfaat ekonomi melalui

peningkatan produktivitas perempuan dan pengurangan beban biaya kesehatan (Onarheim et al., 2016; Canning & Schultz, 2012).

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang menekankan pentingnya akses terhadap informasi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta kebebasan dalam pengambilan keputusan terkait fungsi reproduksi. Pendekatan ini memperkuat posisi perempuan sebagai subjek utama dalam sistem pelayanan kesehatan dan mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam bidang kesehatan.

Tantangan yang masih dihadapi, seperti pernikahan usia dini, anemia, rendahnya literasi kesehatan, serta ketimpangan akses layanan, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan reproduksi memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Intervensi tidak hanya berfokus pada pelayanan klinis, tetapi juga harus melibatkan aspek pendidikan, kebijakan publik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh.

Pendekatan life course dan continuum of care menjadi landasan penting dalam pengembangan program kesehatan reproduksi, karena memungkinkan intervensi dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum konsepsi hingga masa pascareproduksi. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan maternal dan anak secara signifikan (Dean et al., 2014).

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Upaya yang konsisten, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan akan memberikan dampak luas tidak hanya pada kesehatan individu, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Ahmed, S., Li, Q., Liu, L., & Tsui, A.O. (2012). Maternal deaths averted by contraceptive use: an analysis of 172 countries. *The Lancet*.
- Akokuwebe, M.E., Idemudia, E.S., & Lekulo, A.M. (2021). Determinants of cervical cancer screening uptake among women. *BMC Public Health*.
- Akwara, E., Pinchoff, J., & Abularrage, T. (2023). The urban environment and disparities in sexual and reproductive health outcomes. *Journal of Urban Health*.
- Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, J.V. (2020). Factors influencing sexual and reproductive health of women: a systematic review. *Reproductive Health*.
- Amran, Y., Fasya, T.N., & Salamah, H. (2025). Factors associated with reproductive health service utilization in Indonesia. *Journal of Preventive Medicine and Public*

Health.

- Bhutta, Z.A., Lassi, Z.S., Blanc, A., & Donnay, F. (2010). Linkages among reproductive health, maternal health, and perinatal outcomes. *Seminars in Perinatology*.
- Biglari, A.M., et al. (2024). Social determinants of women's reproductive health: a systematic review.
- Canelón, S.P., & Boland, M.R. (2020). A systematic review of factors affecting women's reproductive health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Canning, D., & Schultz, T.P. (2012). The economic consequences of reproductive health and family planning. *The Lancet*.
- Caserta, D., Mantovani, A., Marci, R., & Fazi, A. (2011). Environment and women's reproductive health. *Human Reproduction Update*.
- Ciebiera, M., et al. (2021). Nutrition in gynecological diseases: current perspectives. *Nutrients*.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. *The Lancet*.
- Comfort, A.B., Juras, R.C., Bradley, S.E.K., et al. (2019). Community health workers and reproductive health service delivery. *Health Policy and Planning*.
- Dayyani, I., Lou, S., & Jepsen, I. (2022). Midwives' provision of health promotion in antenatal care. *Women and Birth*.
- Dean, S.V., Lassi, Z.S., Imam, A.M., & Bhutta, Z.A. (2014). Preconception care: closing the gap in the continuum of care. *Reproductive Health*.
- Feng, C., et al. (2018). Reproductive health in Southeast Asian women: current situation and influencing factors. *Global Health Journal*.
- Ganatra, B., & Faundes, A. (2016). Role of family planning services in reducing maternal mortality. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*.
- Gelgelo, D., Abeya, S.G., & Hailu, D. (2023). Health education interventions to improve contraceptive uptake among women of reproductive age. *Health Services Research and Managerial Epidemiology*.
- Goossens, J., De Roose, M., & Van Hecke, A. (2018). Barriers and facilitators to preconception care. *International Journal of Nursing Studies*.

- Harris, M.L., Feyissa, T.R., Bowden, N.A., et al. (2022). Contraceptive counselling interventions for women: systematic review and meta-analysis. *BMC Medicine*.
- Hsu, L.C., et al. (2020). Female human papillomavirus infection associated with increased risk of infertility. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Huzaimah, A., Abdillah, M., & Laila, N.Q. (2023). Disregarding the reproductive rights of women in child marriage in Indonesia. *Samarah Journal*.
- La Marca, A., & Mastellari, E. (2020). Infertility: Epidemiology and etiology. In *Female Reproductive Dysfunction*. Springer.
- Lassi, Z.S., Dean, S.V., Mallick, D., & Bhutta, Z.A. (2014). Preconception care: delivery strategies and packages for care. *Reproductive Health*.
- Li, T., et al. (2026). Global burden of female infertility attributable to sexually transmitted infections. *BMC Infectious Diseases*.
- Metcalfe, A., Grabowska, K., & Weller, C. (2013). Impact of prenatal care provider on maternal health service use. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Moos, M.K., Dunlop, A.L., Jack, B.W., et al. (2008). Healthier women, healthier reproductive outcomes. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*.
- Mussa, I., et al. (2024). Burden of irregular menstrual cycle among reproductive-age women. *SAGE Open Medicine*.
- Nabhan, A.F., et al. (2022). Women's reproductive span: a systematic scoping review. *Human Reproduction Open*.
- Nelson, H.D., Cantor, A., Jungbauer, R.M., et al. (2022). Effectiveness of contraceptive counseling interventions. *Annals of Internal Medicine*.
- Onarheim, K.H., Iversen, J.H., & Bloom, D.E. (2016). Economic benefits of investing in women's health. *PLOS ONE*.
- Osingada, C.P., Ninsiima, G., Chalo, R.N., & Muliira, J.K. (2015). Determinants of uptake of cervical cancer screening. *Cancer Nursing*.
- Paladine, H.L., Ekanadham, H., & Diaz, D.C. (2021). Health maintenance for women of reproductive age. *American Family Physician*.
- Phommachanh, S., Essink, D.R., & Wright, E.P. (2019). Quality of antenatal counseling. *BMC Health Services Research*.

- Qiao, J., et al. (2021). Women's reproductive, maternal, newborn health in China. *The Lancet*.
- Rizkianti, A., & Sari, D.P. (2025). Child marriage and reproductive health in Indonesia. *Vulnerable Children and Youth Studies*.
- Rocha, R.M., et al. (2019). The role of sexually transmitted infections in infertility. *Reproductive BioMedicine Online*.
- Rowe, R.E., Garcia, J., & Macfarlane, A.J. (2002). Communication in maternity care. *Health Expectations*.
- Sandall, J., Devane, D., Soltani, H., & Hatem, M. (2010). Improving quality in maternity care. *Journal of Midwifery & Women's Health*.
- Sharif, M., et al. (2022). Menstrual irregularities among women of reproductive age. *Cureus*.
- Simbolon, D., Jumiayati, J., & Ningsih, L. (2021). Maternal characteristics and reproductive health problems. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Sommer, M., & Mmari, K. (2015). Structural factors in reproductive health. *American Journal of Public Health*.
- Stanton, A.L., Lobel, M., & Sears, S. (2002). Psychosocial aspects of women's reproductive health. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*.
- Starrs, A.M., et al. (2018). Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all. *The Lancet*.
- Steiner, A.Z., et al. (2017). Biomarkers of ovarian reserve and infertility. *JAMA*.
- Sutton, M.Y., Anachebe, N.F., & Lee, R. (2021). Disparities in reproductive health services. *Obstetrics & Gynecology*.
- Tang, W.Z., et al. (2025). Global burden of gynecological diseases. *BMC Public Health*.
- Teal, S., & Edelman, A. (2021). Contraception selection and effectiveness. *JAMA*.
- Terrinoni, M., et al. (2025). Human papillomavirus across the reproductive lifespan. *Medicina*.
- Trianita, D., Christiana, I., & Hariani, W.F. (2026). Reproductive health education and early marriage prevention.
- Tsui, A.O., & McDonald-Mosley, R. (2010). Family planning and unintended pregnancies. *Epidemiologic Reviews*.

WHO. (2023). Sexual and reproductive health. Geneva: World Health Organization.

WHO. (2025). Guideline for the prevention, diagnosis and treatment of infertility. Geneva: World Health Organization.

Wilson, L.C., & Rademacher, K.H. (2021). Menstrual health and reproductive health linkages. Sexual and Reproductive Health Matters.

Yang, J., et al. (2025). Women's health and fertility in Asia-Pacific. The Lancet Regional Health.

BAB VI

PERIMENOPAUSE DAN MENOPAUSE

A. Pendahuluan

Perimenopause merupakan sebuah periode transisi sebelum fase menopause, sekitar satu tahun sebelum menopause terjadi. Sementara, menopause adalah salah satu titik dalam rangkaian tahapan kehidupan bagi wanita dan menandai berakhirnya masa reproduksi mereka. Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup, jumlah perempuan yang mengalami menopause di seluruh dunia juga meningkat, dengan perkiraan 1,2 miliar pada tahun 2030 (Hill, 1996). Menurut World Health Organization, peningkatan angka harapan hidup perempuan menyebabkan jumlah wanita yang hidup dalam fase pascamenopause terus meningkat, sehingga isu kesehatan terkait menopause menjadi semakin penting dalam perspektif kesehatan masyarakat. Secara global, diperkirakan lebih dari 1 miliar perempuan akan berada pada fase menopause pada tahun 2030, dengan sebagian besar tinggal di negara berkembang. Variasi usia menopause dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, status gizi, kebiasaan merokok, serta kondisi sosial ekonomi (WHO, 2021; North American Menopause Society, 2022).

Setelah menopause, seorang wanita tidak dapat hamil, kecuali dalam kasus sangat langka. Sebagian besar wanita mengalami menopause antara usia 45 dan 55 tahun sebagai bagian alami dari penuaan biologis. Menopause juga dapat menjadi konsekuensi dari prosedur bedah atau medis. Menopause disebabkan oleh hilangnya fungsi folikel ovarium dan penurunan kadar estrogen dalam darah. Transisi menopause dapat bertahap, biasanya dimulai dengan perubahan siklus menstruasi. Perimenopause mengacu pada periode sejak tanda-tanda ini pertama kali diamati dan berakhir satu tahun setelah periode menstruasi terakhir. Perimenopause dapat berlangsung beberapa tahun dan dapat memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial (WHO, 2024).

Di Indonesia, data epidemiologi menunjukkan bahwa usia rata-rata menopause berada pada kisaran 49–51 tahun, meskipun terdapat variasi antar daerah. Peningkatan jumlah perempuan usia lanjut di Indonesia sejalan dengan transisi demografi dan epidemiologi, yang berdampak pada meningkatnya beban penyakit kronis terkait menopause seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, kurangnya kesadaran dan akses terhadap layanan

kesehatan menopause masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi berbasis populasi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan pada fase menopause (Kementerian Kesehatan RI, 2023; WHO, 2021).

B. Definisi Perimenopause, Menopause dan Post Menopause

Perimenopause adalah tahapan kehidupan yang biasanya mendahului menopause. Memahami bagaimana orang memandang dan mengelola perimenopause sangat penting baik untuk membantu perempuan mempersiapkan diri maupun mendukung petugas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun, mendiagnosis perimenopause merupakan tantangan. Awal perimenopause biasanya terjadi pada usia pertengahan hingga akhir empat puluhan, pada usia ketika fungsi reproduksi biasanya telah berakhir. Sangat jarang seorang wanita di usia pertengahan empat puluhan hamil dengan gametnya sendiri, bahkan dengan bantuan medis (Weiss, 2007).

Menurut *British Menopause Society* (2026), menopause adalah masa dalam kehidupan seorang wanita ketika menstruasinya berhenti sebagai akibat dari penurunan dan hilangnya 'fungsi reproduksi ovarium'. Ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Ketika seorang wanita mendekati menopause, lebih sedikit estrogen yang diproduksi sehingga tubuhnya berperilaku berbeda. Proses ini biasanya merupakan proses bertahap yang berlangsung selama beberapa tahun. Estrogen juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan jantung serta fungsi otak selama masa reproduksi.

Menopause biasanya terjadi antara usia 45 dan 55 tahun, tetapi mungkin lebih awal. Ada perbedaan etnis dalam usia onset. Usia rata-rata di Inggris adalah 51 tahun. Menopause didefinisikan sebagai ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama satu tahun atau lebih. Sebelum itu, seorang wanita akan mengalami 'perimenopause awal' dan 'perimenopause akhir' dan sebelum itu, fase 'reproduksi akhir'.

Selama perimenopause awal, wanita mengalami perubahan pola siklus menstruasi. Mereka mungkin mulai mengalami gejala menopause bersamaan dengan perubahan siklus, paling sering sekitar 7 hari dari siklus normal mereka. Selanjutnya, pada akhir perimenopause, banyak wanita mengalami memburuknya gejala menopause mereka. Siklus menstruasi menjadi kurang sering, dengan periode menstruasi kadang-kadang beberapa bulan sekali, yang menyebabkan amenore. Sebelum perimenopause, fase reproduksi akhir dapat melihat perubahan halus dalam siklus dan hormon perangsang folikel (FSH) yang bervariasi. Hal ini tidak

digambarkan sebagai bagian dari transisi menopause, tetapi beberapa individu mungkin menyadari fluktuasi hormonal yang halus.

Usia terjadinya menopause dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, salah satunya adalah faktor genetik. Studi menunjukkan bahwa usia menopause memiliki komponen hereditas yang kuat, di mana perempuan cenderung mengalami menopause pada usia yang mirip dengan ibu atau saudara perempuannya. Variasi genetik tertentu juga berperan dalam menentukan kecepatan penurunan fungsi ovarium. Selain itu, faktor biologis lain seperti cadangan ovarium sejak lahir turut memengaruhi waktu terjadinya menopause (North American Menopause Society, 2022; World Health Organization, 2021).

Status gizi dan gaya hidup juga menjadi determinan penting dalam usia menopause. Perempuan dengan status gizi kurang atau indeks massa tubuh (IMT) rendah cenderung mengalami menopause lebih awal, sedangkan kelebihan berat badan dapat berkaitan dengan menopause yang lebih lambat akibat produksi estrogen dari jaringan adiposa. Kebiasaan merokok diketahui sebagai faktor risiko utama menopause dini karena zat toksik dalam rokok dapat mempercepat deplesi folikel ovarium dan mengganggu produksi hormon estrogen. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur berkontribusi dalam menjaga keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi, meskipun hubungan langsungnya dengan usia menopause masih bervariasi dalam berbagai studi (World Health Organization, 2021; North American Menopause Society, 2022).

Faktor sosial ekonomi juga memiliki peran signifikan dalam menentukan usia menopause dan pengalaman perempuan selama masa transisi tersebut. Perempuan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang memadai, serta informasi kesehatan, sehingga cenderung mengalami menopause pada usia yang lebih optimal dan dengan dampak kesehatan yang lebih terkelola. Sebaliknya, kondisi sosial ekonomi rendah sering dikaitkan dengan stres kronis, pola makan yang kurang berkualitas, serta keterbatasan akses layanan kesehatan, yang dapat mempercepat terjadinya menopause dan meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa menopause tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu dan lingkungan (WHO, 2021; Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Selain faktor genetik dan gaya hidup, paparan lingkungan dan kondisi kesehatan reproduksi juga berkontribusi terhadap variasi usia menopause. Paparan bahan kimia lingkungan seperti endocrine-disrupting chemicals (EDCs) diketahui dapat mengganggu fungsi hormon dan mempercepat penurunan cadangan ovarium. Riwayat kesehatan reproduksi, termasuk usia menarche, paritas, serta

penggunaan kontrasepsi hormonal, juga berperan dalam menentukan waktu menopause. Perempuan dengan menarche lebih awal atau jumlah kehamilan yang lebih banyak cenderung memiliki paparan estrogen yang berbeda sepanjang hidupnya, yang pada akhirnya memengaruhi waktu berhentinya fungsi ovarium (National Institutes of Health, 2020; International Menopause Society, 2021).

Selain itu, faktor psikososial seperti stres kronis dan kondisi lingkungan kerja juga turut memengaruhi usia menopause dan kualitas transisinya. Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium, sehingga berdampak pada regulasi hormon reproduksi. Lingkungan kerja yang tidak mendukung, termasuk beban kerja tinggi dan kurangnya dukungan sosial, dapat memperburuk gejala menopause serta mempercepat penurunan kualitas hidup perempuan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor biologis, lingkungan, dan psikososial sangat diperlukan dalam memahami determinan menopause secara menyeluruh (International Menopause Society, 2021; National Institutes of Health, 2020).

Sementara itu, gejala pascamenopause terutama disebabkan oleh penurunan kadar estrogen yang beredar. Sensasi panas (*hot flashes*), atrofi vulvovaginal, dan disfungsi seksual merupakan akibat dari perubahan kompleks yang terjadi di sekitar menopause. Pada tingkat ovarium, terjadi penipisan folikel ovarium, terutama sel granulosa. Oleh karena itu, ovarium tidak lagi mampu merespons hormon hipofisis. Kadar hormon perangsang folikel (FSH) dan hormon luteinizing (LH) meningkat karena kurangnya inhibisi umpan balik, dan produksi estrogen, progesteron, dan inhibin ovarium berhenti. Namun, produksi androgen terus berlanjut di sel teka ovarium dan kelenjar adrenal yang tersisa, yang kemudian diubah menjadi estrogen melalui aromatisasi perifer.

Etiologi sensasi panas (*hot flashes*) cukup kompleks. Diperkirakan terjadi pengaturan ulang dan penyempitan sistem termoregulasi akibat fluktuasi atau hilangnya produksi estrogen. Sensasi panas juga diduga disebabkan oleh perubahan kadar estrogen dan FSH. Hal ini juga mungkin terkait dengan peningkatan regulasi reseptor 5-hidroksitriptamin (5-HT_{2A}) di hipotalamus sebagai respons terhadap penurunan kadar serotonin. Penurunan ini diduga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen.

Jaringan urogenital sangat sensitif terhadap estrogen, dan kekurangan estrogen menyebabkan atrofi dan pemendekan vagina, prolaps uterus, dan dispareunia. Penurunan kadar estrogen memengaruhi saluran kemih, termasuk kandung kemih dan uretra, dan banyak yang mengalami inkontinensia urin. Tidak seperti gejala vasomotor, atrofi vulvovaginal tidak membaik seiring waktu tanpa pengobatan.

Tidak seperti hot flashes dan atrofi vulvovaginal, etiologi disfungsi seksual tidak berkorelasi dengan perubahan hormonal. Penurunan libido juga dapat disebabkan oleh gejala vasomotor, gangguan tidur, dan perubahan suasana hati pada wanita pascamenopause.

C. Perubahan terkait dengan Menopause

Perimenopause dan menopause ditandai oleh berbagai perubahan fisik yang terutama disebabkan oleh penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Salah satu gejala yang paling umum adalah gejala vasomotor seperti hot flashes dan keringat malam, yang dapat mengganggu kenyamanan serta kualitas tidur. Selain itu, perempuan juga sering mengalami perubahan pada siklus menstruasi selama perimenopause sebelum akhirnya berhenti secara permanen pada menopause. Menurut North American Menopause Society, sekitar 75% perempuan mengalami gejala vasomotor dengan tingkat keparahan yang bervariasi, yang dapat berlangsung selama beberapa tahun (NAMS, 2015).

Perubahan fisik lainnya meliputi peningkatan berat badan dan redistribusi lemak tubuh, terutama di area abdomen. Penurunan estrogen berperan dalam perubahan komposisi tubuh, termasuk penurunan massa otot dan peningkatan lemak visceral yang berisiko terhadap penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, terjadi pula penurunan kepadatan mineral tulang yang meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur pada perempuan pascamenopause. Penelitian oleh Susan R. Davis menunjukkan bahwa perubahan hormonal selama menopause berkontribusi signifikan terhadap perubahan metabolik dan komposisi tubuh yang berdampak pada kesehatan jangka panjang (Davis et al., 2012).

Selain itu, perubahan pada sistem integumen dan urogenital juga sering terjadi, seperti kulit menjadi lebih kering dan tipis, serta rambut mengalami penipisan. Pada sistem urogenital, penurunan estrogen menyebabkan atrofi vagina yang dapat menimbulkan keluhan seperti kekeringan, iritasi, dan nyeri saat berhubungan seksual. Kondisi ini dikenal sebagai genitourinary syndrome of menopause (GSM) dan dapat memengaruhi kualitas hidup perempuan secara signifikan. Studi yang dipublikasikan oleh International Menopause Society menekankan bahwa perubahan fisik ini bersifat progresif dan memerlukan penanganan yang tepat melalui pendekatan medis maupun non-medis untuk mengurangi dampaknya (IMS, 2016).

Perubahan hormonal yang terkait dengan menopause dapat memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial. Gejala yang dialami selama dan setelah transisi menopause sangat bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang

hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Bagi yang lain, gejalanya bisa parah dan memengaruhi aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Beberapa orang dapat mengalami gejala selama beberapa tahun. Gejala yang terkait dengan menopause meliputi:

1. sensasi panas dan keringat malam. Sensasi panas mengacu pada perasaan panas tiba-tiba di wajah, leher, dan dada, sering disertai dengan kulit memerah, keringat, jantung berdebar, dan perasaan tidak nyaman fisik yang akut yang dapat berlangsung beberapa menit;
2. perubahan keteraturan dan aliran siklus menstruasi, yang berujung pada penghentian menstruasi;
3. kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan seksual, dan inkontinensia;
4. kesulitan tidur/insomnia; dan
5. perubahan suasana hati, depresi, dan kecemasan.

Komposisi tubuh dan risiko kardiovaskular juga dapat terpengaruh. Keunggulan wanita dibandingkan pria dalam hal penyakit kardiovaskular secara bertahap menghilang dengan penurunan kadar estrogen yang signifikan setelah menopause. Menopause juga dapat menyebabkan melemahnya struktur penopang panggul, meningkatkan risiko prolaps organ panggul. Hilangnya kepadatan tulang saat menopause merupakan faktor penting yang berkontribusi pada tingginya angka osteoporosis dan fraktur.

Terdapat berbagai intervensi non-hormonal dan hormonal yang dapat membantu meringankan gejala menopause. Gejala yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan harus didiskusikan dengan penyedia layanan kesehatan untuk mengidentifikasi pilihan penanganan yang tersedia, dengan mempertimbangkan riwayat medis, nilai-nilai, dan preferensi.

Kehamilan masih mungkin terjadi selama perimenopause. Kontrasepsi dianjurkan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan hingga setelah 12 bulan berturut-turut tanpa menstruasi. Kehamilan setelah menopause tidak mungkin terjadi tanpa perawatan kesuburan yang melibatkan penggunaan sel telur donor atau embrio yang sebelumnya dibekukan.

Selama perimenopause dan setelah menopause, masih mungkin untuk tertular infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV, melalui kontak seksual tanpa perlindungan, termasuk seks oral, anal, dan vaginal. Penipisan dinding vagina setelah menopause meningkatkan kemungkinan terjadinya lesi dan robekan, sehingga meningkatkan risiko penularan HIV selama hubungan seks vaginal.

Banyak penelitian mengaitkan antara menopause dan kesehatan tulang. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan untuk mengendalikan dan menghindari fraktur kerapuhan osteoporosis meningkat. Hilangnya kepadatan tulang dan

kerusakan jaringan mikro tulang merupakan gejala gangguan yang berhubungan dengan kerangka tubuh yang disebut osteoporosis. Osteoporosis, yang berarti "tulang berpori", membuat tulang lebih rapuh dan rentan terhadap fraktur. Pengobatannya telah mengalami banyak kemajuan dalam 50 tahun terakhir, yang dulunya dianggap sebagai efek samping penuaan yang tak terhindarkan.

Osteoporosis pascamenopause berkaitan dengan kekurangan estrogen dan kurangnya produksi sel telur oleh ovarium yang terjadi seiring bertambahnya usia. Setelah bertahun-tahun penelitian, peran estrogen kini telah mapan dalam pembentukan ulang tulang. Estrogen berkontribusi pada resorpsi dan penguatan tulang. Estrogen mendeteksi kepadatan tulang yang lebih rendah di lokasi tertentu dan membantu memperkuat tulang di lokasi tersebut. Pilihan pengobatan didasarkan pada tingkat keparahan, laju perkembangan, dan karakteristik spesifik pasien. Dengan mengadopsi pendekatan siklus hidup, semua wanita harus diedukasi tentang penyakit ini dan diinspirasi untuk mengadopsi gaya hidup sehat yang mencakup olahraga teratur dan diet seimbang. Semua wanita pramenopause harus disarankan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D dan kalsium terlepas dari apakah mereka memiliki kelainan tulang atau tidak. Merokok dan konsumsi alkohol juga harus dibatasi. Intervensi farmakologis dilakukan pada pasien yang didiagnosis menderita penyakit ini. Obat-obatan harus dipilih berdasarkan efek samping dan kontraindikasinya (Charde et al, 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan adanya potensi hubungan antara menopause dan peningkatan risiko terkena penyakit Alzheimer (AD), yang menggarisbawahi peran penting penurunan kadar estrogen dalam perkembangan AD. Estrogen memainkan peran penting dalam metabolisme otak, memengaruhi metabolisme energi, plastisitas sinaptik, dan fungsi kognitif. Manfaat kognitif yang terkait dengan terapi penggantian hormon (HRT) diyakini terkait dengan efek neuroprotektif estrogen, baik melalui aksi langsung pada otak atau secara tidak langsung dengan meningkatkan kesehatan kardiovaskular (Silva et al, 2024).

D. Menopasue dan Kualitas Hidup di Masa Mendatang

Menopause dikaitkan dengan peningkatan prevalensi obesitas, sindrom metabolik, penyakit kardiovaskular, dan osteoporosis. Penyakit-penyakit ini dan nilai laboratorium yang tidak menguntungkan, yang merupakan ciri khas periode ini pada wanita, dapat diperbaiki secara signifikan dengan menghilangkan dan mengurangi faktor risiko diet. Perubahan kebiasaan makan selama perimenopause paling efektif dicapai melalui konseling dan intervensi nutrisi. Untuk mengurangi faktor risiko semua penyakit ini, dan dalam kasus penyakit yang sudah ada, terapi diet yang dipimpin oleh ahli gizi harus menjadi bagian integral dari pengobatan.

Tinjauan berikut merangkum rekomendasi untuk diet seimbang dan asupan cairan, pencegahan penyakit kardiovaskular melalui diet, peran tidur, dan nutrisi pencegahan utama pada menopause, seperti vitamin D, kalsium, vitamin C, vitamin B, dan asupan protein. Singkatnya, selama periode perimenopause dan menopause, banyak faktor gaya hidup dapat mengurangi risiko pengembangan semua penyakit (penyakit kardiovaskular, resistensi insulin, diabetes melitus tipe 2, osteoporosis, dan tumor) dan gejala yang menjadi ciri khas periode ini (Erdélyi, 2023).

Menopause berhubungan dengan perubahan baik secara jumlah maupun struktur pada jaringan adiposa, seperti meningkatnya penumpukan lemak di area abdomen, serta perubahan profil lipid dan munculnya resistensi insulin. Transisi menuju menopause juga ditandai oleh pergeseran keseimbangan hormon dari dominasi estrogen menjadi lebih androgenik, yang disebabkan oleh meningkatnya kadar testosteron bioavailabel. Meskipun kadar estrogen menurun, ovarium masih memproduksi androgen dalam jumlah cukup besar selama beberapa tahun setelah menopause, dan peningkatan gonadotropin turut merangsang sekresi androgen tersebut.

Selain itu, penurunan kadar globulin pengikat hormon seks menyebabkan peningkatan androgen bebas, sehingga memperparah ketidakseimbangan antara estrogen dan androgen. Kondisi ini dapat memicu akumulasi lemak, terutama pada jaringan lemak visceral. Jaringan ini menjadi lebih sensitif terhadap androgen karena berkurangnya pengaruh regulasi estrogen, serta meningkatnya jumlah reseptor androgen. Bahkan, perubahan kadar androgen bioavailabel diketahui dapat memprediksi peningkatan lemak visceral dalam jangka waktu beberapa tahun.

Risiko obesitas juga cenderung lebih tinggi pada wanita pascamenopause, terutama pada mereka yang mengalami peningkatan testosteron bioavailabel secara cepat. Sebaliknya, peningkatan yang lebih lambat berkaitan dengan akumulasi lemak yang lebih rendah. Di sisi lain, peningkatan hormon perangsang folikel (FSH) juga berperan, karena reseptornya terdapat pada adiposit visceral. Aktivasi reseptor ini dapat meningkatkan pembentukan lemak dan kadar leptin, serta menurunkan adiponektin, yang pada akhirnya mempercepat penumpukan lemak (Jeong, 2022).

Kualitas hidup pada perempuan menopause sangat dipengaruhi oleh tingkat keparahan gejala yang dialami. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan gejala vasomotor yang berat dan gangguan tidur cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan yang mengalami gejala ringan atau tanpa gejala (Avis et al., 2005). Selain itu, faktor psikososial seperti dukungan sosial, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan juga berperan dalam menentukan bagaimana perempuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi selama menopause. Studi

oleh Nancy E. Avis menegaskan bahwa pengalaman menopause bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh persepsi individu serta lingkungan sosialnya (Avis et al., 2005).

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause dapat dilakukan melalui pendekatan multidimensional, termasuk terapi hormonal, intervensi gaya hidup sehat, dan dukungan psikologis. Aktivitas fisik teratur, pola makan seimbang, serta manajemen stres terbukti dapat membantu mengurangi gejala menopause dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, konseling dan edukasi kesehatan juga penting untuk membantu perempuan memahami perubahan yang terjadi dan mengembangkan strategi koping yang efektif. Menurut penelitian oleh North American Menopause Society, pendekatan komprehensif yang menggabungkan terapi medis dan non-medis memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan selama masa menopause (NAMS, 2015).

Selain faktor fisik dan psikologis, kualitas hidup perempuan menopause juga dipengaruhi oleh perubahan fungsi seksual dan kesehatan urogenital. Penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan kekeringan vagina, dispareunia, dan penurunan libido yang berdampak pada hubungan interpersonal dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh Margery L. Gass menunjukkan bahwa gangguan fungsi seksual pada masa menopause berkorelasi signifikan dengan penurunan kualitas hidup, terutama pada domain emosional dan sosial (Gass et al., 2011). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani perempuan menopause, tidak hanya berfokus pada gejala fisik tetapi juga aspek relasional dan psikoseksual.

Selain itu, faktor budaya dan persepsi individu terhadap menopause turut memengaruhi kualitas hidup perempuan. Dalam beberapa budaya, menopause dianggap sebagai proses alami yang positif karena menandai berakhirnya masa reproduksi, sementara di budaya lain justru dikaitkan dengan penuaan dan penurunan peran sosial. Penelitian oleh Sonia M. Hunter menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki persepsi positif terhadap menopause cenderung melaporkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memandangnya secara negatif (Hunter & Rendall, 2007). Oleh karena itu, intervensi berbasis edukasi dan peningkatan persepsi positif sangat penting dalam membantu perempuan menjalani masa menopause dengan lebih baik.

E. Manajemen dan Penatalaksanaan dalam Menopause

Menopause dikaitkan dengan peningkatan prevalensi obesitas, sindrom metabolik, penyakit kardiovaskular, dan osteoporosis. Penyakit-penyakit ini dan nilai laboratorium yang tidak menguntungkan, yang merupakan ciri khas periode ini pada wanita, dapat diperbaiki secara signifikan dengan menghilangkan dan mengurangi faktor risiko diet. Perubahan kebiasaan makan selama perimenopause paling efektif dicapai melalui konseling dan intervensi nutrisi. Untuk mengurangi faktor risiko semua penyakit ini, dan dalam kasus penyakit yang sudah ada, terapi diet yang dipimpin oleh ahli gizi harus menjadi bagian integral dari pengobatan. Tinjauan berikut merangkum rekomendasi untuk diet seimbang dan asupan cairan, pencegahan penyakit kardiovaskular melalui diet, peran tidur, dan nutrisi pencegahan utama pada menopause, seperti vitamin D, kalsium, vitamin C, vitamin B, dan asupan protein. Singkatnya, selama periode perimenopause dan menopause, banyak faktor gaya hidup dapat mengurangi risiko pengembangan semua penyakit (penyakit kardiovaskular, resistensi insulin, diabetes melitus tipe 2, osteoporosis, dan tumor) dan gejala yang menjadi ciri khas periode ini (Erdélyi, 2023).

Manajemen menopause bertujuan untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Terapi hormonal atau *hormone replacement therapy* (HRT) merupakan intervensi yang paling efektif dalam mengatasi gejala vasomotor seperti hot flashes dan keringat malam. HRT bekerja dengan menggantikan hormon estrogen yang menurun selama menopause, sehingga dapat memperbaiki gejala serta mencegah kehilangan massa tulang. Namun, penggunaan HRT harus dipertimbangkan secara individual karena adanya potensi risiko seperti penyakit kardiovaskular dan kanker payudara, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, rekomendasi terkini menekankan penggunaan dosis terendah dalam durasi sesingkat mungkin sesuai kebutuhan pasien (Lumsden *et al.*, 2016; Manson *et al.*, 2017).

Selain terapi hormonal, olahraga dan intervensi gaya hidup memiliki peran penting dalam pengelolaan menopause. Aktivitas fisik teratur, seperti latihan aerobik dan latihan kekuatan, terbukti dapat membantu mengurangi gejala vasomotor, meningkatkan kesehatan tulang, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Pola makan seimbang yang kaya kalsium, vitamin D, dan fitoestrogen juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan selama menopause. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menerapkan gaya hidup sehat cenderung memiliki gejala menopause yang lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang memiliki gaya hidup sedentari (Daley *et al.*, 2015; Menopause, 2018).

Pendekatan psikososial melalui konseling juga merupakan komponen penting dalam penatalaksanaan menopause. Konseling dapat membantu perempuan memahami perubahan yang terjadi, mengelola stres, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi fase kehidupan ini. Intervensi seperti terapi kognitif-perilaku (*cognitive behavioral therapy*) terbukti efektif dalam mengurangi gangguan tidur, kecemasan, dan depresi yang sering menyertai menopause. Dukungan sosial dari keluarga dan tenaga kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis perempuan selama masa transisi ini. Dengan demikian, pendekatan multidisiplin yang mencakup terapi medis, gaya hidup sehat, dan dukungan psikologis sangat dianjurkan dalam manajemen menopause (Ayers *et al.*, 2012; Manson *et al.*, 2017).

F. Menopause, Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Menopause merupakan fase kehidupan perempuan yang tidak hanya berdampak pada aspek biologis dan kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kondisi ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga. Pada masa menopause, perubahan hormonal sering kali disertai dengan penurunan produktivitas kerja akibat gejala seperti kelelahan, gangguan tidur, dan perubahan suasana hati. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan perempuan dalam mempertahankan pendapatan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Menurut Food and Agriculture Organization, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga akses ekonomi yang dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar (FAO, 2011). Dengan demikian, menopause dapat secara tidak langsung memengaruhi ketahanan pangan melalui penurunan kapasitas ekonomi perempuan.

Selain itu, perempuan menopause sering menghadapi peningkatan kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan tulang, metabolisme, dan mencegah penyakit kronis seperti osteoporosis dan penyakit kardiovaskular. Kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, termasuk sumber kalsium, vitamin D, dan protein, dapat menjadi tantangan tersendiri apabila kondisi ekonomi terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga dengan akses ekonomi rendah cenderung memiliki kualitas diet yang lebih buruk, yang berdampak pada kesehatan perempuan usia lanjut (Darmon & Drewnowski, 2008). Kondisi ini memperburuk risiko malnutrisi pada perempuan menopause, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan beban kesehatan jangka panjang.

Dari perspektif ketahanan pangan, perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan pangan rumah tangga, termasuk dalam pemilihan, pengolahan, dan

distribusi makanan bagi anggota keluarga. Ketika perempuan memasuki masa menopause dan mengalami penurunan kesehatan atau keterbatasan ekonomi, peran ini dapat terganggu. Studi oleh World Food Programme menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan keluarga, karena perempuan cenderung mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan gizi dan kesehatan keluarga (WFP, 2020). Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan kesejahteraan ekonomi perempuan menopause menjadi penting tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas pangan rumah tangga.

Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan pada perempuan menopause perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sektor, seperti edukasi gizi, peningkatan akses terhadap pangan sehat yang terjangkau, serta pemberdayaan ekonomi melalui program sosial dan pelatihan keterampilan. Intervensi berbasis komunitas yang mendukung perempuan usia lanjut dalam mempertahankan kemandirian ekonomi juga dapat membantu mengurangi risiko kerawanan pangan. Selain itu, kebijakan publik yang sensitif gender dan usia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan menopause tetap memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan pangan yang memadai. Dengan pendekatan yang komprehensif, dampak menopause terhadap ekonomi dan ketahanan pangan dapat diminimalkan, sehingga perempuan dapat menjalani masa transisi ini dengan lebih sehat dan sejahtera.

Menurut FP Analytics (2025), Perempuan menopause menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, dengan hilangnya hari kerja, pensiun dini, dan penurunan pendapatan yang memengaruhi produktivitas di berbagai perekonomian. Menopause memiliki dampak ekonomi yang signifikan, dengan biaya global mencapai miliaran dolar setiap tahunnya akibat hilangnya produktivitas, ketidakhadiran, dan keluarnya perempuan dari dunia kerja sebelum waktunya. Di AS saja, gejala-gejalanya menyebabkan kerugian waktu kerja sekitar \$1,8 miliar setiap tahunnya, meningkat menjadi \$26 miliar jika termasuk biaya medis, dan banyak perempuan merasa tidak mendapat dukungan di tempat kerja.

Survei nasional oleh AARP mengungkapkan bahwa 90% wanita berusia 35 tahun ke atas mengalami satu atau lebih gejala menopause — bahkan, rata-rata lima gejala berbeda, seperti sensasi panas, keringat malam, dan perubahan suasana hati. Dengan hampir 50 juta wanita dalam angkatan kerja AS di kelompok usia tersebut dan gejala yang sering berlangsung hingga satu dekade atau lebih, menopause dapat memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi pengusaha dan pekerja wanita, dan pada akhirnya, bagi perekonomian AS. Mayo Clinic memperkirakan biaya kerugian produktivitas pekerja akibat gejala menopause sekitar \$1,8 miliar dan biaya perawatan kesehatan terkait mencapai lebih dari \$24 miliar (AARP, 2025).

G. Tantangan Kesehatan dan Keluarga berkaitan dengan menopause

Wanita pascamenopause menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengubah dinamika dan tuntutan dalam keluarga, sehingga mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar dari lingkungan terdekat. Ketika dukungan tersebut tidak terpenuhi, dapat muncul berbagai dampak negatif seperti rasa kesepian, ketidaknyamanan, hingga konflik dalam keluarga. Sebaliknya, dukungan sosial—baik dalam bentuk emosional maupun informasi—mampu meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi stres serta menurunkan gejala fisik dan psikologis yang dialami. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial, semakin rendah tingkat keluhan yang dirasakan selama menopause. Dalam hal ini, suami memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber dukungan utama, terutama melalui pemahaman yang baik terhadap kondisi pasangan. Dukungan emosional dari pasangan terbukti dapat mengurangi depresi dan kecemasan serta memperbaiki hubungan sosial. Selain itu, keterlibatan suami melalui peningkatan pengetahuan tentang menopause, aktivitas bersama seperti olahraga, pemberian dukungan emosional, serta penerapan teknik relaksasi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup perempuan. Oleh karena itu, edukasi bagi perempuan dan pasangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan selama masa menopause (Namazi et al, 2019).

Perempuan perimenopause membutuhkan akses ke layanan kesehatan berkualitas serta komunitas dan sistem yang dapat mendukung mereka. Sayangnya, kesadaran dan akses terhadap informasi dan layanan terkait menopause masih menjadi tantangan signifikan di sebagian besar negara. Menopause seringkali tidak dibahas dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, atau lingkungan perawatan kesehatan.

Perempuan mungkin tidak mengetahui bahwa gejala yang mereka alami berkaitan dengan menopause, atau bahwa ada pilihan konseling dan pengobatan yang dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan. Mereka yang mengalami gejala menopause mungkin merasa malu atau kurang percaya diri untuk menarik perhatian pada pengalaman mereka dan meminta dukungan.

Penyedia layanan kesehatan mungkin tidak terlatih untuk mengenali gejala perimenopause dan pascamenopause serta memberikan konseling kepada pasien tentang pilihan pengobatan dan menjaga kesehatan setelah transisi menopause. Menopause saat ini hanya mendapat perhatian terbatas dalam kurikulum pelatihan bagi banyak pekerja kesehatan.

Kesejahteraan seksual perempuan menopause diabaikan di banyak negara. Ini berarti bahwa efek ginekologis umum dari menopause, termasuk kekeringan vagina dan nyeri saat berhubungan seksual, mungkin tidak ditangani. Demikian pula,

perempuan yang lebih tua mungkin tidak menganggap diri mereka berisiko terkena infeksi menular seksual, termasuk HIV (3), atau mungkin tidak diberi konseling oleh penyedia layanan kesehatan mereka untuk melakukan hubungan seks yang lebih aman atau melakukan tes.

Banyak pemerintah tidak memiliki kebijakan kesehatan dan pendanaan untuk memasukkan layanan diagnosis, konseling, dan pengobatan terkait menopause sebagai bagian dari layanan rutin yang tersedia. Layanan terkait menopause merupakan tantangan khusus di lingkungan di mana seringkali terdapat prioritas mendesak dan bersaing lainnya untuk pendanaan kesehatan.

H. Menopause dan Kesehatan Mental

Menopause merupakan fase transisi biologis yang tidak hanya ditandai oleh perubahan fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesehatan mental perempuan. Penurunan kadar hormon estrogen selama menopause berperan penting dalam memengaruhi fungsi neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin, yang berhubungan dengan regulasi suasana hati. Perubahan hormonal ini sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan psikologis, termasuk depresi, kecemasan, dan perubahan mood yang fluktuatif. Studi menunjukkan bahwa perempuan pada fase perimenopause memiliki risiko lebih tinggi mengalami gejala depresi dibandingkan dengan fase premenopause, terutama pada individu dengan riwayat gangguan mental sebelumnya (Freeman *et al.*, 2014; Soares, 2017).

Menopause telah dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap gejala psikotik, terutama pada wanita dengan kerentanan yang sudah ada sebelumnya seperti gangguan bipolar atau skizofrenia. Menopause, yang meliputi perimenopause dan pascamenopause, adalah fase transformatif yang ditandai oleh perubahan hormonal yang dapat memicu atau memperburuk tantangan kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan, dalam kasus yang parah, pikiran untuk bunuh diri. Penelitian menyoroti bahwa meskipun tidak semua wanita mengalami gangguan kejiwaan, transisi menopause memperkuat kerentanan pada individu yang rentan.

Interaksi antara fluktuasi hormonal dan kesehatan mental bersifat kompleks dan dua arah. Estrogen, yang menurun tajam selama menopause, memberikan efek neuromodulator pada otak, memengaruhi jalur serotonin, dopamin, dan asam gamma-aminobutirat (GABA), neurotransmitter yang penting untuk pengaturan suasana hati. Progesteron, demikian pula, memiliki sifat anxiolitik melalui metabolitnya, allopregnanolon, yang meningkatkan aktivitas reseptor GABA. Periode perimenopause adalah periode di mana banyak wanita melaporkan timbulnya atau memburuknya gejala kejiwaan (Garg, 2025).

Selain faktor biologis, gejala fisik menopause seperti hot flashes, gangguan tidur, dan kelelahan juga berkontribusi terhadap penurunan kesehatan mental. Gangguan tidur yang sering terjadi akibat gejala vasomotor dapat memperburuk kondisi psikologis, meningkatkan iritabilitas, serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara gangguan tidur dan depresi pada perempuan menopause, di mana keduanya saling memperburuk kondisi satu sama lain. Oleh karena itu, penanganan gejala fisik secara efektif dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental (Baker *et al.*, 2018; Menopause, 2015).

Faktor psikososial juga memainkan peran penting dalam menentukan kondisi kesehatan mental selama menopause. Perubahan peran sosial, seperti anak yang mulai mandiri, pensiun, atau perubahan hubungan interpersonal, dapat menjadi sumber stres tambahan bagi perempuan. Selain itu, persepsi negatif terhadap menopause dan kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kondisi emosional. Sebaliknya, perempuan yang memiliki dukungan keluarga yang baik dan pemahaman yang positif terhadap menopause cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman menopause sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana perempuan tersebut berada (Avis *et al.*, 2015; Soares, 2017).

Pendekatan penatalaksanaan kesehatan mental pada menopause perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi intervensi farmakologis dan non-farmakologis. Terapi hormonal dapat membantu mengurangi gejala depresi ringan hingga sedang yang berkaitan dengan perubahan hormon, meskipun penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi individu. Selain itu, intervensi psikologis seperti *cognitive behavioral therapy* (CBT) terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan, depresi, serta gangguan tidur pada perempuan menopause. Aktivitas fisik dan gaya hidup sehat juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mental melalui peningkatan endorfin dan perbaikan kualitas tidur. Dengan demikian, pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial sangat penting dalam mendukung kesehatan mental perempuan selama menopause (Ayers *et al.*, 2012; Maki *et al.*, 2019).

I. Penutup

Sebagai penutup, menopause merupakan fase alami dalam siklus kehidupan perempuan yang membawa berbagai perubahan multidimensional, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kompleksitas perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa menopause tidak dapat dipandang semata sebagai proses biologis, melainkan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor

individu, lingkungan, dan sistem kesehatan. Dampaknya terhadap kualitas hidup, kesehatan mental, produktivitas, hingga ketahanan pangan menegaskan pentingnya perhatian yang lebih komprehensif terhadap perempuan pada fase ini, terutama di tengah meningkatnya angka harapan hidup secara global.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, kebijakan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Peningkatan literasi kesehatan, akses terhadap layanan yang responsif gender dan usia, serta dukungan sosial yang memadai menjadi kunci dalam membantu perempuan menjalani masa menopause dengan sehat dan bermartabat. Dengan intervensi yang tepat, menopause tidak hanya dapat dilalui dengan lebih baik, tetapi juga menjadi fase kehidupan yang tetap produktif, berkualitas, dan sejahtera bagi perempuan.

Referensi

- AARP Research (2023) *Menopause in the workplace has an economic impact*. Tersedia di: <https://www.aarp.org/pri/topics/work-finances-retirement/employers-workforce/menopause-workplace>
- Avis, N.E., Crawford, S.L. & McKinlay, S.M., 2005. Psychosocial, behavioral, and health factors related to menopause symptomatology. *Women's Health*, 14(1), pp.1–15.
- Ayers, B., Smith, M. and Hellier, J. (2012) 'Effectiveness of cognitive behavioural interventions in improving menopausal symptoms', *Menopause*, 19(7), pp. 749–759.
- Baker, F.C., de Zambotti, M., Colrain, I.M. and Bei, B. (2018) 'Sleep problems during the menopausal transition: prevalence, impact, and management', *Nature Reviews Endocrinology*, 14(4), pp. 199–215.
- Briceno Silva, G., Arvelaez Pascucci, J., Karim, H., Kaur, G., Olivas Lerma, R., Kaur Mann, A., Gnanasekaran, S., & Thomas Garcia, K. D. (2024). *Influence of the onset of menopause on the risk of developing Alzheimer's disease*. *Cureus*, 16(9), e69124. <https://doi.org/10.7759/cureus.69124>
- British Menopause Society (2026). *BMS Tool for Clinicians: What is the menopause?*. Available at: <https://thebms.org.uk/wp-content/uploads/2026/01/17-NEW-BMS-TfC-What-is-the-menopause-JAN2026-A.pdf>
- Charde, S. H., Joshi, A., & Raut, J. (2023). *A comprehensive review on postmenopausal osteoporosis*. Retrieved May 5, 2026, from <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10711335/>

- Daley, A., Stokes-Lampard, H., MacArthur, C. and Mutrie, N. (2015) 'Exercise for vasomotor menopausal symptoms', *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 1, CD006108.
- Darmon, N. & Drewnowski, A., 2008. Does social class predict diet quality? *The American Journal of Clinical Nutrition*, 87(5), pp.1107–1117.
- Davis, S.R., Castelo-Branco, C., Chedraui, P., Lumsden, M.A., Nappi, R.E., Shah, D. & Villaseca, P., 2012. Understanding weight gain at menopause. *Climacteric*, 15(5), pp.419–429.
- Erdélyi, A., Pálfi, E., Túű, L., Nas, K., Szűcs, Z., Török, M., Jakab, A. and Várbió, S. (2023). *The importance of nutrition in menopause and perimenopause: A review*. *Nutrients*, 16(1), p. 27. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10780928/>
- European Menopause and Andropause Society (EMAS). (2022). *Menopause: Definitions and terms*. <https://emas-online.org/wp-content/uploads/2022/05/Menopause-definitions-and-terms.pdf>
- Food and Agriculture Organization (FAO), 2011. *The State of Food Insecurity in the World*. Rome: FAO.
- FP Analytics (2025). *The health and economic impacts of menopause: Policies and investments to advance care, opportunity, and equity*. Available at: <https://impactsofmenopause.com/>
- Freeman, E.W., Sammel, M.D. and Lin, H. (2014) 'Temporal associations of hot flashes and depression in the transition to menopause', *Menopause*, 21(7), pp. 687–693.
- Garg, R., & Munshi, A. (2025). *Menopause and mental health*. *Journal of Mid-life Health*, 16(2), 119–123. https://doi.org/10.4103/jmh.jmh_61_25
- Gass, M.L.S., Cochrane, B.B., Larson, J.C., Manson, J.E., Barnabei, V.M., Brzyski, R.G. & Ockene, J.K., 2011. Patterns and predictors of sexual activity among women in the menopause transition. *Menopause*, 18(11), pp.1160–1171.
- Hill, K. (1996). *The demography of menopause*. *Maturitas*, 23(2), pp. 113–127. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8735350/>
- Hunter, M.S. & Rendall, M., 2007. Bio-psycho-socio-cultural perspectives on menopause. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 21(2), pp.261–274.
- International Menopause Society (IMS), 2016. Recommendations on women's midlife

- health and menopause hormone therapy. *Climacteric*, 19(2), pp.109–150.
- International Menopause Society (2021) *Global consensus on menopause and women's health*. London: IMS.
- Jeong, H. G., & Park, H. (2022). *Metabolic disorders in menopause*. *Metabolites*, 12(10), 954. <https://doi.org/10.3390/metabo12100954>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Koothirezhi, R. & Ranganathan, S. (2023) *Postmenopausal Syndrome*. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560840/>
- Lumsden, M.A., Davies, M. and Sarri, G. (2016) 'Diagnosis and management of menopause', *BMJ*, 354, i4945.
- Manson, J.E., Chlebowski, R.T., Stefanick, M.L. *et al.* (2017) 'Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases', *JAMA*, 318(10), pp. 927–938.
- Maki, P.M., Kornstein, S.G., Joffe, H. *et al.* (2019) 'Guidelines for the evaluation and treatment of perimenopausal depression', *Menopause*, 26(10), pp. 1069–1085.
- Menopause (2018) 'Nonpharmacologic management of menopause-associated vasomotor symptoms', *Menopause*, 25(9), pp. 1063–1070.
- Menopause (2015) 'Sleep and mood disturbances during menopause', *Menopause*, 22(3), pp. 299–305.
- Namazi, M., Sadeghi, R., & Behboodi Moghadam, Z. (2019). *Social determinants of health in menopause: An integrative review*. *International Journal of Women's Health*, 11, 637–647. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S228594>
- National Institutes of Health (2020) *Menopause and environmental health factors*. Bethesda: NIH.
- North American Menopause Society (NAMS), 2015. The 2015 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 22(7), pp.728–753.
- North American Menopause Society (2022) *Menopause Practice: A Clinician's Guide*. 6th edn. Cleveland: NAMS.
- Soares, C.N. (2017) 'Depression and menopause: current knowledge and clinical

- recommendations', *Menopause*, 24(9), pp. 1089–1096.
- Weiss, G. (2007). *Understanding the perimenopause*. *Women's Health*, 3(4), 387–390.
<https://doi.org/10.2217/17455057.3.4.387>
- World Food Programme (WFP), 2020. *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: WFP.
- World Health Organization (2024). *Menopause*. Available at:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause>
- World Health Organization (2021) *Women ageing and health*. Geneva: WHO. Tersedia di: <https://www.who.int>
- World Health Organization (WHO), 2012. *WHOQOL: Measuring Quality of Life*. Geneva: WHO.

BAB VII

MODEL PELAYANAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan pilar utama dalam pembangunan kesehatan suatu bangsa. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi prioritas global dan nasional. Salah satu strategi kunci yang diakui secara internasional untuk menjawab tantangan ini adalah penerapan model Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *Continuity of Care* (CoC).

Continuity of Care dalam praktik kebidanan bukan sekadar pemberian asuhan medis, melainkan sebuah filosofi pelayanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan (*Woman-Centered Care*). Model ini memastikan bahwa seorang ibu mendapatkan pendampingan yang konsisten, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan keluarga berencana oleh bidan atau tim kecil bidan yang sama.

Secara teoretis dan praktis, pelayanan yang terputus-putus (*fragmented care*) sering kali menjadi celah terjadinya komplikasi yang tidak terdeteksi. Sebaliknya, melalui model berkelanjutan, terjalin hubungan emosional dan kepercayaan (trust) antara bidan dan ibu.

Di Indonesia, implementasi model ini menghadapi dinamika unik, mulai dari tantangan geografis hingga ketersediaan regulasi yang mendukung praktik mandiri maupun kolaboratif. Oleh karena itu, bab ini akan mengupas tuntas mengenai kerangka konseptual, dimensi-dimensi pendukung, serta efektivitas model pelayanan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Pemahaman yang komprehensif mengenai model ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi, pendidik, maupun mahasiswa kebidanan dalam mewujudkan asuhan yang aman, bermutu, dan humanis.

B. Filosofi dan Prinsip Dasar Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan

Filosofi pelayanan kebidanan berkelanjutan berakar pada pandangan bahwa kehamilan dan persalinan adalah proses fisiologis yang normal serta merupakan peristiwa kehidupan yang sangat bermakna bagi seorang perempuan. Pelayanan ini

tidak hanya berfokus pada aspek klinis-medis, tetapi juga menghargai martabat serta otonomi perempuan sebagai subjek utama dalam asuhan (Guilliland & Pairman, 2010).

1. Filosofi Kemitraan (Partnership)

Inti dari filosofi *Continuity of Care* adalah kemitraan antara bidan dan perempuan (*partnership with women*). Kemitraan ini mencakup hubungan yang sejajar, di mana bidan tidak memposisikan diri sebagai otoritas tunggal, melainkan sebagai pendamping yang berbagi pengetahuan. Hubungan ini dibangun di atas fondasi kepercayaan (trust), rasa hormat, dan tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan ibu dan bayi (Hunter dkk., 2017).

2. Asuhan yang Berpusat pada Perempuan (Woman-Centered Care)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan klinis harus melibatkan suara perempuan. Bidan bertugas memberikan informasi yang berbasis bukti (*evidence-based information*) agar perempuan dapat melakukan pilihan sadar (*informed choice*) dan persetujuan tindakan (*informed consent*). Pelayanan berpusat pada perempuan berarti asuhan yang diberikan harus fleksibel, responsif, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu (Leach dkk., 2016).

3. Fokus pada Normalitas dan Pencegahan

Bidan memiliki filosofi untuk mendukung proses fisiologis persalinan dan meminimalkan intervensi medis yang tidak perlu. Dalam model berkelanjutan, bidan menggunakan kemampuan observasi yang tajam untuk membedakan kondisi normal dan risiko. Pendekatan ini mengutamakan upaya promotif dan preventif melalui pemantauan yang konsisten sepanjang siklus reproduksi (Sandall dkk., 2016).

4. Keberlanjutan Relasional (Relational Continuity)

Prinsip dasar CoC adalah konsistensi pemberi asuhan. Keberlanjutan relasional memastikan bahwa perempuan berinteraksi dengan bidan yang sama (atau tim kecil yang sama) sepanjang periode antenatal, intranatal, hingga postnatal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan ibu dan membangun alur komunikasi yang efektif serta personal (Dahlberg & Aune, 2013).

5. Holistik dan Pemberdayaan (Empowerment)

Asuhan berkelanjutan memandang perempuan secara utuh mencakup dimensi fisik, emosional, psikologis, spiritual, dan sosial. Bidan berperan dalam memberdayakan perempuan agar mereka merasa mampu dan percaya diri dalam menghadapi proses persalinan dan mengasuh bayinya. Pemberdayaan ini menjadi modal utama bagi ibu dalam menjalani transisi peran barunya (Kennedy dkk., 2016).

C. Dimensi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan

Pelayanan kebidanan berkelanjutan (*Continuity of Care*) bukanlah sebuah konsep tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kerangka kerja multidimensi yang saling berkaitan untuk menjamin kualitas asuhan. Secara komprehensif, terdapat tiga dimensi utama yang menjadi pilar keberhasilan model ini, yaitu kesinambungan relasional, kesinambungan manajemen, dan kesinambungan informasi. Ketiga dimensi ini bekerja secara simultan untuk memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan pengalaman asuhan yang utuh, tanpa fragmentasi, mulai dari masa kehamilan hingga periode postnatal (Haggerty dkk., 2003).

Dimensi pertama dan yang paling fundamental dalam asuhan kebidanan adalah kesinambungan relasional (*relational continuity*). Dimensi ini menitikberatkan pada kualitas hubungan terapeutik yang konsisten antara bidan dan perempuan dalam jangka panjang. Hubungan ini melampaui sekadar interaksi klinis; ia dibangun di atas fondasi kepercayaan (*trust*), rasa aman, dan pengenalan personal yang mendalam. Ketika seorang perempuan didampingi oleh bidan yang sama di setiap fase reproduksinya, akan tercipta ikatan emosional yang kuat yang mampu menurunkan tingkat kecemasan ibu secara signifikan. Secara klinis, kesinambungan relasional terbukti efektif dalam meminimalkan intervensi medis yang tidak perlu karena bidan memahami betul pola normal dan preferensi dari pasien yang diasuhnya (Sandall dkk., 2016).

Selanjutnya, kesinambungan manajemen (*management continuity*) berperan sebagai jembatan koordinasi antara berbagai level layanan kesehatan. Dalam dimensi ini, fokus utamanya adalah penyelarasan rencana asuhan dan penggunaan protokol klinis yang konsisten, terutama ketika pasien memerlukan rujukan atau kolaborasi interprofesional. Kesinambungan manajemen memastikan bahwa transisi asuhan dari satu tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan lainnya—atau dari fasilitas kesehatan primer ke sekunder—berjalan mulus tanpa adanya instruksi yang bertolak belakang. Hal ini sangat krusial dalam menjaga standar keselamatan pasien serta memastikan bahwa filosofi asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan tetap terjaga meskipun dalam kondisi kegawatdaruratan (Perriman dkk., 2018).

Dimensi terakhir yang tidak kalah penting adalah kesinambungan informasi (*informational continuity*). Informasi merupakan instrumen yang menghubungkan satu titik kontak asuhan ke titik kontak berikutnya. Dimensi ini menjamin bahwa data riwayat kesehatan, riwayat sosial, serta keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh tim kesehatan yang terlibat. Dengan adanya aliran informasi yang lancar, perempuan tidak perlu mengulangi penjelasan mengenai kondisinya secara berulang-ulang setiap kali bertemu dengan tenaga kesehatan berbeda. Hal ini tidak hanya meningkatkan

efisiensi layanan, tetapi juga secara drastis mengurangi risiko kesalahan medis (medical error) akibat hilangnya informasi penting selama proses pemindahan asuhan (Haggerty dkk., 2003).

D. Model Praktik Mandiri dan Kolaboratif

Model praktik dalam pelayanan kebidanan berkelanjutan terbagi menjadi dua pilar utama yang saling melengkapi, yaitu praktik mandiri dan praktik kolaboratif. Kedua model ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan tingkat asuhan yang paling sesuai dengan kebutuhan klinisnya, tanpa mengabaikan filosofi asuhan yang berpusat pada perempuan. Pemahaman yang jelas mengenai batas kewenangan dan mekanisme kerja sama sangat krusial untuk menjamin keselamatan pasien dan legalitas praktik bidan (International Confederation of Midwives, 2017).

Model praktik mandiri merupakan bentuk otonomi profesional bidan dalam memberikan asuhan kepada perempuan dengan kehamilan dan persalinan normal atau risiko rendah. Dalam model ini, bidan berperan sebagai pemberi asuhan utama (*primary care provider*) yang bertanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan klinis, pemantauan, dan evaluasi asuhan sepanjang siklus reproduksi. Praktik mandiri menekankan pada kemampuan bidan untuk mendukung proses fisiologis secara alami dengan intervensi medis yang minimal. Kemandirian ini bukan berarti bidan bekerja dalam isolasi, melainkan bidan memiliki otoritas legal dan kompetensi klinis untuk mengelola asuhan sesuai dengan standar profesi yang berlaku (Fullerton dkk., 2011).

Di sisi lain, model praktik kolaboratif diterapkan ketika ditemukan adanya penyimpangan dari kondisi normal atau adanya risiko tinggi yang memerlukan keterlibatan tenaga kesehatan lain. Kolaborasi interprofesional adalah kemitraan antara bidan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, serta tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan solusi terintegrasi bagi ibu dan bayi. Dalam model ini, bidan tetap mendampingi perempuan sebagai mitra pendukung emosional dan pemberi asuhan dasar, sementara dokter spesialis mengambil peran dalam penanganan medis spesialisik atau kegawatdaruratan. Kolaborasi yang efektif memerlukan komunikasi yang terbuka, rasa saling menghormati antar profesi, serta pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam tim (World Health Organization, 2010).

Integrasi antara praktik mandiri dan kolaboratif dalam kerangka *Continuity of Care* memastikan bahwa transisi asuhan dari kondisi normal ke kondisi rujukan berjalan secara mulus (*seamless*). Keberhasilan model ini sangat bergantung pada sistem rujukan yang terorganisir dan kesepakatan klinis bersama. Dengan demikian,

perempuan tetap merasakan kesinambungan asuhan meskipun membutuhkan intervensi medis tingkat lanjut. Model kolaboratif yang solid terbukti tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan klinis, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan secara keseluruhan karena mereka tetap merasa didampingi oleh bidan yang mereka percayai (Downe dkk., 2010).

E. Implementasi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan pada Masa Kehamilan

Implementasi pelayanan kebidanan berkelanjutan pada masa kehamilan merupakan fase krusial di mana fondasi kepercayaan antara bidan dan perempuan mulai dibangun. Dalam model *Continuity of Care* (CoC), asuhan antenatal tidak lagi dipandang sebagai rangkaian prosedur klinis rutin yang bersifat mekanis, melainkan sebagai proses pendampingan yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Fokus utamanya adalah memfasilitasi pengalaman kehamilan yang positif bagi perempuan melalui pemantauan kesehatan yang konsisten, penyediaan informasi berbasis bukti, serta dukungan psikososial yang memadai (World Health Organization, 2016).

Pada tahap implementasi ini, kunjungan antenatal dirancang sedemikian rupa agar perempuan bertemu dengan bidan yang sama atau tim kecil bidan yang sudah dikenal di setiap sesi pemeriksaan. Hal ini memungkinkan bidan untuk melakukan pengkajian yang jauh lebih mendalam, tidak hanya terbatas pada parameter fisik seperti tekanan darah atau pertumbuhan janin, tetapi juga mencakup kesiapan mental, kondisi sosial, serta harapan perempuan terhadap proses persalinan nantinya. Kontinuitas ini meminimalkan risiko adanya informasi yang terabaikan dan memastikan bahwa setiap perkembangan kondisi ibu dipahami dalam konteks riwayat kesehatannya yang utuh (Sandall dkk., 2016).

Selain fungsi pemantauan klinis, implementasi CoC pada masa kehamilan berperan penting dalam pemberdayaan ibu melalui edukasi kesehatan yang terpersonalisasi. Bidan bertindak sebagai konselor yang membimbing ibu dalam mengenali tanda bahaya kehamilan secara dini, merencanakan persalinan (*birth planning*), hingga mempersiapkan peran orang tua. Dengan adanya hubungan relasional yang stabil, komunikasi menjadi lebih terbuka sehingga ibu merasa lebih nyaman untuk mendiskusikan kekhawatiran atau keluhan yang bersifat sensitif. Model ini secara signifikan meningkatkan kepuasan ibu terhadap layanan kesehatan dan terbukti efektif dalam mendorong perilaku sehat selama kehamilan, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada optimalisasi luaran maternal dan neonatal (McCourt & Rayment, 2018).

F. Implementasi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan pada Masa Nifas dan Menyusui

Masa nifas merupakan fase transisi yang kritis bagi seorang perempuan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Implementasi pelayanan kebidanan berkelanjutan (*Continuity of Care*) pada fase ini bertujuan untuk memastikan pemulihan fisik ibu berjalan optimal, mendukung keberhasilan pemberian ASI, serta memantau kesehatan mental ibu pasca persalinan. Dalam model berkelanjutan, asuhan nifas tidak berhenti saat ibu meninggalkan fasilitas kesehatan, melainkan berlanjut melalui kunjungan rumah atau pemantauan jarak jauh yang dilakukan oleh bidan yang telah mendampingi ibu sejak masa kehamilan (Yonemoto dkk., 2017).

Fokus utama asuhan pada masa nifas dalam kerangka CoC adalah deteksi dini komplikasi pasca persalinan, seperti perdarahan sekunder, infeksi, atau tanda-tanda preeklampsia postpartum. Selain aspek fisik, bidan berperan besar dalam memberikan dukungan emosional untuk mencegah terjadinya postpartum blues hingga depresi pasca persalinan. Keberlanjutan relasi yang telah terbangun sebelumnya membuat bidan lebih mudah mengenali perubahan perilaku atau gangguan emosional pada ibu, karena bidan telah memahami kondisi dasar psikologis pasien tersebut (Perriman dkk., 2018).

Dalam hal menyusui, implementasi asuhan berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap durasi dan eksklusivitas pemberian ASI. Bidan memberikan bimbingan teknis yang konsisten mengenai posisi dan perlekatan menyusui, serta memberikan solusi atas masalah-masalah yang sering muncul seperti puting lecet atau bendungan ASI. Dukungan yang bersifat personal dan berkelanjutan ini membangun kepercayaan diri ibu dalam merawat bayinya. Melalui integrasi asuhan nifas yang berkesinambungan, transisi peran menjadi orang tua dapat dilalui dengan lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ibu dan kualitas hidup bayi baru lahir (Beake dkk., 2010).

G. Implementasi Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan pada Masa Nifas dan Menyusui

Masa nifas merupakan periode transisi yang kritis, di mana ibu mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan secara cepat. Dalam model pelayanan kebidanan berkelanjutan (*Continuity of Care*), asuhan pada masa nifas tidak hanya berfokus pada pemulihan klinis pasca persalinan, tetapi juga pada penguatan ikatan antara ibu dan bayi serta keberhasilan laktasi. Kontinuitas relasi antara bidan dan ibu yang telah terjalin sejak masa kehamilan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan transisi ini (McCourt & Rayment, 2018).

Implementasi asuhan nifas berkelanjutan memastikan adanya pemantauan yang konsisten terhadap involusi uterus, penyembuhan luka perineum atau pasca operatif, dan deteksi dini komplikasi seperti perdarahan postpartum sekunder maupun infeksi. Keunggulan model CoC terletak pada frekuensi dan kualitas kontak antara bidan dan ibu, di mana bidan dapat memberikan asuhan yang lebih responsif sesuai dengan kondisi aktual ibu di lingkungan rumahnya. Kunjungan rumah pasca persalinan yang terintegrasi terbukti secara signifikan menurunkan risiko ibu mengalami gangguan psikologis pasca persalinan, seperti postpartum blues dan depresi, karena adanya dukungan emosional yang berkelanjutan dari sosok tenaga kesehatan yang sudah mereka percayai (Yonemoto dkk., 2017).

Dalam dimensi menyusui, pendampingan berkelanjutan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan angka pemberian ASI Eksklusif. Bidan tidak hanya memberikan edukasi teknis mengenai posisi dan perlekatan yang benar, tetapi juga berperan sebagai motivator saat ibu menghadapi tantangan laktasi seperti bendungan ASI atau persepsi ketidakcukupan ASI. Dengan adanya bidan yang mendampingi secara konsisten, ibu merasa lebih percaya diri (*maternal self-efficacy*) dalam merawat bayinya. Model asuhan ini menjamin bahwa setiap ibu mendapatkan dukungan yang dibutuhkannya untuk melalui masa nifas dengan aman, sehat, dan berdaya (Beake dkk., 2010).

H. Peran Teknologi dalam Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan

Integrasi teknologi dalam model *Continuity of Care* (CoC) telah membawa transformasi signifikan pada cara bidan berkomunikasi, memantau, dan memberikan asuhan kepada perempuan. Teknologi berperan sebagai instrumen pendukung yang memperkuat ketiga dimensi kesinambungan-relasional, informasi, dan manajemen-terutama dalam mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan waktu. Penggunaan teknologi informasi kesehatan tidak bertujuan untuk menggantikan kehadiran fisik bidan, melainkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan efisiensi koordinasi layanan (Higgins dkk., 2019).

Salah satu peran utama teknologi adalah melalui penerapan mHealth (*Mobile Health*) dan *Tele-midwifery*. Aplikasi kesehatan berbasis ponsel memungkinkan ibu untuk memantau perkembangan kehamilan secara mandiri, sementara bidan dapat melakukan pengawasan jarak jauh melalui fitur konsultasi daring. Hal ini sangat krusial dalam mendeteksi tanda bahaya secara real-time di luar jam kunjungan rutin. Selain itu, penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi menjamin adanya kesinambungan informasi. Dengan RME, data klinis ibu dapat diakses dengan cepat oleh anggota tim kesehatan lain saat terjadi rujukan, sehingga

meminimalisir risiko kesalahan medis akibat informasi yang terfragmentasi (Perriman dkk., 2018).

Lebih jauh lagi, teknologi berperan dalam pemberdayaan perempuan melalui penyediaan media edukasi digital yang interaktif dan berbasis bukti. Platform digital memungkinkan bidan untuk mengirimkan pengingat kunjungan, materi persiapan persalinan, hingga dukungan menyusui yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan spesifik ibu. Di daerah dengan tantangan geografis yang besar, teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam sistem rujukan terpadu yang menghubungkan bidan di tingkat primer dengan fasilitas kesehatan rujukan. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai "perekat" yang memastikan asuhan tetap berkesinambungan dan berkualitas, meskipun terdapat jarak fisik antara pemberi dan penerima asuhan (Dalton dkk., 2014).

I. Tantangan dan Strategi Pengembangan Model Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan

Implementasi model pelayanan kebidanan berkelanjutan (Continuity of Care) secara luas di sistem kesehatan sering kali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun personal. Untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan model ini, diperlukan identifikasi tantangan yang jujur serta penyusunan strategi yang adaptif terhadap dinamika pelayanan kesehatan modern.

1. Tantangan dalam Implementasi

Tantangan utama yang sering muncul adalah beban kerja bidan yang tidak seimbang dengan jumlah ketersediaan sumber daya manusia. Dalam model CoC, bidan dituntut untuk selalu tersedia (on-call) bagi pasiennya, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu kelelahan fisik dan mental (*burnout*) serta mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi bidan (Sandall dkk., 2016).

Selain itu, fragmentasi sistem kesehatan dan kebijakan birokrasi di rumah sakit sering kali menjadi penghalang bagi bidan untuk mendampingi pasiennya secara penuh saat rujukan diperlukan. Kurangnya pemahaman antar profesi mengenai otonomi bidan dalam tim kolaborasi juga dapat menghambat efektivitas pelayanan. Dari sisi administratif, sistem pembiayaan kesehatan yang belum sepenuhnya mengakomodasi model asuhan berkelanjutan sering kali membuat praktik ini sulit dipertahankan secara finansial (Homer dkk., 2014).

2. Strategi Pengembangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain:

- a. Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Mendorong adanya regulasi yang mendukung otonomi praktik bidan serta sistem remunerasi yang adil bagi

model asuhan berkelanjutan. Kebijakan ini harus mampu memfasilitasi akses bidan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut saat mendampingi pasiennya.

- b. Model Tim Kecil (*Caseload Midwifery*): Mengembangkan model kerja tim kecil (misalnya tim yang terdiri dari 2–4 bidan) untuk mengasuh sekelompok pasien. Strategi ini efektif untuk menjamin kesinambungan asuhan bagi ibu sekaligus memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental bidan karena adanya sistem pembagian waktu on-call yang lebih teratur.
- c. Integrasi Teknologi Informasi: Memanfaatkan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dan platform tele-midwifery untuk mempermudah koordinasi antar level layanan, sehingga kesinambungan informasi tetap terjaga tanpa menambah beban administrasi manual (Higgins dkk., 2019).
- d. Pendidikan dan Pelatihan Interprofesional: Memasukkan konsep Continuity of Care dan praktik kolaboratif ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan sejak dini untuk membangun budaya saling menghormati antar profesi (World Health Organization, 2010).

Melalui sinergi antara regulasi yang kuat, pengelolaan sumber daya yang bijak, dan pemanfaatan teknologi, model pelayanan kebidanan berkelanjutan dapat bertransformasi dari sekadar konsep teoretis menjadi standar pelayanan yang merata bagi seluruh perempuan.

J. Penutup

Sebagai simpulan, Model Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan (*Continuity of Care*) merupakan paradigma esensial yang mentransformasi praktik kebidanan dari sekadar prosedur klinis menjadi hubungan kemitraan yang bermakna dan berpusat pada perempuan. Melalui integrasi yang kuat antara kesinambungan relasional, manajemen, dan informasi, serta dukungan teknologi dan kolaborasi interprofesional yang solid, model ini terbukti mampu meningkatkan kualitas asuhan serta derajat kesehatan ibu dan anak secara signifikan. Keberhasilan implementasi model ini di masa depan sangat bergantung pada komitmen kolektif para praktisi, pendidik, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih manusiawi, responsif, dan berkesinambungan bagi setiap perempuan.

Referensi

- Beake, S., McCourt, C., & Bick, D. (2010). Women's views of hospital-based postnatal care and the factors mediating their output: A systematic review of qualitative evidence. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Dahlberg, U., & Aune, I. (2013). The woman's birth experience: The effect of interpersonal relationships and continuity of care. *Midwifery*, 29(4), 407-413.
- Dalton, J. A., dkk. (2014). Implementation and evaluation of a computer-based prenatal screening tool. *Midwifery*, 30(3), e107-e112.
- Downe, S., Finlayson, K., & Walsh, D. (2010). 'Self-contained' and 'embedded' models of continuity of care: Midwives' voices. *Midwifery*, 26(1), 101-109.
- Fullerton, J. T., Thompson, J. B., & Severino, R. (2011). The International Confederation of Midwives essential competencies for basic midwifery practice. an update study: 2009–2010. *Midwifery*, 27(4), 399-408.
- Guilliland, K., & Pairman, S. (2010). *Women's Business: The Story of the New Zealand College of Midwives*. NZCOM.
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., Adair, C. E., & McKendry, R. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. *BMJ (Clinical research ed.)*, 327(7425), 1219–1221.
- Higgins, L., dkk. (2019). The role of digital health technologies in the provision of continuity of care in maternity services. *Women and Birth*, 32.
- Homer, C. S. E., dkk. (2014). The projected help of midwife-led continuity of care in Australia: A cost-comparison study. *Midwifery*, 30(6).
- Hunter, B., Berg, M., Dahlberg, H., & Olafsdottir, O. A. (2017). International perspectives on emotional relationships in midwifery: A qualitative study. *Midwifery*, 45, 27-35.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2017). *International Definition of the Midwife*. The Hague: ICM.
- Kennedy, H. P., dkk. (2016). The Renfrew Maryville Framework: A outcomes-based approach to the Midwifery Model of Care. *Journal of Midwifery & Women's Health*.
- Leach, L. S., dkk. (2016). Continuity of care and women's experience of care: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- McCourt, C., & Rayment, J. (2018). Continuity of Care. In: *Midwifery Essentials: Antenatal*. Elsevier Health Sciences.
- Perriman, N., Davis, D. L., & Ferguson, S. (2018). What women value in their continuity of care midwife: A meta-synthesis with implications for perinatal mental health. *Midwifery*, 62, 7–15.
- Sandall, J., dkk. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for stimulating or facilitating pregnancy and childbirth. *Cochrane Database of*

Systematic Reviews.

- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for stimulating or facilitating pregnancy and childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4).
- World Health Organization (WHO). (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2010). Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2018). WHO Guideline: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening. Geneva: WHO.
- Yonemoto, N., Dowswell, T., Nagai, S., & Mori, R. (2017). Schedules for home visits in the early postpartum period. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Perriman, N., Davis, D. L., & Ferguson, S. (2018). What women value in their continuity of care midwife: A meta-synthesis with implications for perinatal mental health. *Midwifery*, 62, 7–15.

PROFIL PENULIS



Bd. Sri Rintani Sikumbang, SST., M.Kes. Lahir di Kota Tengah, Sumatera Utara, 27 Oktober 1985. Berprofesi sebagai dosen Kebidanan di Institut Kesehatan Helvetia sejak tahun 2015 dan sebelumnya di Akademi Kebidanan Helvetia Medan, Pendidikan terakhir lulusan program megister (S2) Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi di STIKes Helvetia Medan tahun 2015, sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan D3 kebidanan tahun 2006 di Akademi Kebidanan Helvetia, D4 Bidan Pendidik tahun 2010 di STIKes Helvetia dan pendidikan profesi bidan di Institut Kesehatan Helvetia. Telah mengikuti berbagai elatihan diantaranya Pengendali Diklat, Penyusunan Kurikulum diklat, TPPK dan aktif sebagai fasilitator Pelatihan Preseptor Mentor dan lainnya. Selain sebagai dosen, penulis juga menjalankan Praktik Mandiri Bidan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sririntani44@gmail.com

Motto: "Bukan nikmat mendatangkan syukur, tai syukur mendatangkan nikmat"



Atika Kurnia Sari, SST., M.Kes) Lahir di Bandar Lampung, 06 Maret 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D IV Bidan Pendidik Di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2008, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat Di Universitas Mitra Bandar Lampung dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sebagai Dosen Tetap di Akbid Gemilang Husada Lampung. Saat ini penulis bekerja di Akbid Wahana Husada Bandar Jaya Lampung, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar dan penyuluhan kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : atikakurnias86@gmail.com

Motto: "Ilmu Yang Dibagikan Akan Menjadi Cahaya Bagi Banyak Kehidupan"



Yarnita, S.ST, M.K.M. Lahir di Lima Puluh Kota, 20 Juni 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dari DIII Kebidanan, STIKes YPAK Padang pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke D IV bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes padang pada tahun 2012, selang beberapa tahun penulis juga melanjutkan Pendidikan ke jenjang S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort De Kock Bukittinggi pada tahun 2016, dan selesai pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 di salah satu klinik di kota padang, sedangkan bekerja sebagai Dosen itu dimulai pada tahun 2014 di STIKes Purna Bhakti Husada Batusangkar. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di kampus STIKes Piala Sakti Pariaman mengampu beberapa mata kuliah seperti: mata kuliah anatomi Fisiologi, Komunikasi Dalam Pratik Kebidanan, komunikasi perubahan perilaku dan konseling gizi, askeb Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar.



Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes. adalah dosen tetap sekaligus Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Kader Bangsa Palembang. Ia merupakan bidan profesional yang menekuni bidang kesehatan reproduksi dan KB serta pelayanan pasca persalinan. Lahir di Sekayu pada 16 Januari 1988, ia menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar magister kesehatan pada tahun 2012, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2022. Ia aktif mengajar mata kuliah KB dan Pelayanan, Asuhan Kebidanan Nifas, serta Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Fokus risetnya mencakup upaya meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Penulis dapat dihubungi melalui email : ermapuspitasari88@gmail.com.



Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes. merupakan dosen tetap dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kader Bangsa Palembang. Penulis adalah bidan profesional yang memiliki kepakaran di bidang kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan komunitas. Lahir di Palembang pada 1 Agustus 1988, Penulis menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar Magister Kesehatan pada tahun 2015, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2023. Dalam aktivitas akademiknya, Penulis mengampu mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi, Asuhan Kebidanan Komunitas, serta Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan. Fokus risetnya mencakup upaya preventif dan promotif kesehatan ibu dan anak, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Kontak korespondensi dapat dilakukan melalui email: ramdhanilist@gmail.com.



Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien. Penulis dilahirkan di Sleman pada tanggal 27 November 1988. Ketertarikan penulis terhadap ilmu gizi dan dietetik dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Studi Gizi dan Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat (FKKMK) UGM. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Gizi dan Kesehatan tahun 2013. Di penghujung 2024, penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Profesi Dietisien di FKKMK UGM. Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Gizi di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu PERSAGI. Sehari-harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah dietetik. Selain itu, penulis juga aktif dalam menulis jurnal, prosiding, serta aktif menulis buku ajar dan *book chapter*. Dosen dalam ajang *National Blog Writing Competition* yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah tahun 2023. Penulis dapat dihubungi di norekanoviani@unisayogya.ac.id



Arista Kusuma Wradani, S.ST., M.Keb) Lahir di Mataram. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wardanikusuma1313@gmail.com

Motto: "Lakukan semua dengan hati"

Sinopsis

Buku referensi Kesehatan Reproduksi Perempuan Sepanjang Daur Kehidupan membahas secara komprehensif berbagai aspek kesehatan reproduksi perempuan pada setiap tahap kehidupan, mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga menopause dan lanjut usia. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang utuh bahwa kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya berkaitan dengan fungsi biologis organ reproduksi, tetapi juga mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, spiritual, serta hak-hak kesehatan reproduksi.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep dasar kesehatan reproduksi perempuan, perubahan fisiologis sepanjang daur kehidupan, kesehatan reproduksi remaja, menstruasi, perencanaan keluarga, kesehatan seksual, kehamilan dan persalinan, perawatan masa nifas, pencegahan infeksi menular seksual, gangguan sistem reproduksi, serta isu kesehatan reproduksi pada masa menopause. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya edukasi, deteksi dini, pemberdayaan perempuan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, bermartabat, serta bebas dari diskriminasi.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa kesehatan, dosen, bidan, perawat, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan perempuan. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memperkuat wawasan dan kompetensi pembaca dalam memahami kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan secara holistik dan berkesinambungan.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melihat kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian penting dari kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, buku referensi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi yang profesional, humanis, responsif, serta berorientasi pada hak, martabat, dan kebutuhan perempuan sepanjang daur kehidupannya.

Buku referensi Kesehatan Reproduksi Perempuan Sepanjang Daur Kehidupan membahas secara komprehensif berbagai aspek kesehatan reproduksi perempuan pada setiap tahap kehidupan, mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga menopause dan lanjut usia. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang utuh bahwa kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya berkaitan dengan fungsi biologis organ reproduksi, tetapi juga mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, spiritual, serta hak-hak kesehatan reproduksi.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep dasar kesehatan reproduksi perempuan, perubahan fisiologis sepanjang daur kehidupan, kesehatan reproduksi remaja, menstruasi, perencanaan keluarga, kesehatan seksual, kehamilan dan persalinan, perawatan masa nifas, pencegahan infeksi menular seksual, gangguan sistem reproduksi, serta isu kesehatan reproduksi pada masa menopause. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya edukasi, deteksi dini, pemberdayaan perempuan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, bermartabat, serta bebas dari diskriminasi.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa kesehatan, dosen, bidan, perawat, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan perempuan. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memperkuat wawasan dan kompetensi pembaca dalam memahami kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan secara holistik dan berkesinambungan.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melihat kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian penting dari kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, buku referensi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi yang profesional, humanis, responsif, serta berorientasi pada hak, martabat, dan kebutuhan perempuan sepanjang daur hidupnya.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-27-5 (PDF)



9

786347

756275